

# APLIKASI MANAJEMEN KEPERAWATAN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Nining Rusmianingsih, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Yenny Sima, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Susi Widiawati, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Arifin Dwi Atmaja, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Nenny Parinusa, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Dherlirona, S.Kep., Ners, M.Kep.  
Feby Manuhutu, S.Kep., Ners, M.Kep.



# **APLIKASI MANAJEMEN KEPERAWATAN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN**

**Nining Rusmianingsih, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Yenny Sima, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Susi Widiawati, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Arifin Dwi Atmaja, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Nenny Parinusa, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Dherlirona, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Feby Manuhutu, S.Kep., Ners, M.Kep.**



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

# **APLIKASI MANAJEMEN KEPERAWATAN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN**

Penulis:

**Nining Rusmianingsih, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Yenny Sima, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Susi Widiawati, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Arifin Dwi Atmaja, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Nenny Parinusa, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Dherlirona, S.Kep., Ners, M.Kep.**

**Feby Manuhutu, S.Kep., Ners, M.Kep.**

Desain Cover:

**Ivan Zumarano**

Tata Letak:

**Achmad Faisal**

ISBN:

**978-623-88564-5-9**

Cetakan Pertama:

**April, 2023**

Hak Cipta 2023

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**Nuansa Fajar Cemerlang**

**Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F**

**Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah**

**Jakarta Barat**

Website: [www.nuansafajarcemerlang.com](http://www.nuansafajarcemerlang.com)

Instagram: [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku ini yang berjudul Aplikasi Manajemen Keperawatan dalam Praktik Keperawatan. Buku ini disusun sebagai acuan dalam aplikasi praktik manajemen keperawatan baik pada area pendidikan keperawatan maupun pelayanan di lahan praktik manajemen keperawatan, khususnya yang terkait dengan Analisis SWOT, Klasifikasi Klien berdasarkan Tingkat Ketergantungan, Jenjang Karir Perawat, Supervisi dalam Keperawatan, Motivasi Kerja Perawat, Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan dan Manajemen Waktu.

Proses penyusunan Buku ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Rizky Al Gibran selaku Direktur PT Nuansa Fajar Cemerlang (Optimal) yang sudah memfasilitasi penulis dalam penyusunan Buku ini.
2. Mas Koko selaku *General Manager* PT Nuansa Fajar Cemerlang (Optimal) yang sudah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Buku ini.
3. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada terhingga kepada penulis selama penyusunan Buku ini.

Semoga semua amal baik mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Buku ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kuningan, Januari 2023

## DAFTAR ISI

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| PRAKATA .....                                             | iii |
| DAFTAR ISI.....                                           | iv  |
| ANALISIS SWOT .....                                       | 1   |
| KLASIFIKASI KLIEN BERDASARKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN..... | 25  |
| JENJANG KARIR PERAWAT .....                               | 35  |
| SUPERVISI DALAM KEPERAWATAN .....                         | 65  |
| MOTIVASI KERJA PERAWAT .....                              | 77  |
| MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN .....                | 93  |
| MANAJEMEN WAKTU.....                                      | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                      | 129 |

# ANALISIS SWOT



## ANALISIS SWOT

### A. Pendahuluan

Paradigma perubahan pelayanan kesehatan bersifat dinamis sesuai dengan perubahan tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan. Perubahan tersebut berdampak terhadap pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan menghasilkan produk asuhan keperawatan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa keperawatan yang pada akhirnya sangat menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap pelayanan asuhan keperawatan.

Kepuasan dan loyalitas pelanggan pengguna jasa keperawatan dapat diperoleh ketika pelayanan asuhan keperawatan yang dirasakan menjadi benar-benar bernilai dan unggul sehingga menjadikan pelanggan sebagai fokus utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Kepuasan pelanggan merupakan modal dasar untuk merebut loyalitas pelanggan sebagai hasil akhir dari proses asuhan keperawatan dan sebagai hasil kinerja perawat. (Mulyadi, 2007).

Kinerja perawat yang diharapkan dapat memberikan kepuasan tidak hanya terhadap pelanggan eksternal tetapi juga terhadap pelanggan internal dimana perawat saling berinteraksi dan berkolaborasi di lingkungan organisasi dan memberikan dampak positif bagi perkembangan personal perawat sebagai pembelajaran organisasi. Oleh sebab itu pengelolaan manajemen pelayanan keperawatan sangat membutuhkan dukungan dan iklim organisasi yang sehat agar mampu memformulasikan setiap kebutuhannya melalui pelaksanaan setiap fungsi-fungsi manajemen.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan manajemen pelayanan keperawatan di unit-unit pelayanan keperawatan menjadi fenomena tersendiri seiring dengan tuntutan perubahan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Kepuasan dan kinerja menjadi tidak optimal yang didukung oleh budaya organisasi, pemberdayaan dalam melaksanakan setiap fungsi – fungsi manajemen dan kesempatan untuk berkembang terkait dengan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. (Tantri Arini, 2018; Sari, D.I.P, 2017; Ernawati, 2010).

Penelitian terdahulu juga diperoleh gambaran tingkat kepuasan, tingkat keamanan dan keselamatan pasien serta perawat sangat berhubungan dengan motivasi kerja, beban kerja, pendokumentasian asuhan keperawatan dan kompleksitas pelayanan serta ketersediaan tenaga perawat, ketersediaan fasilitas pendukung untuk melaksanakan setiap tahapan asuhan keperawatan, kemampuan komunikatif edukatif terapeutik pelayanan yang bersifat holistik, pemberdayaan, kompetensi yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi perawat baik sebagai pemberi asuhan maupun sebagai pengelola unit pelayanan keperawatan, penerapan

model pelayanan keperawatan professional. (Muryani, 2019; Tantri Arini, 2018; Taufik Hidayat, 2009 Lusianah, 2008).

Fenomena penerapan manajemen pelayanan keperawatan tersebut seyogyanya menjadi perhatian khusus walaupun dampak terhadap kepuasan pasien tingkat keamanan dan keselamatan pasien serta perawat atas layanan keperawatan bukan satu-satunya pertimbangan, namun merupakan hal yang penting mengingat kedudukan perawat yang sangat erat dalam berhubungan dengan pasien, yang oleh penulis disebut sebagai *"The Major Caring Profession"* (Steven R. Steiber & William J. Krowinski, 1990).

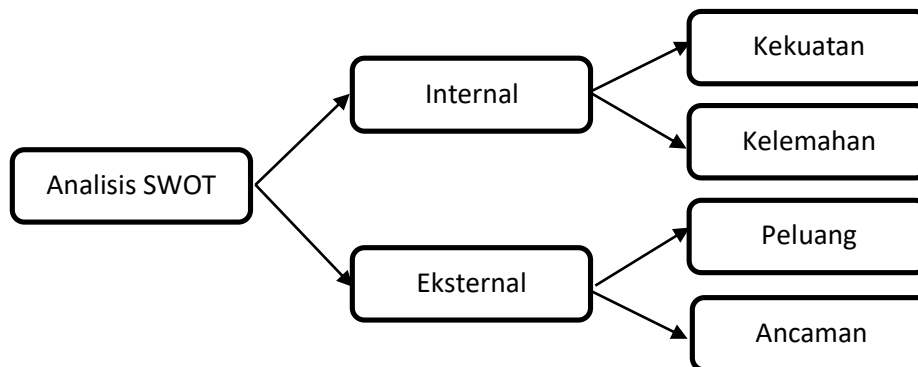
Paradigma pelayanan kesehatan yang terus berubah dan dinamis mendorong terjadinya perubahan manajemen pelayanan asuhan keperawatan kearah yang lebih baik. Olehnya itu sangat dibutuhkan visi bersama dan dukungan organisasi serta budaya kerja yang baik dalam merespon perubahan. Dalam merespon perubahan tersebut dibutuhkan suatu pengenalan lingkungan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal.

## B. Definisi SWOT Analysis

Visi, misi, dan tujuan merupakan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Dibutuhkan suatu pengambilan keputusan, strategi dan kebijakan yang berasal dari suatu analisa secara komprehensif guna pencapaian Visi, misi, tujuan organisasi tersebut.

Analisis situasi atau masalah organisasi dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu analisis internal dan eksternal. Analisis internal atau yang berasal dari dalam organisasi terdiri dari 2 kategori yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dan eksternal atau yang berasal dari luar organisasi juga terdiri dari 2 kategori yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman (*Threat*), sehingga kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*Threat*) disebut sebagai analisis SWOT. (Wardoyo, 2011).

Analisis SWOT tersebut digambarkan seperti di bawah ini :



Gambar 1.1 Analisis SWOT



Beberapa ahli mendefinisikan bahwa analisis SWOT sebagai alat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Philip Kotler et al., 2009) sedangkan (Rangkuti, 2014) mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu alat mengidentifikasi berbagai faktor yang sistematis dan didasarkan pada logika dalam merumuskan strategi perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Robinson dalam (Dewi Kurniasih et al., 2021) menjelaskan bahwa analisis SWOT telah dikenal dan digunakan secara luas sebagai salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis tersebut menghasilkan suatu strategi yang efektif yang meminimalkan kelemahan dan ancaman dan bila diterapkan secara akurat maka akan memberikan dampak keberhasilan yang besar.

### C. Tujuan

Budiman (2018) dalam Wiswasta et al. (2018) menjelaskan tentang penggunaan analisis SWOT bahwa selain menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal serta posisi perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya juga untuk menganalisis sejauh mana kondisi dan posisi lingkungan pribadi kita mampu menghadapi dan menjalankan bisnis. Olehnya itu (Wiswasta et al., 2018) mengatakan bahwa analisis SWOT semakin meningkat penggunaannya terutama di era perdagangan bebas abad ke 21. Dengan demikian berkaitan dengan pengelolaan manajemen pelayanan keperawatan maka analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah di unit-unit pelayanan keperawatan guna mendapatkan Informasi mengenai:

1. Kekuatan dan kelemahan manajemen pelayanan asuhan keperawatan dan seberapa besar peluang dan ancaman yang dihadapi.
2. Mengetahui sejauhmana kemampuan manajemen pelayanan asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan perawat dan pasien. (Kementerian Kesehatan RI, 2011).
3. Mengetahui sejauh mana kondisi atau posisi keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan. (Kementerian Kesehatan RI, 2019).
4. Menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah kekuatan (*strengths*) sebagai kompetensi inti yang dimiliki dapat meminimalisir atau mengatasi kelemahan (*weaknesses*) dan apakah peluang (*opportunities*) yang ada dapat digunakan untuk menghadapi ancaman (*threats*). (Mulyadi, 2007)

### D. Manfaat

Dengan mengetahui kondisi dan posisi lembaga, organisasi atau perusahaan maka juga dapat diperoleh gambaran pengelolaan pelayanan keperawatan saat ini seperti yang telah dijelaskan oleh (Mulyadi, 2007).

Dengan demikian maka hasil analisis SWOT dapat dijadikan sebagai bahan:

1. Rekonfirmasi, redefinisi misi, visi, tujuan keyakinan dasar dan nilai dasar pelayanan keperawatan dan organisasi.
2. Tolok ukur dalam perumusan program kerja yang lebih konkret untuk memperbaiki program sebelumnya sehingga dapat turut mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
3. Perbandingan manajemen pelayanan keperawatan saat ini dengan pesaing utama atau manajemen pelayanan keperawatan ditempat lain.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup analisis SWOT mengacu pada manajemen perencanaan di tingkat unit pelayanan keperawatan yang dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan keperawatan baik pada tingkat manajerial maupun asuhan keperawatan yang berefek pada kepuasan dan keamanan serta keselamatan perawat dan pasien. Diharapkan penggunaan SWOT analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mendukung ataupun tidak mendukung penerapan ataupun pelaksanaan manajemen pelayanan asuhan keperawatan di unit pelayanan keperawatan.

#### **F. Faktor-Faktor SWOT Analysis**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam setiap definisi menurut para ahlinya maka SWOT sesuai dengan akronimnya adalah Kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) sebagai faktor-faktor analisis SWOT.

Freddy Rangkuti (2013) dalam (Kurniasih, 2021) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan suatu analisa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), dan peluang (*oppotunitis*) serta ancaman (*threat*) yang didasarkan pada logika, kemudian analisa tersebut berlanjut pada bagaimana meminimalkan kelemahan serta ancaman dengan memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

Kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), dan peluang (*oppotunitis*) serta ancaman (*threat*) dijelaskan oleh (Wardhana et al., 2021; David, 2011; Mulyadi, 2007) sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*Strenghts*)**

*Strenghts* merupakan situasi atau kondisi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kekuatan dapat bersumber dari keberadaan sumber daya manusia, sarana prasarana, produk andalan, kepercayaan, loyalitas pelanggan, citra positif yang membuat lebih kuat atau lebih unggul dari pesaing dalam

memberikan kepuasan bagi pelanggan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar.

Pertanyaan yang dapat diajukan untuk melihat kekuatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung manajemen pelayanan di unit keperawatan, seperti:

- a. Apa kelebihan yang dimiliki saat ini?
- b. Apa yang membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan aman dibanding ditempat lain?

2. Kelemahan (*Weakness*)

Weakness adalah keterbatasan atau kekurangan dalam penerapan, pelaksanaan, kejelasan arah, cakupan produk keahlian dan kompetensi, jaringan, reputasi. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk melihat kelemahan saat ini seperti:

- a. Apa yang tidak dimiliki tetapi dimiliki oleh pesaing?
- b. Apa yang tidak kita lakukan dan penuhi tetapi dilakukan dan dipenuhi oleh pesaing sehingga mereka menjadi lebih baik?

3. Peluang (*Opportunities*)

Merupakan situasi yang menguntungkan bagi lingkungan organisasi atau perusahaan. Perubahan penting lingkungan eksternal diantaranya adalah perubahan teknologi ataupun peraturan membawa pada kondisi persaingan merupakan suatu peluang atau kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pengguna jasa.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan jika tidak diatasi dan berdampak pada masa sekarang maupun di masa depan. Perubahan teknologi, peraturan dan meningkatnya daya beli masyarakat meningkatkan daya tawar menawar sehingga menimbulkan persaingan yang ketat sehingga menjadi ancaman bagi organisasi atau perusahaan.

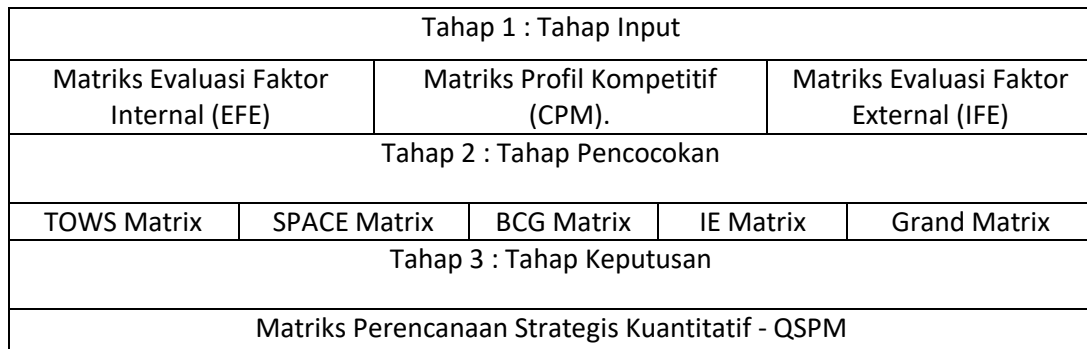
## G. Analisis Situasi

Wardhana et al. (2021), David (2011), dan Mulyadi (2007) menjelaskan bahwa sebagai alat analisis SWOT melalui tiga tahapan yaitu tahap pertama adalah tahap input, tahap kedua adalah tahap pencocokan dan tahap ketiga adalah tahap keputusan (*Decision Stage*).

Tahap 1 : tahap mengumpulkan data dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi dengan membuat matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE), matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), dan matriks Profil Kompetitif (CPM).

Tahap 2 : tahap pencocokan (*matching stage*) pada SWOT yang berfokus pada menciptakan berbagai alternatif yang masuk akal berdasarkan IFE dan EFE. Tahap ini matriks SWOT, matriks posisi dan evaluasi tindakan (*strategic position and action Evaluation – SPACE*), matriks *Boston Consulting Group – BCG*, matriks internal – eksternal – IE dan matriks strategi besar – Grand Strategy Matrix.

Tahap 3 : menggunakan satu Teknik yaitu Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (*Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM*) yang menggunakan informasi dari tahap 1 untuk mengevaluasi berbagai strategi alternative yang diidentifikasi pada tahap 2 sehingga menjadi landasan obyektif dalam memilih strategi alternative. Ketiga tahapan tersebut seperti terlihat pada kerangka analitis dibawah ini :



Gambar 1.2 Kerangka Analitis Perumusan Strategi

#### 1. Tahap 1 : Tahap Input

Tahap input terdiri dari *Evaluasi Faktor Internal (IFE) Matriks*, *Profil Kompetitif (CPM) Matriks* dan *Evaluasi Faktor External (EFE) Matriks*. Pada tahap ini menggunakan pertanyaan berdasarkan *Tools Managemenet* yaitu *man, methode, machine, money, market (5M)*, yang diuraikan sebagai berikut:

##### a. *Evaluasi Faktor Internal (IFE Matriks)*

Merupakan Identifikasi data dasar di Unit pelayanan keperawatan dengan melihat sumber kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan pertanyaan

|                                        | S                                                                                                     | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Man-M1</i><br>(Sumber Daya Manusia) | Pendidikan<br>- DIII 65%<br>- Ners 35%                                                                | Penyebaran kualifikasi Ns tidak merata ke setiap unit                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Method-M2</i><br>(Metode)           | 1. Visi RS menjadi pilihan masyarakat<br>2. Menerapkan MPKP<br>3. Terbentuknya tim Komite Keperawatan | 1. Kurangnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi dan pengembangan pelayanan keperawatan yang mendukung pencapaian visi dan misi<br>2. Pengawasan mutu pelayanan terhambat disebabkan tugas rangkap non keperawatan<br>3. Tidak sinerginya hubungan komunikasi vertical dan horizontal serta program dengan manajerial keperawatan |

|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Machine -M3</i> | 1.Pemanfaatan TT yang mencapai ideal<br>2.Adanya kegiatan non keperawatan (administrasi, pemenuhan sarana pelayanan) | 1.Penambahan jumlah TT tidak sebanding dengan jumlah perawat<br>2.SOP alur koordinasi non keperawatan                                                                                                               |
| <i>Money -M4</i>   | Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah dan jaminan kesehatan masyarakat                                           | 1.Manajer dan perawat pelaksana belum mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pengelolaan unit dan pelayanan asuhan perawatan<br>2.Tim Komite belum mengikuti pelatihan pengelolaan komite |
| <i>M5 – Market</i> | Penambahan jenis pelayanan spesialistik                                                                              | Rendahnya daya saing perawat                                                                                                                                                                                        |

Gambar 1.3. Tahap Input Internal Faktor Evaluation (IFE)

b. *Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matriks)*

|                    | Peluang                                                                                                                                          | Kendala/Ancaman                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Man-M1</i>      | 1. UU Keperawatan<br>2. Jenjang Pendidikan keperawatan ke tingkat yang lebih tinggi                                                              |                                                                                                         |
| <i>Method-M2</i>   | Pelayanan asuhan keperawatan yang terus berkembang                                                                                               |                                                                                                         |
| <i>Material-M3</i> | 1. Peraturan peningkatan mutu keamanan dan keselamatan pasien<br>2. Peraturan standar pelayanan RS<br>3. Peraturan standar pelayanan ruang rawat | Memiliki peralatan spesialistik canggih                                                                 |
| <i>Money -M4</i>   |                                                                                                                                                  | Kesadaran dan daya beli masyarakat terhadap pelayanan kesehatan                                         |
| <i>Market- M5</i>  |                                                                                                                                                  | 1. Kemampuan daya saing professional perawat<br>2. Kepuasan pasien dan masyarakat meningkatkan image RS |

Gambar 1.4. Tahap Input Internal Faktor Evaluation (EFE)

| Kelompok                                                                                                                                               | Bobot (B) | Rating (R) | Skor N=BxR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2         | 3          | 4          |
| <i>IFE</i>                                                                                                                                             |           |            |            |
| <b>Kekuatan (<i>strengths</i>)</b>                                                                                                                     |           |            |            |
| <i>Man – 1</i>                                                                                                                                         |           |            |            |
| - Pendidikan DIII 65% ; Ners 35%                                                                                                                       | 0,1       | 2          | 0,2        |
| <i>Method – M2</i>                                                                                                                                     |           |            |            |
| - Visi RS menjadi pilihan masyarakat                                                                                                                   | 0,1       | 2          | 0,2        |
| - Menerapkan MPKP                                                                                                                                      | 0,1       | 1          | 0,1        |
| - Terbentuknya tim Komite Keperawatan                                                                                                                  | 0,2       | 1          | 0,2        |
| <i>Material - M3</i>                                                                                                                                   |           |            |            |
| - Pemanfaatan TT yang mencapai ideal                                                                                                                   | 0,2       | 2          | 0,4        |
| - Adanya kegiatan non keperawatan (administrasi, pemenuhan sarana pelayanan)                                                                           | 0,2       | 2          | 0,4        |
| <i>Money -M4</i>                                                                                                                                       |           |            |            |
| Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah dan jaminan kesehatan masyarakat                                                                             | 0,05      | 2          | 0,10       |
| <i>Market - M5</i>                                                                                                                                     |           |            |            |
| Penambahan jenis pelayanan spesialistik                                                                                                                | 0,05      | 1          | 0,05       |
| <i>Total</i>                                                                                                                                           | 1,00      |            | 1,65       |
| <b>Kelemahan (<i>weaknesses</i>)</b>                                                                                                                   |           |            |            |
| <i>Man – 1</i>                                                                                                                                         |           |            |            |
| - <b>Penyebaran kualifikasi Ns tidak merata ke setiap unit</b>                                                                                         | 0,11      | -2         | -0,22      |
| - Kontrol pelayanan terhambat disebabkan tugas rangkap non keperawatan                                                                                 | 0,14      | -2         | -0,28      |
| <i>Method – M2</i>                                                                                                                                     |           |            |            |
| - Kurangnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi perawat dan pengembangan pelayanan keperawatan yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi      | 0,12      | -2         | -0,24      |
| - Tidak sinerginya hubungan komunikasi vertikal dan horizontal serta program dengan manajerial keperawatan                                             | 0,14      | -2         | -0,28      |
| <i>Material - M3</i>                                                                                                                                   |           |            |            |
| - SOP alur koordinasi kegiatan non keperawatan                                                                                                         | 0,11      | -2         | -0,22      |
| <i>Money -M4</i>                                                                                                                                       |           |            |            |
| - Manajer dan perawat pelaksana belum mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pengelolaan unit dan pelayanan asuhan perawatan | 0,13      | -3         | -0,39      |
| - Tim Komite belum mengikuti pelatihan pengelolaan komite                                                                                              | 0,13      | -2         | -0,26      |
| <i>Market - M5</i>                                                                                                                                     |           |            |            |
| - Rendahnya daya saing perawat                                                                                                                         | 0,12      | -2         | -0,24      |
|                                                                                                                                                        | 1,00      |            | -2,13      |

Gambar 1.5. Bobot, Rating, dan Score Internal Faktor Evaluation (IFE)

Bobot dan Rating:

1. Buat matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE), matriks Evaluasi Faktor External (EFE), dan matriks Profil Kompetitif (CPM).

Pada Matriks IFE dan EFE:

- a. Variable kekuatan dan peluang beri bobot nilai mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) tetapi pada rating atau peringkat beri skala positif mulai dari +1 s.d +6.
- b. Variable kelemahan dan ancaman beri bobot nilai mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) tetapi pada rating atau peringkat beri skala negatif mulai dari -1 s.d -6.
- c. Total nilai bobot pada matriks IFE dan EFE masing-masing 1.00 atau tidak melebihi 1.00.
- d. Kalikan bobot dengan rating atau peringkat untuk mendapatkan skor.
- e. Jumlahkan skor IFE dan EFE

Pedoman pemberian rating serta arti atau maksud dari masing-masing rating tersebut seperti yang dijelaskan oleh (Wardoyo, 2011), yaitu:

| Kelompok                     | Angka Rating | Arti/Maksud                                         |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Peluang dan Kekuatan</b>  | +1           | <i>Outstanding/Sangat baik</i>                      |
|                              | +2           | <i>Good/Baik</i>                                    |
|                              | +3           | <i>Fair/Cukup</i>                                   |
|                              | +4           | <i>Poor/Buruk</i>                                   |
| <b>Ancaman dan Kelemahan</b> | -1           | <i>Not so good/Agak buruk</i>                       |
|                              | -2           | <i>Fairly Bad/Cukup</i>                             |
|                              | -3           | Mengkhawatirkan                                     |
|                              | -4           | <i>Warning/Hati-hati</i><br><i>Danger/Berbahaya</i> |

| Kelompok                                                      | Bobot (B) | Rating (R) | Skor N=BxR |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <i>1</i>                                                      | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>   |
| <b>EFAS</b>                                                   |           |            |            |
| Peluang ( <i>opportunities</i> )                              |           |            |            |
| - UU Keperawatan                                              | 0,2       | +2         | 0,4        |
| - Jenjang Pendidikan keperawatan ke tingkat yang lebih tinggi | 0,2       | +2         | 0,4        |
| - Pelayanan asuhan keperawatan yang terus berkembang          | 0,2       | +2         | 0,4        |
| - Peraturan peningkatan mutu keamanan dan keselamatan pasien  | 0,1       | +2         | 0,4        |
| - Peraturan standar pelayanan RS                              | 0,1       | +2         | 0,2        |
| - Peraturan standar pelayanan ruang rawat                     | 0,2       | +3         | 0,6        |
| Sub Total                                                     | 1,00      |            | 2,4        |

|                                                                               |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|
| Ancaman ( <i>threats</i> )                                                    |     |    |      |
| - Memiliki alat medis spesialistik canggih                                    | 0,2 | -2 | -0,4 |
| - Ketatnya persaingan RS dengan pelayanan keperawatan terbaik                 | 0,3 | -2 | -0,6 |
| - Kesadaran dan daya beli masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan | 0,2 | -2 | -0,4 |
| - Kepuasan pasien dan masyarakat meningkatkan image RS                        | 0,3 | -2 | -0,6 |
| Total                                                                         | 1,0 |    | -0,2 |

Gambar 1.6. Bobot, Rating dan Score Enternal Faktor Evaluation (EFE)

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$S + W = 1,65 + (-2,13) = -0,48$$

$$O + T = -2,4 + (0,2) = -2,2$$

c. *Profil Kompetitif Matriks (CPM)*

| Faktor Strategis | Bobot | Perusahaan |      | Pesaing 1 |      | Pesaing 2 |      |
|------------------|-------|------------|------|-----------|------|-----------|------|
|                  |       | Rating     | Skor | Rating    | Skor | Rating    | Skor |
|                  |       |            |      |           |      |           |      |
| Total            |       |            |      |           |      |           |      |

Gambar 1.7. Matriks Profil Kompetitif (CPM)

Sebagai pembanding antara kondisi manajemen pelayanan keperawatan di unit saat ini dengan pesaing utama di tempat lain maka tabel dibawah ini dapat digunakan sebagai pembanding, yaitu:

- Rating 1. Bila kondisi manajemen pelayanan asuhan keperawatan sangat lemah dibanding pesaing
- Rating 2. Bila kondisi manajemen pelayanan asuhan keperawatan agak lemah dibanding pesaing
- Rating 3. Bila manajemen pelayanan asuhan keperawatan mempunyai kondisi yang kurang lebih sama dengan pesaing
- Rating 4. Bila perusahaan mempunyai kondisi agak lebih baik dari pesaing
- Rating 5. Bila manajemen pelayanan asuhan keperawatan mempunyai kondisi yang sangat baik dibanding dengan pesaing

Gambaran dari matrik profil kompetitif, posisi kekuatan pengelolaan manajemen pelayanan asuhan keperawatan dapat terbaca, apakah kekuatan yang dimiliki mampu menangkap peluang yang ada dan apakah kelemahan yang dimiliki dapat diminimalisasikan untuk menahan ancaman yang datang dari luar.



2. Tahap 2 : Tahap Mencocokkan atau Penandingan

Menciptakan berbagai alternative strategi yang dapat dipilih berdasarkan informasi pada matriks identifikasi. Tahap pencocokan ini terdiri dari TOWS Matriks, SPACE Matriks, Internal Eksternal dan Grans Strategy.

a. TOWS Matriks

TOWS Matriks dilakukan dengan mengembangkan strategi SO – WO – WT – ST, yaitu :

SO : Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang

WO : Mengatasi keterbatasan denan memanfaatkan peluang

ST : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman

WT : Meminimalkan keterbatasan dan menghindari ancaman

|                                                                                                                                                                                                                        | STRENGHT - S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WEAKNESS - W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | 1. Pendidikan DIII 65% ; Ners 35%<br>2. Visi RS menjadi pilihan masyarakat<br>3. Menerapkan MPKP<br>4. Terbentuknya tim Komite Keperawatan<br>5. Pemanfaatan TT yang mencapai ideal<br>6. Adanya kegiatan non keperawatan /penunjang<br>7. Sumber pembiayaan bersumber dari pemerintah dan jaminan kesehatan masyarakat<br>8. Penambahan jenis pelayanan spesialistik | 1. Penyebaran kualifikasi Ns tidak merata ke setiap unit<br>2. Kontrol pelayanan terhambat disebabkan tugas rangkap non keperawatan<br>3. Kurangnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi perawat dan pengembangan pelayanan keperawatan<br>4. Tidak sinerginya hubungan komunikasi vertikal dan horizontal serta program dengan manajerial keperawatan<br>5. SOP alur koordinasi kegiatan non keperawatan<br>6. Rendahnya kesempatan meningkatkan kompetensi<br>7. Tim Komite belum mengikuti pelatihan pengelolaan komite<br>8. Rendahnya daya saing perawat |
| OPOTUNIES - O                                                                                                                                                                                                          | SO - STRATEGIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WO - STRATEGIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. UU Keperawatan<br>2. Tersedianya jenjang Pendidikan tinggi<br>3. Pelayanan asuhan keperawatan yang terus berkembang<br>4. PMK peningkatan mutu keamanan dan keselamatan pasien<br>5. Peraturan standar pelayanan RS | Menyusun dan menerapkan program pengawasan mutu pengelolaan pelayanan :<br>1. Deskripsi tupoksi<br>2. Mutu pengelolaan unit kperawatan, ketenagaan, sarana prasarana, mutu                                                                                                                                                                                            | Optimalisasi sinergitas program dan hubungan koordinasi, komunikasi vertical dan horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                |                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 6. Peraturan standar pelayanan ruang rawat, ruang khusus                                                                                                       | kinerja, penerapan MPKP             |                 |
| THREAT - T                                                                                                                                                     | ST - STRATEGIES                     | WT - STRATEGIES |
| 1. Kemampuan daya saing profesional perawat<br>2. Memiliki alat medis spesialistik canggih<br>3. Ketatnya persaingan RS<br>4. Daya beli masyarakat yang tinggi | Peningkatan hard dan soft skill SDM |                 |

Gambar 1.8. Matrix TOWS

Setelah mendapatkan nilai skor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman maka selanjutnya membuat Matrik *strategic position and action evaluation (SPACE)* untuk mempertajam analisis manajemen pelayanan asuhan keperawatan dan dapat melihat posisi serta arah perkembangan dimasa akan datang.

Empat kuadran dan dua sumbu dalam SPACE Matrix menurut (Kurniasih et al., 2021) sebagai berikut:

- Kuadran I - Pada sumbu X dan Y yang bertanda positif, positif
- Memiliki kekuatan, kemampuan yang prima serta peluang untuk melakukan ekspansi guna maksimalkan pertumbuhan
  - Strategi Aggressive / Progresif Strategic
- Kuadran II - Pada sumbu X positif dan Y negative
- Memiliki kemampuan tetapi juga memiliki kendala serta tantangan yang besar untuk dapat berjalan sehingga disarankan untuk membuat beragam rencana taktis
  - Diversifikasi Strategy
- Kuadran III - Pada sumbu X negatif dan Y negative
- Memiliki kelemahan internal sehingga menghadapi situasi kondisi yang dilematis dalam menghadapi kendala serta tantangan yang besar. Disarankan menggunakan strategi bertahan sambil mengendalikan kinerja internal dan melakukan berbagai pembenahan.
- Kuadran IV - Pada sumbu Y negative dan X positif
- Memiliki kelemahan internal namun sangat berpeluang untuk memperbaiki kinerja sehingga disarankan untuk merubah strategi lama yang tidak dapat menangkap peluang

b. *SPACE Matriks*

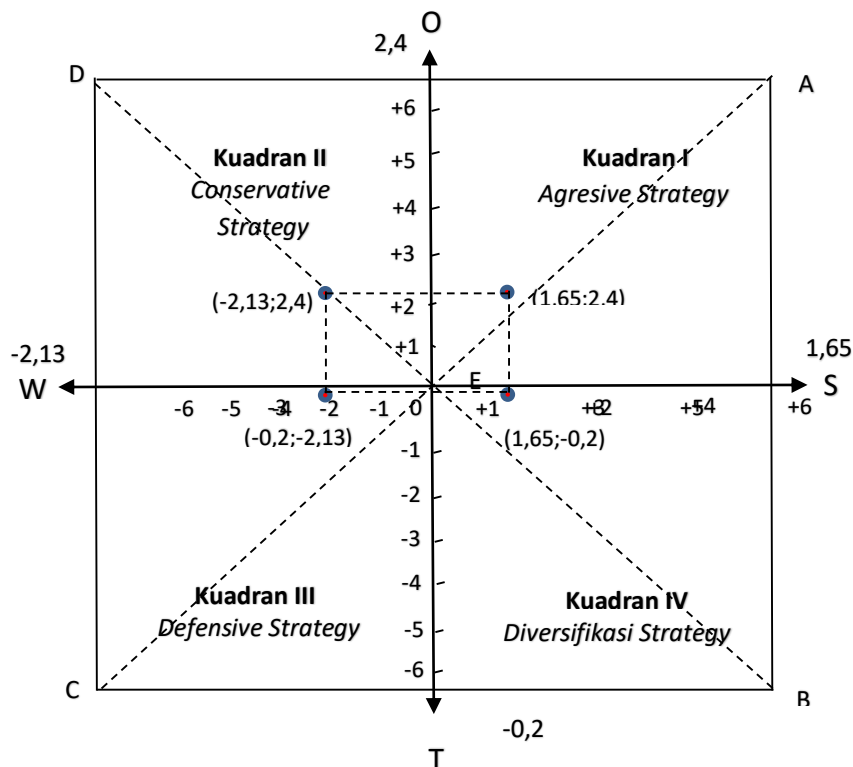
Langkah-langkah membuat SPACE matrix menurut (Kurniasih et al., 2021; Wardoyo, 2011), yaitu:

- 1) Tarik satu garis horizontal dari kiri ke kanan sebagai sumbu X dan satu garis vertical dari atas ke bawah sebagai sumbu Y
- 2) Pada garis horizontal (kiri) beri tanda kelemahan (*Weakness*) dan pada sebelah kanan dengan kekuatan (*Strenght*)
- 3) Pada garis sumbu Y (atas) beri tanda peluang (*Oportunitis*) dan yang bagian bawah beri tanda ancaman (*Threath*)
- 4) Tetapkan suatu nilai angka dari +1 (terburuk) sampai dengan +6 (terbaik) untuk kekuatan (*Strenght*) dan peluang (*Oportunitis*) sedangkan untuk kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threath*) beri nilai angka -1 (terbaik) sampai -6 (terburuk).
- 5) Cantumkan skor hasil penambahan SW pada sumbu X dan OT pada sumbu Y.
- 6) Jumlahkan nilai S dan W begitu juga dengan O dan T sehingga diperoleh titik potong untuk mendapatkan arah strategi

$$S + W = 1,65 + (-2,13) = -0,48 \quad \text{Sumbu X}$$

$$O + T = 2,4 + (-0,2) = 2,2 \quad \text{Sumbu Y}$$

- 7) Tarik garis arah vector (directional vector) dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang baru. Arah panah menunjukkan jenis strategi yang disarankan bagi unit pelayanan keperawatan.



Gambar 1.9. SPACE matrix

Keterangan :

- E = Adalah perpotongan diagonal AC dan BD  
A = mempunyai koordinat (1,65 ; 2,4)  
B = mempunyai koordinat (1,65 ; -0,2)  
C = mempunyai koordinat (-0,2 ; -2,13)  
D = mempunyai koordinat (-2,13 ; 2,4)

#### H. Prioritas Masalah

Berdasarkan titik koordinat dalam setiap wilayah A,B,C dan D pada SPACE Matriks tersebut diatas maka diperoleh pilihan strategi dan nilai luas setiap kuadran yang akan mengarahkan pada nilai ranking sehingga membantu pada tahap pengambilan keputusan prioritas penyelesaian masalah yang ada di pelayanan. Luas wilayah sesuai titik koordinat, ranking dan strategi tersebut seperti di bawah ini:

| Kuadran | Letak   |                 | Luas  | Ranking | Strategi      |
|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------------|
|         | Wilayah | Titik Koordinat |       |         |               |
| I       | A       | 1,65 ; 2,4      | 3,96  | I       | Agresif       |
| II      | B       | 1,65 ; -0,2     | -0,33 | III     | Defensive     |
| III     | C       | -0,2 ; -2,13    | 0,42  | II      | Konservatif   |
| IV      | D       | -2,13 ; 2,4     | -5,11 | IV      | Diversifikasi |

Gambar 1.10. Titik Koordinat, Ranking dan Strategi  
Berdasarkan Letak Kuadran dan Wilayah

*Internal Eksternal Matriks* adalah matriks ke 3 dalam tahap kedua (tahap pencocokan atau penandingan) yang menggambarkan kondisi posisi internal pada sumbu X dan eksternal pada sumbu Y berdasarkan skor.

Analisis internal dan ekstrnal dalam matriks IFE dan EFE pada sumbu X dan Y masing-masing memiliki skor total yang berada pada setiap sumbunya (XY), selanjutnya nilai tersebut, yaitu nilai SW yang berada pada sumbu X dijumlahkan dan OT pada sumbu Y juga dijumlahkan sehingga menjadi nilai SW (-0,48) dan OT (2,2). Hasil penjumlahan tersebut diletakkan pada gambar 9 (Sembilan) sel.

Posisi skor nilai internal dan eksternal menurut (Umar, Husein 2019 dalam Aditya Wardhana et al., 2021; Fred David, 2010; Mulyadi,2007) penjelasannya sebagai berikut:

| IFE        |                 | EFE        |                  |
|------------|-----------------|------------|------------------|
| Skor       |                 | Skor       |                  |
| Sumbu X    | Posisi Internal | Sumbu Y    | Posisi Eksternal |
| 1,0 – 1,99 | Lemah           | 1,0 – 1,99 | Rendah           |
| 2,0 – 2,99 | Sedang          | 2,0 – 2,99 | Sedang           |
| 3,0 – 4,0  | Kuat            | 3,0 – 4,0  | Tinggi           |

Gambar 1.11. Posisi IFE dan EFE Berdasarkan Skor Nilai

|                 |                      | Total IFE Score   |                      |                     |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                 |                      | Kuat<br>3,0 - 4,0 | Sedang<br>2,0 – 2,99 | Lemah<br>1,0 – 1,99 |
| Total EFE Score | Tinggi<br>3,0 – 4,0  | I                 | II                   | III                 |
|                 | Sedang<br>2,0 – 2,99 | IV                | V                    | VI                  |
|                 | Rendah<br>1,0- 1,99  | VII               | VIII                 | IX                  |
|                 |                      |                   |                      |                     |

Gambar 1.12 Kondisi /posisi Internal Eksternal Matriks dalam sel ke Vi (SW -0,48 ; OT 2,2)

Gambaran kondisi dan strategi sesuai dengan setiap sel, yaitu :

- Sel I, II, IV : Kondisi pada sel ini adalah grow and built. Merupakan kondisi yang sedang mengalami pertumbuhan. Strategi yang tepat adalah strategi intensif seperti market penetration strategy, market development strategy, dan product development strategy, atau strategi Tarik baik backward strategy, foreward strategy, dan horizontal strategy
- Sel III, V, VII : Kondisi pada sel ini adalah hold and maintain. Strategi yang tepat dalam kondisi ini adalah market penetration strategy dan strategi product development strategy
- Sel VI, VIII, IX : Pada sel ini kondisi yang dihadapi adalah kondisi yang sulit untuk bertahan apalagi untuk tumbuh dan berkembang. Strategi yang tepat dalam kondisi ini adalah strategi pelepasan (divestation strategy)

*Grand Strategy Matrix* adalah matriks ke 5 dalam tahap kedua yaitu tahap pencocokan atau penandingan. (Gochani, Kazami dan Alavije, 2012 ; Tambunan, Amelia, Priyana, 2019) menerangkan bahwa *SPACE Matriks (Strategic Position and Action Evaluation)* merupakan alat yang menunjukkan posisi atau situasi dan kondisi yang sedang dialami. (R. David, F, 2010 ; Mulyadi, 2007).

Dijelaskan kembali bahwa *SPACE Matriks* memiliki posisi strategi dua dimensi evaluasi yaitu posisi persaingan yang cepat maupun lambat dan posisi kompetitif yang kuat dan lemah sehingga pertimbangan strategi yang dapat digunakan adalah :

1. Kuadran I. Strategi Agresif

Agresif adalah posisi yang kuat pada kuadran I. Strategi ini berfokus pada bagaimana memanfaatkan peluang eksternal, dan menghindari ancaman dari luar serta mengatasi keterbatasan internal dengan melakukan berbagai pengembangan produk yang disesuaikan dengan keadaan pasar saat ini. Di era pelayanan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pasien saat ini manajemen dan pelayanan asuhan keperawatan memiliki tantangan yang besar dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan.

2. Kuadran II. Strategi Konservatif

Konservatif adalah strategi pada kuadran II. Pada posisi ini perlu mengevaluasi hubungan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan setiap fungsi-fungsi manajemen baik secara vertikal maupun horizontal. Perbaikan dan pengembangan produk pengelolaan manajemen pelayanan asuhan keperawatan (*Product Development, diversifikasi terkait*) dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna pelayanan asuhan keperawatan.

3. Kuadran III. Strategi Defensif

Pada posisi ini, situasi yang terjadi dan dihadapi adalah ketidakmampuan untuk bersaing dalam menghasilkan produk asuhan keperawatan yang dapat merebut kepuasan dan loyalitas klien maupun perawat. Dengan kata lain pengelolaan pelayanan keperawatan mengalami pertumbuhan yang lambat. Apabila tidak segera dilakukan perbaikan maka strategi yang digunakan adalah divestasi atau likuidasi dengan menggabungkan unit pelayanan agar pengawasan mutu pengelolaan manajemen asuhan keperawatan dapat dilakukan secara lebih intensif dengan sumber daya yang terbatas.

4. Kuadran IV. Strategi Kompetitif

Kompetitif adalah posisi bersaing yang kuat dengan pertumbuhan Tarik yang lambat, olehnya itu diversifikasi, strategi *joint venture* merupakan strategi yang tepat. Pengelolaan manajemen pelayanan keperawatan dapat melakukan kemitraan dengan unit bisnis yang lain terkait dengan pengembangan program pelayanan (*joint venture*).

## I. Alternatif Solusi

Tahap ketiga adalah tahap pengambilan keputusan dengan memberikan nilai kuantitatif pada beberapa alternatif strategi, seperti yang dikatakan oleh (Widiyarini dan Hunusalela, Z.F. (2019) ; David dan David (2016) ; Widiyanti & Damayanti, 2015) ; Baroto dan Purbohadiningrat (2014) ; R. David, F (2010) ; Mulyadi (2007) bahwa QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) merupakan suatu cara mengidentifikasi alternatif strategi dan mengintegrasikan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses pengambilan keputusan yang diturunkan dari Matriks SWOT.

Langkah-langkah menyusun QSPM sebagai berikut:

1. Buat daftar peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan berdasarkan informasi langsung dari matriks EFE dan matriks IFE lalu isi di kolom kiri QSPM.
2. Beri bobot pada setiap Tarik eksternal dan internal kunci sebagaimana pada matriks EFE dan IFE.
3. Periksa matriks-matriks pencocokan ditahap kedua dan kenali berbagai alternatif strategi yang dipertimbangkan untuk diimplementasikan.
4. Tentukan nilai AS (*Attractiveness Score*) yang ditentukan dengan memeriksa Tarik eksternal dan internal satu per satu. Cakupan nilai daya Tarik adalah:
  - 1) 1 adalah tidak menarik
  - 2) 2 adalah sedikit menarik
  - 3) 3 adalah cukup menarik, dan 4 adalah sangat menarik.
5. Hitung nilai TAS (*Total Attractiveness Score*) yang ditentukan dari hasil perkalian bobot dengan nilai daya Tarik dalam setiap baris. Semakin tinggi TAS semakin menarik alternatif strategi itu.
6. Hitung nilai *Sum Total Attractiveness Score (STAS)* dengan menjumlahkan total nilai daya Tarik dalam setiap kolom strategi QSPM. Semakin tinggi nilainya semakin menarik strategi tersebut dengan mempertimbangkan semua Tarik kritis eksternal dan internal yang berkaitan

| Faktor Kunci                                            | Bobot | Alternatif Strategi                |      |                                                                                             |      |                                     |      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
|                                                         |       | Strategi 1                         |      | Strategi 2                                                                                  |      | Strategi 3                          |      |
|                                                         |       | Program Mutu Pengelolaan pelayanan |      | Optimalisasi sinergitas program dan hubungan koordinasi, komunikasi vertical dan horizontal |      | Peningkatan hard dan soft skill SDM |      |
|                                                         |       | AS                                 | TAS  | AS                                                                                          | TAS  | AS                                  | TAS  |
| Peluang (O)                                             |       |                                    |      |                                                                                             |      |                                     |      |
| 1. UU Keperawatan                                       | 0,2   | 3                                  | 0,6  | 3                                                                                           | 0,6  | 2                                   | 0,4  |
| 2. Tersedianya jenjang Pendidikan tinggi                | 0,2   | 3                                  | 0,6  | 3                                                                                           | 0,6  | 3                                   | 0,6  |
| 3. Pelayanan asuhan keperawatan yang terus berkembang   | 0,2   | 3                                  | 0,6  | 4                                                                                           | 0,8  | 4                                   | 0,8  |
| 4. PMK peningkatan mutu keamanan dan keselamatan pasien | 0,1   | 3                                  | 0,3  | 4                                                                                           | 0,4  | 3                                   | 0,3  |
| 5. Peraturan standar pelayanan RS                       | 0,1   | 4                                  | 0,4  | 3                                                                                           | 0,3  | 3                                   | 0,3  |
| 6. Peraturan standar pelayanan ruang rawat              | 0,2   | 3                                  | 0,6  | 4                                                                                           | 0,8  | 4                                   | 0,8  |
| TOTAL BOBOT, TSK                                        | 1,00  |                                    | 0,31 |                                                                                             | 0,35 |                                     | 0,32 |

**Gambar 1.13. Faktor Kunci Peluang**  
pada QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*)

| Faktor Kunci                                | Bobot | Alternatif Strategi |      |            |      |            |      |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|------|------------|------|------------|------|
|                                             |       | Strategi 1          |      | Strategi 2 |      | Strategi 3 |      |
|                                             |       | AS                  | TAS  | AS         | TAS  | AS         | TAS  |
| Ancaman (T)                                 |       |                     |      |            |      |            |      |
| 1. Kemampuan daya saing profesional perawat | 0,2   | 4                   | 0,8  | 4          | 0,8  | 4          | 0,8  |
| 2. Memiliki alat medis spesialistik canggih | 0,3   | 2                   | 0,6  | 3          | 0,9  | 1          | 0,3  |
| 3. Ketatnya persaingan RS                   | 0,2   | 3                   | 0,6  | 2          | 0,4  | 3          | 0,6  |
| 4. Daya beli masyarakat yang tinggi         | 0,3   | 4                   | 0,12 | 3          | 0,9  | 4          | 0,12 |
| TOTAL BOBOT, TSK                            | 1,00  |                     | 0,32 |            | 0,30 |            | 0,29 |

**Gambar 1.14. Faktor Kunci Ancaman**  
pada QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*)



| Faktor Kunci                                                                    | Bobot | Alternatif Strategi |      |            |      |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|------------|------|------------|------|
|                                                                                 |       | Strategi 1          |      | Strategi 2 |      | Strategi 3 |      |
|                                                                                 |       | AS                  | TAS  | AS         | TAS  | AS         | TAS  |
| Kekuatan (S)                                                                    |       |                     |      |            |      |            |      |
| 1. Pendidikan DIII 65%; Ners 35%                                                | 0,1   | 4                   | 0,4  | 3          | 0,3  | 4          | 0,4  |
| 2. Visi RS menjadi pilihan masyarakat                                           | 0,1   | 3                   | 0,3  | 3          | 0,3  | 3          | 0,3  |
| 3. Menerapkan MPKP                                                              | 0,1   | 4                   | 0,4  | 4          | 0,4  | 4          | 0,4  |
| 4. Terbentuknya tim Komite Keperawatan                                          | 0,2   | 4                   | 0,8  | 4          | 0,8  | 4          | 0,8  |
| 5. Pemanfaatan TT yang mencapai ideal                                           | 0,2   | 3                   | 0,6  | 2          | 0,6  | 3          | 0,6  |
| 6. Adanya kegiatan non keperawatan /penunjang                                   | 0,2   | 3                   | 0,6  | 2          | 0,6  | 2          | 0,4  |
| 7. Sumber pembiayaan bersumber dari pemerintah dan jaminan kesehatan masyarakat | 0,05  | 3                   | 0,15 | 3          | 0,15 | 2          | 0,10 |
| 8. Penambahan jenis pelayanan spesialistik                                      | 0,05  | 2                   | 0,1  | 1          | 0,05 | 2          | 0,10 |
| TOTAL BOBOT, TSK                                                                | 1,00  |                     | 0,47 |            | 3,2  |            | 3,1  |

**Gambar 1.15. Faktor Kunci Kekuatan  
pada QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)**

| Faktor Kunci                                                                                                | Bobot | Alternatif Strategi |      |            |      |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|------------|------|------------|------|
|                                                                                                             |       | Strategi 1          |      | Strategi 2 |      | Strategi 3 |      |
|                                                                                                             |       | AS                  | TAS  | AS         | TAS  | AS         | TAS  |
| Kelemahan (W)                                                                                               |       |                     |      |            |      |            |      |
| 1. Penyebaran kualifikasi Ns tidak merata ke setiap unit                                                    | 0,11  | 3                   | 0,33 | 2          | 0,22 | 3          | 0,33 |
| 2. Kontrol pelayanan terhambat disebabkan tugas rangkap non keperawatan                                     | 0,14  | 4                   | 0,56 | 3          | 0,42 | 2          | 0,28 |
| 3. Kurangnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi perawat dan pengembangan pelayanan keperawatan        | 0,12  | 4                   | 0,48 | 2          | 0,24 | 2          | 0,24 |
| 4. Tidak sinerginya hubungan komunikasi vertikal dan horizontal serta program dengan manajerial keperawatan | 0,14  | 4                   | 0,56 | 4          | 0,56 | 2          | 0,28 |
| 5. SOP alur koordinasi kegiatan non keperawatan                                                             |       |                     |      |            |      |            |      |

|                                                            |      |   |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|
| 6. Rendahnya kesempatan meningkatkan kompetensi            |      |   |      |   |      |   |      |
| 7. Tim Komite belum mengikuti pelatihan pengelolaan komite | 0,11 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 |
| 8. Rendahnya daya saing perawat                            | 0,13 | 3 | 0,39 | 3 | 0,39 | 4 | 0,52 |
|                                                            | 0,13 | 4 | 0,52 | 4 | 0,52 | 4 | 0,52 |
|                                                            | 0,12 | 4 | 0,48 | 3 | 0,36 | 4 | 0,48 |
| TOTAL BOBOT, TSK                                           | 1,0  |   | 3,54 |   | 2,93 |   | 2,87 |
| TOTAL BOBOT, TSK (OTST)                                    |      |   | 4,61 |   | 6,78 |   | 6,58 |

Gambar 1.16. Faktor Kunci Kelemahan pada QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*)

Nilai total daya tarik dalam setiap kolom strategi QSPM adalah:

1. Strategi 1 : Program Mutu Pengelolaan pelayanan berjumlah 4,61
2. Strategi 2 : Optimalisasi sinergitas program dan hubungan koordinasi, komunikasi vertical dan horizontal berjumlah 6,78
3. Strategi 3 : Peningkatan hard dan soft skill SDM berjumlah 6,58

Dengan demikian alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam penyusunan *Planning Of Action* (POA) adalah Optimalisasi sinergitas program dan hubungan koordinasi, komunikasi vertical dan horizontal.

#### J. *Planning of Action* (POA)

*Planning of Action* (POA) merupakan rencana tindak lanjut pelaksanaan strategi sesuai dengan strategi-strategi yang telah dipilih dari QSPM Matriks. Rencana tindak lanjut tersebut tersusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, menurut spesifikasi kegiatan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjadi sasaran atau penerima dampak dari kegiatan, kapan dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan serta berapa biaya yang dibutuhkan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana, unsur-unsur yang terdapat didalam POA tersebut dikenal dengan unsur 5W + 1 H.

Rencana aksi yang dibuat dalam bentuk POA menggambarkan kegiatan yang spesifik yang memberikan dampak positif-*Spesific*, terukur-*Measurable*, dapat dicapai dengan metode yang sesuai dan dengan biaya ataupun tanpa biaya-

*Attainable atau achievable*, bisa dilakukan-*Relevant*, sesuai dengan kebutuhan saat ini -*Time bond (SMART)*

| Str | Program | Sasaran | Kegiatan | Dokumen terkait | Indikator Keberhasilan | Target Waktu | Biaya |
|-----|---------|---------|----------|-----------------|------------------------|--------------|-------|
| 1   | 2       | 3       | 4        | 5               | 6                      | 7            | 8     |
| 1.  | 1.      |         | a.<br>b. |                 |                        |              |       |
|     | 2.      |         | a.<br>b. |                 |                        |              |       |
| 2.  | Dst.    |         |          |                 |                        |              |       |

Gambar 1.17. *Planning of Action (POA)*

Keterangan tabel :

Kolom 1 : Strategi I, II, III

Kolom 2 : Nama program misalnya “Peningkatan Mutu Pengelolaan Unit”

Kolom 3 : Sasaran atau target yang terkena dampak dari kegiatan, misalnya Katim dan perawat pelaksana

Kolom 4 : Kegiatan adalah penjabaran atau rincian kegiatan yang berasal dari program, misalnya kegiatan sosialisasi standar pengelolaan unit apa, penyusunan deskripsi tupoksi Kepru, Ka.Tim, PP, Sosialisasi tupoksi Kepru, Ka.Tim, PP, workshop, Bimtek, dll

Kolom 5 : Dokumen terkait sebagai landasan yang memperkuat program dan kegiatan, misalnya peraturan pemerintah, dll.

Kolom 6 : Indikator keberhasilan adalah nilai kuantitatif yang ingin dicapai.

Kolom 7 : Target waktu dapat berupa “bulan” atau “tanggal pelaksanaan”

Kolom 8 : Kebutuhan biaya

## K. Implementasi

Berdasarkan ketertarikan dalam analisis QSPM maka strategi yang akan di implementasikan adalah pada strategi kedua, yaitu Optimalisasi sinergitas program dan hubungan koordinasi, komunikasi vertical dan horizontal. Strategi tersebut dituangkan menjadi beberapa kegiatan sebagaimana terdapat dalam *Planning Of Action (POA)*.

Program dan kegiatan yang dibuat kedalam *Planning Of Action (POA)* mengarahkan pada kegiatan yang tersusun dan terencana secara sistematis, apabila ditemukan kendala dalam rentang pelaksanaan tersebut maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi setiap kendala yang terjadi.

Tentunya pemberian nilai ketertarikan dilakukan bersama oleh perawat di unit pelayanan sehingga terbentuk penyatuan persepsi yang akan meningkatkan

motivasi serta komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Demikian pula komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting yang perlu dilakukan baik secara horizontal maupun vertical diantara perawat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi dan koordinasi akan mendorong kearah terciptanya kebijakan-kebijakan terhadap penyusunan langkah-langkah strategis selanjutnya dan terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sehingga menjadi budaya organisasi bagi pelayanan keperawatan.

#### **L. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan yang mengukur pencapaian atau keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan secara periodik baik triwulan, semester atau tahunan untuk melihat penyimpangan atau kendala pada setiap fase yang terjadi bila pencapaian tidak mencapai target keberhasilan.



# **KLASIFIKASI KLIEN BERDASARKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN**



## **KLASIFIKASI KLIEN BERDASARKAN TINGKAT KETERGANTUNGAN**

### **A. Pendahuluan**

Rumah sakit merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, dan ini merupakan institusi penyedia jasa. Pelayanan yang kompleks perlu dikelola secara profesional terhadap sumber daya manusianya. Salah satu tenaga penyedia jasa pelayanan di rumah sakit adalah tenaga perawat. Bagi tenaga perawat di rumah sakit melakukan praktek keperawatan yang berupa pelayanan keperawatan yang dikenal dengan asuhan keperawatan.

Keperawatan memberikan pelayanan di rumah sakit selama 24 jam sehari, serta mempunyai kontak yang konstan dengan pasien. Oleh karena itu, pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Kontribusi yang diberikan keperawatan sangat menentukan kualitas pelayanan rumah sakit. Upaya untuk peningkatan pelayanan rumah sakit juga diikuti upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.

Salah satu upaya dalam perbaikan pelayanan kepada pasien adalah dengan pengklasifikasian pasien itu sendiri. Dengan itu maka perawat akan lebih membagi asuhan keperawatan yang lebih terfokus. Sebagai contoh dalam kasus Covid-19 di Rumah Sakit India dengan menggunakan system klasifikasi pasien memudahkan dalam menganalisa data lebih baik. Semua kebutuhan pasien lebih terukur baik dalam obat-obatan, layanan dan hasil pengkajian kesehatannya.(Gada et al., 2022)

### **B. Definisi**

Klasifikasi pasien adalah metode pengelompokkan pasien menurut jumlah dan kompleksitas persyaratan perawatan mereka. Dalam banyak sistem klasifikasi, pasien dikelompokkan sesuai dengan ketergantungan mereka pada pemberi perawatan dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan perawatan.

### **C. Tujuan Sistem Klasifikasi Pasien**

Tujuan klasifikasi pasien adalah untuk mengkaji pasien dan pemberian nilai untuk mengukur jumlah usaha yang diperlukan untuk memenuhi perawatan yang dibutuhkan pasien (Gillies D.A., 1994). Menurut Swanburg, tujuan klasifikasi pasien adalah untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan dan menentukan nilai produktivitas (Swanburg, 1999).

Setiap kategori deskriptor empat perawatan (aktifitas sehari-hari, kesehatan umum, dukungan pengajar serta emosional, dan perlakuan sekitar pengobatan) dipakai untuk menunjukkan karakteristik dan tingkat perawat yang dibutuhkan pasien di dalam klasifikasi tersebut. Klasifikasi pasien sangat menentukan perkiraan kebutuhan tenaga. Hal ini dilakukan untuk menetapkan jumlah tenaga keperawatan

sesuai dengan kategori yang dibutuhkan untuk asuhan keperawatan pasien di setiap unit.

#### **D. Manfaat**

Manfaat dari pengklasifikasian pasien adalah terjaminnya pelayanan yang paripurna dengan lebih fokus pada kebutuhan pasien. Dengan klasifikasi pasien dapat menentukan banyak dan jenis tenaga yang dibutuhkan dan menentukan nilai produktifitas sehingga jumlah perawat dengan kebutuhan pasien dapat seimbang.

#### **E. Ruang Lingkup**

Kategori keperawatan pasien menurut Swanburg (1999) terdiri dari :

1. Self-care  
Pasien memerlukan bantuan minimal dalam melakukan tindak keperawatan dan pengobatan. Pasien melakukan aktivitas perawatan diri sendiri secara mandiri. Biasanya dibutuhkan waktu 1-2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam/24 jam.
2. Minimal care  
Pasien memerlukan bantuan sebagian dalam tindak keperawatan dan pengobatan tertentu, misalnya pemberian obat intravena, dan mengatur posisi. Biasanya dibutuhkan waktu 3-4 jam dengan waktu rata-rata efektif 3,5 jam/24jam.
3. Intermediate care  
Pasien biasanya membutuhkan waktu 5-6 jam dengan waktu rata-rata efektif 5,5 jam/24 jam.
4. Modified intensive care  
Pasien biasanya membutuhkan waktu 7-8 jam dengan waktu rata-rata efektif 7,5 jam/24 jam.
5. Intensive care  
Pasien biasanya membutuhkan 10-14 jam dengan waktu rata-rata efektif 12 jam/24 jam.

Metode lain yang sering digunakan di Rumah Sakit adalah metode menurut Douglas (1984), yang mengklasifikasi derajat ketergantungan pasien dalam tiga kategori, yaitu perawatan minimal, perawatan intermediate dan perawatan maksimal atau total (Douglas & Laura Mae, 1992).

1. Perawatan minimal  
Perawatan ini memerlukan waktu 1-2 jam/24 jam. Kriteria pasien pada klasifikasi ini adalah pasien masih dapat melakukan sendiri kebersihan diri, mandi, dan ganti pakaian, termasuk minum. Meskipun demikian pasien perlu diawasi ketika melakukan ambulasi atau gerakan. Ciri-ciri lain pada pasien dengan klasifikasi ini



adalah observasi tanda vital dilakukan setiap shift, pengobatan minimal, status psikologis stabil, dan persiapan prosedur memerlukan pengobatan.

2. Perawatan intermediate

Perawatan ini memerlukan waktu 3-4 jam/24 jam. Kriteria pasien pada klasifikasi ini adalah pasien memerlukan bantuan perawat sebagian, pasien masih perlu bantuan dalam memenuhi kebersihan diri, makan dan minum. Disamping itu pasien dalam klasifikasi ini memerlukan pengobatan lebih dari sekali. Ciri-ciri lain pada pasien dengan klasifikasi ini yaitu Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik- turun tempat tidur, membutuhkan bantuan untuk ambulasi/ berjalan, membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan, membutuhkan bantuan untuk makan/ disuap, membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut, membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan, membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/ kamar mandi), post operasi minor 24 jam, melewati fase akut dari post operasi mayor, fase awal dari penyembuhan, observasi tanda- tanda vital setiap 4 jam, gangguan emosional ringan, pengobatan dengan injeksi, pasien dengan kateter urin, pemasukan dan pengeluaran dicatat pasien dengan infus, dan pasien dengan pleura pungsi.

3. Perawatan maksimal atau total

Perawat ini memerlukan waktu 5-6 jam/24 jam. Kriteria pasien pada klasifikasi ini adalah pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama, pasien harus dibantu tentang segala sesuatunya. Ciri-ciri lain pada pasien dengan klasifikasi ini yaitu membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda, membutuhkan latihan pasif, kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (Naso Gastrik Tube), membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut, pemakaian alat penghisap (suction), membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan, dimandikan perawat, dalam keadaan inkontinensia, 24 jam post operasi mayor, pasien tidak sadar, keadaan pasien tidak stabil, observasi TTV setiap kurang dari 2 jam, perawatan luka bakar, perawatan kolostomi, menggunakan alat bantu nafas (ventilator), menggunakan WSD, irigasi kandung secara terus menerus, menggunakan alat traksi (skeletal traksi), Fraktur dan atau pasca operasi tulang belakang/ leher, gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi.

Menurut Depkes (2002), klasifikasi ketergantungan pasien ada 4 kategori, masing-masing memerlukan waktu:

- 1) Asuhan keperawatan minimal : 2 jam / 24 jam
- 2) Asuhan keperawatan sedang : 3,08 jam/24 jam
- 3) Asuhan keperawatan agak berat : 4,15 jam/24 jam
- 4) Asuhan keperawatan maksimal : 6,16 jam/24 jam

Klasifikasi kategori asuhan keperawatan menurut Depkes 2002:(Nursalam, 2007)

- 1) Asuhan Keperawatan Minimal
  - a. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri
  - b. Makan dan minum dilakukan sendiri
  - c. Ambulasi dengan pengawasan
  - d. Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift
  - e. Pengobatan minimal, status psikologis stabil
- 2) Asuhan Keperawatan Sedang
  - a. Kebersihan diri dibantu, makan minum dibantu
  - b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
  - c. Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali
- 3) Asuhan Keperawatan Agak Berat
  - a. Sebagian besar aktifitas dibantu
  - b. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 – 4 jam sekali
  - c. Terpasang folley cateter, intake output dicatat
  - d. Terpasang infuse
  - e. Pengobatan lebih dari sekali
  - f. Persiapan pengobatan perlu prosedur
- 4) Asuhan Keperawatan Maksimal
  - a. Segala aktifitas diberikan perawat
  - b. Posisi diatur, observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam
  - c. Makan memerlukan NGT, terapi intra vena
  - d. Penggunaan suction
  - e. Gelisah/disorientasi

Menurut Depkes, terdapat pengelompokan unit kerja di Rumah Sakit, yaitu:

- a. Rawat inap

Kebutuhan tenaga perawat di ruang perawatan menggunakan rumus:

$$\text{Kebutuhan tenaga} = \frac{\text{Jumlah jam perawatan di ruangan/hari}}{\text{Jam efektif perawat}}$$

Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut, perlu ditambah faktor koreksi dengan menambah perawat libur (loss day) dan tugas non keperawatan.

$$\text{Loss day} = \frac{\text{Jumlah hari minggu dalam 1 tahun} + \text{cuti} + \text{hari besar}}{\text{Jumlah hari kerja efektif dalam 1 tahun}} \times \text{kebutuhan tenaga}$$

Tenaga keperawatan yang mengerjakan pekerjaan non keperawatan diperkirakan 25% dari jumlah tenaga keperawatan.

$$\text{Tugas non keperawatan} = (\text{kebutuhan tenaga} + \text{loss day}) \times 25\%$$

Jumlah total kebutuhan tenaga keperawatan

$$\text{Jumlah kebutuhan tenaga} = \text{kebutuhan tenaga} + \text{loss day} + \text{tugas non keperawatan}$$

**b. Rawat inap intensif**

Jumlah jam perawatan perhari = 12 jam/pasien

Perhitungan jumlah tenaga keperawatan:

$$\frac{(\text{Jumlah jam perawatan} \times \text{jumlah pasien})}{\text{Jumlah jam efektif/hari}} + \text{loss day}$$

**c. Instalasi gawat darurat**

Jumlah jam perawatan perhari = 4 jam/pasien

Perhitungan jumlah tenaga keperawatan

$$\frac{(\text{Jumlah jam perawatan} \times \text{jumlah pasien})}{\text{Jumlah jam efektif/hari}} + \text{loss day}$$

**d. Kamar bersalin**

Waktu yang diperlukan untuk pertolongan persalinan mencakup kala I s.d IV = 4 jam/pasien

Perhitungan jumlah tenaga keperawatan

$$\frac{(\text{Jumlah jam perawatan} \times \text{jumlah pasien})}{\text{-----}} + \text{loss day}$$

$$\text{Jumlah jam efektif/hari}$$

e. Ruang operasi

- Kamar operasi

Ketergantungan pasien:

- 1) Operasi besar/khusus : 5 jam/operasi
- 2) Operasi sedang : 2 jam/operasi
- 3) Operasi kecil : 1 jam/operasi

Kriteria operasi kecil, sedang, besar dan khusus menurut Depkes (1997)

| Jenis Operasi  | Waktu   | Peralatan        | Anestesi                     | Resiko |
|----------------|---------|------------------|------------------------------|--------|
| Operasi kecil  | < 1 jam | Alat standar     | Lokal                        | Kecil  |
| Operasi Sedang | 1-2 jam | Alat standar +   | Lokal, regional, dan general | Sedang |
| Operasi Besar  | 3 jam   | Alat standar ++  | General                      | Besar  |
| Operasi Khusus | 4 jam   | Alat standar +++ | General                      | Tinggi |

Sumber: Keperawatan Perioperatif: Prinsip dan Praktik (2008)

Contoh:

- Operasi kecil : Insisi abses, angkat tahi lalat, angkat kutil, sirkumsisi, dll
- Operasi sedang : Tonsilektomi, apendektomi, dll
- Operasi besar : Laparoskopi, bedah paru, bedah jantung, bedah digestif.
- Operasi khusus : Bedah saraf, bedah tulang belakang.

Perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan, sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah jam perawatan/hari} \times \text{Jumlah operasi}) \times \text{Jumlah perawat dalam tim}}{\text{-----}}$$

$$\text{Jam kerja efektif/hari}$$

- Ruang penerimaan dan RR

Ketergantungan pasien di ruang penerimaan = 15 menit

Ketergantungan pasien di RR = 1 jam

Perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah jam ketergantungan pasien} \times \text{jumlah operasi/hari}}{\text{-----}}$$

$$\text{Jumlah jam efektif/hari}$$

f. Rawat Jalan

Jumlah jam perawatan/hari = 15 menit

Perhitungan jumlah tenaga keperawatan

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\text{Jumlah jam perawatan (menit) x jumlah pasien}}{\text{Jumlah jam efektif/hari x 60 menit}} + \text{faktor koreksi (15\%)}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi**

Klasifikasi pasien sangat dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan kasus yang ada di tempat pelayanan keperawatan. Ditambah dengan sumber daya pelayanan keperawatan pada khususnya dan pelayanan Kesehatan pada umumnya. Hal ini pun dipengaruhi dengan kebijakan top manager di dalam mengambil suatu keputusan yang tepat dan cepat terutama bila ada kasus-kasus yang membutuhkan segera pengelompokan pasiennya.

**G. Analisis situasi**

Melihat dari berbagai sumber pengklasifikasian yang ada, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Ada 2 kemungkinan pemakaian pengklasifikasian di dalam praktek pelayanannya. **Pertama**, difokuskan pada pasien di dalam memenuhi kebutuhannya. **Kedua**, berpijak pada kebutuhan tenaga keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam tiap shiftnya.

**H. Prioritas masalah**

Maka dengan melihat kondisi dua situasi di atas kita kembalikan pada kepentingan saat dilakukannya pengklasifikasian tersebut.

**I. Alternative solusi**

Pengambilan model pengklasifikasian pasien akan lebih tepat bila didukung oleh kebijakan dari pimpinan dan disosialisasikan seluruh unit perawatan rawat inap dan tetap dilakukan supervise dalam implementasinya.

**J. Plan of Action**

Untuk mengimplementasikan pengklasifikasian pasien perlu dilakukan persiapan semua komponen dalam melakukan pelayanan kepada pasien.

- Kebijakan dalam pengklasifikasian pasien
- Sumberdaya manusia
- Sarana dan prasarana yang mensupport pengklasifikasian pasien
- Supervise managerial dalam implementasinya\

## K. Implementasi

Douglas mengatur kebutuhan tenaga perawat melalui klasifikasi sebagai berikut:

| Klasifikasi         | Kebutuhan Perawat |      |       |
|---------------------|-------------------|------|-------|
|                     | Pagi              | Sore | Malam |
| <i>Minimal Care</i> | 0,17              | 0,14 | 0,07  |
| <i>Partial Care</i> | 0,27              | 0,15 | 0,10  |
| <i>Total Care</i>   | 0,36              | 0,30 | 0,20  |

Contoh soal:

Pada sebuah ruangan rawat inap dengan kapasitas 20 bed, diketahui:

- Hari 1 Pagi : Terdapat 10 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Sore : Terdapat 10 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Malam : Terdapat 10 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care
- Hari 2 Pagi : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Sore : Terdapat 10 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Malam : Terdapat 10 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care, dan 1 pasien total care
- Hari 3 Pagi : Terdapat 12 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care  
Sore : Terdapat 12 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care  
Malam : Terdapat 12 pasien dengan minimal care, 5 pasien partial care
- Hari 4 Pagi : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Sore : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Malam : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 4 pasien partial care, dan 1 pasien total care
- Hari 5 Pagi : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 3 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Sore : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 3 pasien partial care, dan 1 pasien total care  
Malam : Terdapat 11 pasien dengan minimal care, 3 pasien partial care, dan 1 pasien total care

**PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KEPERAWATAN (DOUGLAS, 1992)**

**RSU.....Bulan.....tahun:.....**

**RUANG: ..... INSTALASI: .....**

| Tgl           | Pagi |      |       |      | Sore |      |       |      | Malam |      |       |      | Supervisor                                                                                                                                     |      |
|---------------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | Min  | Part | Total | Jml  | Min  | Part | Total | Jml  | Min   | Part | Total | Jml  | Paraf                                                                                                                                          | Nama |
| 1             | 1,7  | 1,08 | 0,36  | 3,14 | 1,4  | 0,6  | 0,3   | 2,3  | 0,7   | 0,4  | 0,2   | 1,3  |                                                                                                                                                |      |
| 2             | 1,87 | 1,35 | 0,36  | 3,58 | 1,4  | 0,75 | 0,3   | 2,45 | 0,7   | 0,5  | 0,2   | 1,4  |                                                                                                                                                |      |
| 3             |      |      |       |      |      |      |       |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                |      |
| Dst..         |      |      |       |      |      |      |       |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                |      |
| Jumlah        | 3,57 | 2,43 | 0,72  | 6,72 | 2,8  | 1,35 | 0,6   | 4,75 | 1,4   | 0,9  | 0,4   | 2,7  |                                                                                                                                                |      |
| Rata-rata     | 1,78 | 1,21 | 0,36  | 3,36 | 1,4  | 0,67 | 0,3   | 2,37 | 0,7   | 0,45 | 0,2   | 1,35 |                                                                                                                                                |      |
| Index         | 0,17 | 0,27 | 0,36  |      | 0,14 | 0,15 | 0,30  |      | 0,07  | 0,10 | 0,20  |      |                                                                                                                                                |      |
| Jumlah Tenaga | 3,36 |      |       |      | 2,37 |      |       |      | 1,35  |      |       |      | 7,08 dibulatkan 7 perawat.<br><br>$1/3 \times 7 = 2,3$<br>dibulatkan 2 perawat<br><br>$7 + 2 = 9$<br><br>Ada .....-<br>Kurang/lebih =<br>..... |      |

+

Mengetahui/Menyetujui  
Supervisor

....., tgl.....  
Kepala Ruang Keperawatan

(.....)

(.....)

**L. Evaluasi**

Beberapa model pengklasifikasian pasien akan berjalan baik bila didukung semua komponen pemberi pelayanan Kesehatan di rumah sakit. Pelaksanaan akan bermanfaat bila dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

## JENJANG KARIR PERAWAT



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**



## **JENJANG KARIR PERAWAT**

### **A. Pendahuluan**

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit (UU No. 38, 2014). Untuk mencapai pelayanan keperawatan profesional maka dibutuhkan tenaga keperawatan yang profesional dan kompeten. Mekanisme peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan dapat dilakukan melalui pengembangan tenaga keperawatan.

Pengembangan profesionalisme tenaga keperawatan dapat dilakukan dengan pengembangan jenjang karir perawat yang merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi yang menghasilkan kinerja profesional. Jenjang karir mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akuntabel dan etis sesuai batas kewenangan. Adanya jenjang karir perawat dapat meningkatkan pelayanan profesional perawat (Permenkes No. 40, 2017).

Nelson, Sassaman, dan Phillips (2008) dalam Permenkes No. 40 (2017) mengemukakan bahwa program jenjang karir perawat dirancang untuk menginspirasi dan menghargai keunggulan klinis yang dimiliki. Pengembangan karir perawat dalam konteks penghargaan dapat berupa penghargaan level kompetensi dan kewenangan yang lebih tinggi, juga diikuti dengan penghargaan material yang memperhatikan tingkatan level karir dari setiap jenjang karir profesional. Perawat profesional diharapkan mampu berpikir rasional, mengakomodasi kondisi lingkungan, mengenal diri sendiri, belajar dari pengalaman dan mempunyai aktualisasi diri sehingga dapat meningkatkan jenjang karir profesinya.

### **B. Definisi**

Jenjang karir perawat sangat diperlukan dalam pengembangan karir tenaga keperawatan. Jenjang karir perawat merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi. Jenjang karir merupakan jalur mobilitas vertikal yang ditempuh melalui peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan formal dan informal yang sesuai/ relevan maupun pengalaman praktik klinis yang diakui. Oleh karena itu jenjang karir merupakan jalur untuk peningkatan peran perawat profesional di sebuah institusi. Dalam penerapannya, jenjang karir memiliki kerangka waktu untuk pergerakan dari satu level ke level lain yang lebih tinggi dan dievaluasi berdasarkan penilaian kinerja (Permenkes No. 40, 2017).

Jenjang karir perawat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tugas pekerjaan (*job*) dan karir (*career*). Pekerjaan sebagai perawat diartikan sebagai suatu posisi atau jabatan yang diberikan/ ditugaskan, serta ada keterikatan hubungan pertanggung jawaban dan kewenangan antara atasan dan bawahan, serta mendapatkan imbalan penghargaan berupa uang. Karir sebagai perawat diartikan sebagai suatu bidang kerja yang dipilih dan ditekuni oleh individu untuk dapat memenuhi kepuasan kerja individu melalui suatu sistem dan mekanisme peringkat, dan bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pekerjaan (kinerja) sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap bidang profesi yang dipilihnya (Permenkes No. 40, 2017).

### **C. Tujuan**

Jenjang karir perawat disusun dengan baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan jenjang karir perawat menurut Permenkes No. 40 (2017) adalah:

- a. Meningkatkan moral kerja dan kebuntuan karir (*dead end job/ career*)
- b. Menurunkan jumlah perawat yang keluar dari pekerjaannya (*turn over*)
- c. Menata sistem promosi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga mobilitas karir berfungsi dengan baik dan benar
- d. Meningkatkan profesional perawat yang mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan efisien
- e. Meningkatkan kepuasan individu perawat terhadap bidang kerja profesi yang ditekuninya.

### **D. Manfaat**

Jenjang karir perawat sangat bermanfaat bagi tenaga keperawatan. Pemilihan karir dan meningkatkannya secara bertahap akan menjamin individu perawat dalam mempraktikkan bidang profesinya, karena karir merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan pengakuan dan penghargaan baik materi maupun non materi sesuai level karir perawat yang disandangnya. Komitmen terhadap karir, dapat dilihat dari sikap dan perilaku individu perawat terhadap profesinya serta motivasi untuk bekerja sesuai dengan karir yang telah dipilihnya (Permenkes No. 40, 2017).

### **E. Ruang Lingkup**

Pengembangan profesionalisme tenaga keperawatan dapat dilakukan melalui pengembangan jenjang karir perawat. Pengembangan jenjang karir perawat terdiri dari 4 peran utama yang meliputi : Perawat Klinik (PK), Perawat Manajer (PM), Perawat Pendidik (PP) dan Perawat Riset (PR). Perawat Klinik merupakan perawat yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung kepada

klien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Perawat Manajer merupakan perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana kesehatan baik sebagai pengelola tingkat bawah (*front line manager*), pengelola tingkat menengah (*middle manager*) maupun pengelola tingkat atas (*top manager*). Perawat Pendidik adalah perawat yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di institusi pendidikan keperawatan sedangkan Perawat Riset adalah perawat yang bekerja di bidang penelitian keperawatan/ kesehatan.

Pengembangan jenjang karir perawat memiliki 5 level, yaitu dari level 1 sampai dengan level 5 (Permenkes No. 40, 2017). Pengembangan jenjang karir perawat dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan seperti pendidikan formal, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, workshop atau seminar. Selain itu juga melalui pengakuan terhadap kemampuan yang didasarkan kepada pengalaman kerja dan kinerja praktik keperawatan serta penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan kompetensinya (Permenkes No. 40, 2017)

#### **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Jenjang karir perawat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan Permenkes No. 40 (2017) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem jenjang karir perawat meliputi :

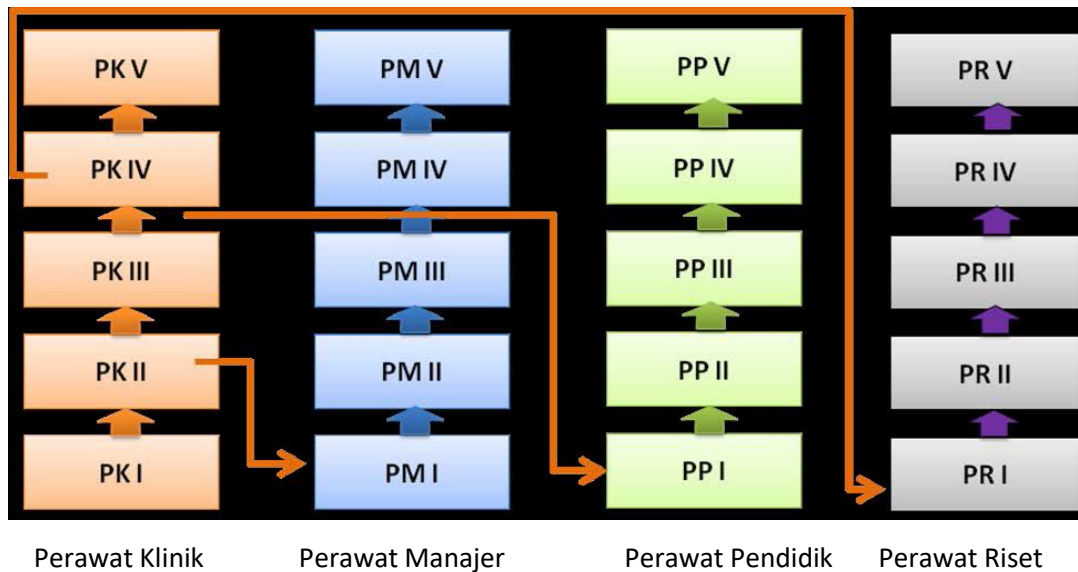
1. Kinerja
2. Orientasi profesional dan kepribadian perawat
3. Kompetensi yang menghasilkan kinerja professional

#### **G. Analisis Situasi**

Kajian situasi pelaksanaan jenjang karir perawat sangat penting dalam pengembangan dan penjenjangan karir perawat profesional. Secara umum, berdasarkan Permenkes No. 40 (2017) penjenjangan karir professional perawat terdiri dari 4 bidang, meliputi :

1. Perawat Klinik (PK), yaitu perawat yang memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien/klien sebagai individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Perawat Manajer (PM) yaitu perawat yang mengelola pelayanan keperawatan di sarana kesehatan, baik sebagai pengelola tingkat bawah (*front line manager*), tingkat menengah (*middle management*) maupun tingkat atas (*top manager*)
3. Perawat Pendidik (PP) yaitu perawat yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di institusi pendidikan keperawatan.
4. Perawat Peneliti/Riset (PR) yaitu perawat yang bekerja di bidang penelitian keperawatan/kesehatan

Keempat jalur jenjang karir profesional perawat digambarkan dalam gambar 1



Gambar 3.1 Bidang Jenjang Karir Perawat dan Pengembangan Karir Perawat Klinik

Pengembangan jenjang karir profesional perawat pada setiap bidang harus berjenjang mulai dari jenjang I sampai dengan jenjang V dan bersifat terbuka. Artinya, perawat profesional dimungkinkan mencapai jenjang karir di semua bidang. Salah satu persyaratan pengembangan jenjang karir profesional baik sebagai perawat manajer, perawat pendidik, maupun perawat klinik adalah mempunyai kualifikasi sebagai perawat klinik.

Setiap bidang memiliki 5 (lima) level, dimulai level generalis, dasar kekhususan, lanjut kekhususan, spesialis, subspecialis/ konsultan. Untuk menjadi perawat manajer level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level II. Untuk menjadi perawat pendidik level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level III. Untuk menjadi perawat peneliti level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level IV.

## H. Prioritas Masalah

Pengembangan jenjang karir perawat belum seluruhnya mempunyai pedoman. Pedoman jenjang karir yang sudah ditetapkan dalam Permenkes No. 40 tahun 2017 adalah Jenjang Karir Perawat Klinik. Pada saat ini prioritas masalah untuk pembahasan adalah Jenjang Karir Perawat Klinik yang bekerja di Rumah Sakit dan Pelayanan Primer.

### - Level Karir dan Kompetensi Perawat di Rumah Sakit

Kompetensi perawat klinis di Rumah Sakit dideskripsikan sesuai level jenjang karir perawat klinis (PK I – PK V). Kompetensi sesuai level pada perawat klinis yaitu:

a. Perawat Klinis I

Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan dibawah bimbingan. Kompetensi perawat klinis I yaitu:

- 1) Melakukan asuhan keperawatan (pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menetapkan intervensi dan melaksanakan tindakan keperawatan serta evaluasi) dengan lingkup keterampilan tehnik dasar.
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan keperawatan.
- 3) Melakukan komunikasi terapeutik di dalam asuhan keperawatan.
- 4) Menerapkan caring dalam keperawatan.
- 5) Menerapkan prinsip keselamatan klien.
- 6) Menerapkan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi.
- 7) Melakukan kerjasama tim dalam asuhan keperawatan.
- 8) Menerapkan prinsip mutu dalam tindakan keperawatan.
- 9) Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien terkait dengan kebutuhan dasar.
- 10) Mengumpulkan data kuantitatif untuk kegiatan pembuatan laporan kasus klien.
- 11) Mengumpulkan data riset sebagai anggota tim penelitian.
- 12) Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 13) Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
- 14) Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
- 15) Menunjukkan sikap asertif.
- 16) Menunjukkan sikap empati.
- 17) Menunjukkan sikap etik.
- 18) Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
- 19) Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
- 20) Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
- 21) Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

b. Perawat Klinis II

Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola

klien/sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut/kompleks. Kompetensi perawat klinis II yaitu:

- 1) Melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan proses keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan *partial* dan *total care*.
- 2) Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
- 3) Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien.
- 4) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien untuk menentukan intervensi keperawatan.
- 5) Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien.
- 6) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam pemberian asuhan keperawatan.
- 7) Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
- 8) Menerapkan *caring* yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
- 9) Melakukan kajian insiden keselamatan klien dan manajemen risiko klinis.
- 10) Melakukan kajian terhadap kejadian dan risiko infeksi pada klien.
- 11) Melakukan kerjasama antar tim.
- 12) Menerapkan pengendalian mutu dengan satu metoda tertentu sesuai kebijakan rumah sakit setempat.
- 13) Mengimplementasikan pengendalian mutu asuhan keperawatan.
- 14) Merumuskan kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistik sesuai dengan masalah kesehatan klien.
- 15) Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga.
- 16) Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga.
- 17) Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan dan rencana tindak lanjut.
- 18) Melaksanakan preceptorsip pada tenaga perawat di bawah bimbingannya dan praktikan.
- 19) Melakukan diskusi refleksi kasus untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan.
- 20) Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan.
- 21) Membantu pelaksanaan riset keperawatan deskriptif.
- 22) Melakukan survey keperawatan.
- 23) Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 24) Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.

- 25) Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
- 26) Menunjukkan sikap asertif.
- 27) Menunjukkan sikap empati.
- 28) Menunjukkan sikap etik.
- 29) Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
- 30) Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
- 31) Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
- 32) Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

c. Perawat Klinis III

Perawat Klinis III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan komprehensif pada area spesifik dan mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis III yaitu:

- 1) Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan partial dan total dengan masalah kompleks di area keperawatan spesifik.
- 2) Menerapkan filosofi dasar keperawatan pada area keperawatan spesifik.
- 3) Menerapkan penyelesaian dan pengambilan keputusan masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan di unit keperawatan.
- 4) Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien pada lingkup area spesifik.
- 5) Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
- 6) Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada unit ruang rawat.
- 7) Menggunakan metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit ruang rawat.
- 8) Menetapkan masalah mutu asuhan keperawatan berdasarkan kajian standar dan kebijakan mutu.
- 9) Melaksanakan analisis akar masalah (RCA) dan membuat grading risiko terhadap masalah klinis.
- 10) Mengidentifikasi kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistik sesuai dengan masalah kesehatan klien di area spesifik.
- 11) Mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang tersedia untuk edukasi kesehatan pada area spesifik.

- 12) Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan.
- 13) Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dan keluarga pada area spesifik.
- 14) Menerapkan *caring* yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien di area spesifik.
- 15) Menerapkan prinsip kerjasama interdisiplin.
- 16) Melaksanakan pengendalian mutu asuhan keperawatan di unit.
- 17) Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesifik.
- 18) Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesifik.
- 19) Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesifik dan rencana tindak lanjut.
- 20) Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesifik.
- 21) Menginterpretasi hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
- 22) Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
- 23) Melakukan riset keperawatan deskriptif analitik dan inferensial.
- 24) Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 25) Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
- 26) Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
- 27) Menunjukkan sikap asertif.
- 28) Menunjukkan sikap etik.
- 29) Menunjukkan sikap empati.
- 30) Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
- 31) Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
- 32) Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
- 33) Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

d. Perawat Klinis IV

Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota. Kompetensi perawat klinis IV yaitu



- 1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melakukan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 3) Mendesain instrumen pengkajian kebutuhan masyarakat dan masalah kesehatan masyarakat memperhatikan faktor risiko atau kerentanan kesehatan.
- 4) Menetapkan indikator pengukuran data yang menunjang masalah keperawatan kesehatan masyarakat.
- 5) Menetapkan masalah kesehatan prioritas untuk selanjutnya dilakukan survei mawas diri (SMD).
- 6) Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 7) Membuat peta masalah kesehatan di tingkat kabupaten atau kota.
- 8) Mengidentifikasi berbagai sumber dan potensi yang mendukung penyelesaian masalah keperawatan kesehatan masyarakat.
- 9) Melakukan pengolahan data dengan perhitungan statistik berdasarkan hasil survei mawas diri.
- 10) Melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari hasil pengkajian komunitas di tingkat kabupaten atau kota.
- 11) Merumuskan diagnosa keperawatan kesehatan komunitas.
- 12) Menyusun *plan of action* (POA) untuk menyelesaikan masalah keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 13) Mengelola kelompok khusus tingkat kabupaten atau kota.
- 14) Melakukan surveilans atau pelacakan kasus masalah kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 15) Melakukan bimbingan atau pembinaan kesehatan masyarakat berdasarkan sasaran program kesehatan prioritas di tingkat kabupaten atau kota.
- 16) Membuat peta wilayah rawan masalah kesehatan berdasarkan kasus penyakit di tingkat kabupaten atau kota.
- 17) Mengorganisir pemantauan kasus penyakit ditiap wilayah kecamatan.
- 18) Melakukan kerjasama dengan sumber daya masyarakat untuk kegiatan promotif dan preventif.
- 19) Melakukan "kampanye hidup sehat" di tingkat Kabupaten/Kota.
- 20) Mampu menampilkan kemampuan leadership secara efektif.
- 21) Mampu mengelola pelayanan keperawatan komunitas di tingkat Kabupaten/Kota.

- 22) Melakukan rujukan kasus atau masalah kesehatan kepada pihak yang lebih kompeten.
- 23) Melakukan pembinaan kesehatan terhadap kelompok risiko tinggi atau rentan.
- 24) Monitoring dan evaluasi triwulan dan tahunan.
- 25) Menyusun laporan tahunan pembinaan kesehatan wilayah di tingkat kabupaten atau kota.
- 26) Membuat resume singkat tolak ukur keberhasilan pembinaan wilayah untuk masing-masing kecamatan.
- 27) Menetapkan rencana kerja tahun yang akan datang berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi.
- 28) Melakukan advokasi kesehatan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- 29) Menunjukkan keterlibatan dalam membuat kebijakan kesehatan dan sosial.
- 30) Memberikan umpan balik, saran perubahan di lingkungan praktiknya di tingkat kabupaten atau kota.
- 31) Melaksanakan upaya peningkatan profesional dalam praktik keperawatan Kompetensi PK IV.
- 32) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab profesi.
- 33) Mengembangkan kompetensi diri sebagai PK IV.
- 34) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada Perawat Klinis III.

e. Perawat Klinis V

Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialisik, melakukan tata kelola klinis secara transdisiplin, melakukan riset klinis untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan. Kompetensi perawat klinis V yaitu:

- 1) Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien yang kompleks di area spesialisik.
- 2) Merumuskan strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
- 3) Menganalisis potensi risiko klinis dari intervensi keperawatan.
- 4) Menerapkan prinsip dan model kerjasama secara interdisiplin/interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.
- 5) Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan.
- 6) Mengembangkan metode penugasan berdasarkan bukti ilmiah.
- 7) Merumuskan indikator kinerja kunci pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialisik sebagai acuan penilaian.

- 8) Mengembangkan metoda perbaikan mutu asuhan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
- 9) Menggunakan filosofi dasar keperawatan sebagai dasar keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan spesialistik.
- 10) Menyediakan pertimbangan klinis sebagai konsultan dalam asuhan keperawatan klien dengan masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
- 11) Melakukan pembinaan tata laku dan pertimbangan etik profesi, legal dalam lingkup pelayanan keperawatan.
- 12) Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik, masalah klien yang kompleks di area spesialistik sebagai konsultan.
- 13) Menyusun strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
- 14) Menggunakan model kerjasama secara interdisiplin/interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.
- 15) Melakukan pemberian konsultasi klinis dalam asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kompleks pada area spesialistik.
- 16) Mengembangkan berbagai alternatif intervensi keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
- 17) Mengembangkan sistem dalam menjaga mutu asuhan keperawatan secara keberlanjutan.
- 18) Melaksanakan konsultasi dan edukasi kesehatan baik bagi peserta didik, sejawat, klien, maupun mitra profesi sesuai kebutuhan.
- 19) Menyediakan advokasi sebagai konsultan dalam pelaksanaan preceptorship dan mentorship.
- 20) Mengevaluasi hasil penelitian untuk merumuskan intervensi keperawatan.
- 21) Melakukan riset keperawatan semi eksperimental dan eksperimental.
- 22) Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 23) Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
- 24) Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
- 25) Menunjukkan sikap asertif.
- 26) Menunjukkan sikap empati.
- 27) Menunjukkan sikap etik.
- 28) Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
- 29) Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.

- 30) Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
- 31) Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

- **Level Karir dan Kompetensi Perawat di Pelayanan Primer**

Kompetensi perawat di pelayanan primer saat ini difokuskan pada kompetensi perawat komunitas secara umum. Kedepan akan dikembangkan kompetensi perawat klinis di pelayanan primer menjadi lima sub bidang yang terdiri dari kompetensi perawat komunitas, perawat keluarga, perawat gerontik, perawat kesehatan kerja dan perawat kesehatan sekolah. Kompetensi sesuai level pada perawat klinis yaitu :

a. Perawat Klinis I

Perawat Klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan individu dalam konteks keluarga di tatanan pelayanan primer atau di wilayah RW atau Dusun atau setaraannya. Kompetensi perawat klinis I yaitu :

- 1) Melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan kode etik, kebijakan lokal dan nasional
- 2) Melakukan praktik keperawatan memperhatikan hak klien terkait privasi, memperoleh informasi, kerahasiaan dan keamanan informasi, rasa aman dan bermartabat dan budaya
- 3) Melakukan pengkajian kesehatan individu setiap anggota keluarga, baik berisiko maupun mempunyai masalah kesehatan
- 4) Melakukan pemeriksaan fisik seluruh individu di dalam keluarga
- 5) Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan individu
- 6) Mengidentifikasi kemampuan individu dan keluarga dalam penanggulangan masalah kesehatan individu di keluarga
- 7) Melakukan analisis data dan merumuskan diagnosa keperawatan individu dalam konteks keluarga
- 8) Melakukan penapisan masalah keperawatan individu di keluarga dan fasilitas sarana primer
- 9) Menetapkan tujuan pelayanan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu di keluarga
- 10) Menetapkan rencana intervensi keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dengan melibatkan peran serta keluarga
- 11) Melakukan tindakan keperawatan, penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar individu di sarana pelayanan primer atau di keluarga
- 12) Melakukan evaluasi melalui penilaian tercapainya tujuan pemenuhan kebutuhan dasar individu

- 13) Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan format asuhan keperawatan individu dalam konteks keluarga
- 14) Melakukan rujukan klien kepada perawat atau fasilitas pelayanan kesehatan setingkat lebih tinggi apabila mengidentifikasi kebutuhan penanganan di luar kewenangan PK I
- 15) Melaksanakan upaya peningkatan profesional dalam praktik keperawatan melalui keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah
- 16) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab profesi

b. Perawat Klinis II

Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistik pada klien secara mandiri dan mengelola klien/sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut/kompleks. Kompetensi perawat klinis II yaitu:

- 1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga
- 3) Melakukan pengkajian kesehatan keluarga baik berisiko maupun mempunyai masalah kesehatan
- 4) Mengidentifikasi faktor risiko masalah kesehatan keluarga
- 5) Mengidentifikasi sumber daya keluarga sebagai faktor pendukung kesehatan keluarga
- 6) Melakukan analisis data hasil pengkajian keluarga secara komprehensif
- 7) Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga
- 8) Melakukan penapisan masalah keperawatan keluarga
- 9) Menyusun rencana intervensi keperawatan keluarga
- 10) Mengimplementasikan tindakan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan melibatkan anggota keluarga
- 11) Melakukan penemuan kasus (*case finding*) pada keluarga berisiko
- 12) Melakukan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan keluarga
- 13) Melakukan pendampingan (*coaching*) pada keluarga dengan masalah kesehatan
- 14) Melakukan konseling individu dengan masalah kesehatan
- 15) Melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan dengan memperhatikan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan perawatan keluarga

- 16) Melakukan rujukan penanganan masalah yang memerlukan penanganan di luar kewenangannya
- 17) Menggunakan hasil penelitian (*evidence based practice*) dalam praktik keperawatan keluarga
- 18) Menganalisis asuhan keperawatan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan keluarga
- 19) Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan format asuhan keperawatan keluarga
- 20) Menunjukkan keterlibatan dalam pengembangan praktik keperawatan profesional
- 21) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab profesi
- 22) Menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan ilmiah keperawatan dengan mengikuti seminar, pelatihan, workshop keperawatan
- 23) Melaksanakan tugas sebagai mentor bagi PK I

c. Perawat Klinis III

Perawat Klinis III adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan kelompok di komunitas atau di seting khusus (sekolah, industri, panti, lapas) di wilayah kecamatan. Kompetensi Perawat Klinis III, yaitu:

- 1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melaksanakan asuhan keperawatan kelompok
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kelompok
- 3) Melakukan pengkajian kesehatan kelompok baik berisiko maupun mempunyai masalah kesehatan
- 4) Melakukan skrining kelompok yang berisiko tinggi
- 5) Membuat peta masalah kesehatan kelompok
- 6) Memimpin Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- 7) Melakukan analisis data dari berbagai sumber untuk menegaskan diagnosa keperawatan kelompok
- 8) Melakukan penapisan masalah kelompok berdasarkan prioritas masalah keperawatan kelompok
- 9) Menyusun rencana intervensi keperawatan pada kelompok berdasarkan tiga level pencegahan
- 10) Melakukan berbagai jenis tindakan keperawatan berbasis komunitas dengan pendekatan promotif dan preventif
- 11) Mendokumentasikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

- 12) Mengelola kelompok swabantu (self help group) di masyarakat atau di seting khusus sesuai kebutuhan
- 13) Melakukan penemuan kasus (*case finding*) pada kelompok di masyarakat dan di seting khusus
- 14) Melakukan pendampingan (*coaching*) pada kelompok dengan masalah kesehatan
- 15) Melakukan konseling kelompok dengan masalah kesehatan
- 16) Melakukan tindakan pencegahan cedera pada kelompok risiko tinggi
- 17) Melakukan pembinaan kader
- 18) Melakukan kampanye hidup bersih dan sehat
- 19) Menyusun proposal promosi kesehatan pada kelompok
- 20) Melaksanakan kerja tim kesehatan pada kelompok
- 21) Menampilkan kemampuan leadership secara efektif
- 22) Mampu mengelola pelayanan keperawatan komunitas di tingkat kabupaten/ kota
- 23) Melakukan rujukan kasus kelompok sesuai dengan jenjang sistem rujukan
- 24) Menggunakan hasil riset dalam pemberian asuhan keperawatan kelompok
- 25) Menyusun laporan program kesehatan pada kelompok
- 26) Melakukan surveilans terhadap potensi wabah di masyarakat tingkat kecamatan
- 27) Melakukan monev program kesehatan tingkat kecamatan
- 28) Menyusun rencana strategis program kesehatan tingkat kecamatan
- 29) Melakukan advokasi kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan
- 30) Melakukan analisis pencapaian program kesehatan tingkat kecamatan
- 31) Melakukan bimbingan teknis kepada mahasiswa keperawatan
- 32) Melakukan bimbingan teknis dan supervise kepada perawat klinis II

d. Perawat Klinis IV

Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota. Kompetensi perawat klinis IV yaitu:

- 1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melakukan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.

- 3) Mendesain instrumen pengkajian kebutuhan masyarakat dan masalah kesehatan masyarakat memperhatikan faktor risiko atau kerentanan kesehatan.
- 4) Menetapkan indikator pengukuran data yang menunjang masalah keperawatan kesehatan masyarakat.
- 5) Menetapkan masalah kesehatan prioritas untuk selanjutnya dilakukan survei mawas diri (SMD).
- 6) Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 7) Membuat peta masalah kesehatan di tingkat kabupaten atau kota.
- 8) Mengidentifikasi berbagai sumber dan potensi yang mendukung penyelesaian masalah keperawatan kesehatan masyarakat.
- 9) Melakukan pengolahan data dengan perhitungan statistik berdasarkan hasil survei mawas diri.
- 10) Melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari hasil pengkajian komunitas di tingkat kabupaten atau kota.
- 11) Merumuskan diagnosa keperawatan kesehatan komunitas.
- 12) Menyusun *plan of action* (POA) untuk menyelesaikan masalah keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 13) Mengelola kelompok khusus tingkat kabupaten atau kota.
- 14) Melakukan surveilans atau pelacakan kasus masalah kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota.
- 15) Melakukan bimbingan atau pembinaan kesehatan masyarakat berdasarkan sasaran program kesehatan prioritas di tingkat kabupaten atau kota.
- 16) Membuat peta wilayah rawan masalah kesehatan berdasarkan kasus penyakit di tingkat kabupaten atau kota.
- 17) Mengorganisir pemantauan kasus penyakit di tiap wilayah kecamatan.
- 18) Melakukan kerjasama dengan sumber daya masyarakat untuk kegiatan promotif dan preventif.
- 19) Melakukan "kampanye hidup sehat" di tingkat Kabupaten/Kota.
- 20) Mampu menampilkan kemampuan leadership secara efektif.
- 21) Mampu mengelola pelayanan keperawatan komunitas di tingkat Kabupaten/Kota.
- 22) Melakukan rujukan kasus atau masalah kesehatan kepada pihak yang lebih kompeten.
- 23) Melakukan pembinaan kesehatan terhadap kelompok risiko tinggi atau rentan.
- 24) Monitoring dan evaluasi triwulan dan tahunan.



- 25) Menyusun laporan tahunan pembinaan kesehatan wilayah di tingkat kabupaten atau kota.
- 26) Membuat resume singkat tolak ukur keberhasilan pembinaan wilayah untuk masing-masing kecamatan.
- 27) Menetapkan rencana kerja tahun yang akan datang berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi.
- 28) Melakukan advokasi kesehatan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- 29) Menunjukkan keterlibatan dalam membuat kebijakan kesehatan dan sosial.
- 30) Memberikan umpan balik, saran perubahan di lingkungan praktiknya di tingkat kabupaten atau kota.
- 31) Melaksanakan upaya peningkatan profesional dalam praktik keperawatan Kompetensi PK IV.
- 32) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab profesi.
- 33) Mengembangkan kompetensi diri sebagai PK IV.
- 34) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada Perawat Klinis III.

e. Perawat Klinis V

Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan memberikan asuhan keperawatan masyarakat dengan masalah kesehatan kompleks di tingkat provinsi. Kompetensi perawat klinis V yaitu:

- 1) Menunjukkan perilaku bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional dalam melakukan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 2) Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan masyarakat.
- 3) Mendesain instrumen pengkajian kebutuhan masyarakat dan masalah kesehatan kompleks dengan memperhatikan faktor risiko atau kerentanan kesehatan.
- 4) Menetapkan indikator pengukuran data yang menunjang masalah keperawatan kesehatan masyarakat yang kompleks.
- 5) Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi.
- 6) Mengidentifikasi berbagai sumber dan potensi yang mendukung penyelesaian masalah keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi.
- 7) Melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari hasil pengkajian komunitas di tingkat provinsi.
- 8) Merumuskan diagnosa keperawatan kesehatan komunitas.

- 9) Menyusun *plan of action* (POA) untuk menyelesaikan masalah keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi.
- 10) Melakukan surveilans atau pelacakan kasus masalah kesehatan masyarakat di tingkat provinsi.
- 11) Melaksanakan peran konsultan di bidang keperawatan komunitas.
- 12) Menunjukkan keterlibatan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan nasional maupun global.
- 13) Melakukan advokasi untuk penyelesaian masalah kesehatan komunitas di tingkat provinsi.
- 14) Melaksanakan advokasi terhadap pengambil keputusan di wilayahnya dalam upaya promosi kesehatan.
- 15) Menerapkan prinsip-prinsip negosiasi, manajemen konflik dan politik untuk penyelesaian masalah kesehatan masyarakat
- 16) Mengkoordinasikan pengembangan dan implementasi program promosi kesehatan
- 17) Mampu menampilkan kemampuan leadership secara efektif
- 18) Mampu mengelola pelayanan keperawatan komunitas di tingkat provinsi.
- 19) Melakukan keterampilan interpersonal yang baik meliputi komunikasi efektif, penilaian dan *coaching*, supervise eksternal, kerjasama antar tim, dan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah keperawatan komunitas.
- 20) Menunjukkan keterlibatan dalam penentuan legislasi yang mempengaruhi praktik keperawatan.
- 21) Mengaplikasikan penelitian yang relevan dalam praktik keperawatan komunitas berdasarkan *evidence based practice*.
- 22) Menunjukkan keterlibatan dalam mengembangkan kemitraan interdisiplin dan intersektoral dalam meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan komunitas.
- 23) Menyusun laporan tahunan pembangunan kesehatan di tingkat provinsi.
- 24) Membuat resume singkat tolok ukur keberhasilan pembinaan wilayah untuk masing-masing kabupaten/ kota.
- 25) Menghasilkan riset keperawatan semi eksperimen dan eksperimen. etapkan rencana kerja tahun yang akan datang berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi.
- 26) Menghasilkan riset keperawatan semi eksperimen dan eksperimen.
- 27) Melakukan analisis hasil penelitian untuk merumuskan intervensi keperawatan.
- 28) Melaksanakan upaya peningkatan profesional dalam praktik keperawatan kompetensi PK V.

- 29) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggung jawab profesi.
- 30) Mengembangkan kompetensi diri sebagai PK V.
- 31) Melaksanakan tugas sebagai pembimbing atau mentor bagi PK IV.

#### **I. Alternatif Solusi**

Alternatif solusi yang dapat dilakukan melalui prinsip pengembangan Jenjang Karir Perawat Klinik berdasarkan Permenkes No. 40 (2017) meliputi :

- a. Kualifikasi  
Kualifikasi perawat, dimulai dari lulusan D III Keperawatan. Mengingat perawat yang ada saat ini sebagian besar lulusan SPK, maka perlu dilakukan penanganan khusus dengan memperhatikan penghargaan terhadap pengalaman kerja, lamanya pengabdian terhadap profesi, uji kompetensi dan sertifikasi.
- b. Penjenjangan  
Penjenjangan mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akontabel dan etis sesuai dengan batas kewenangan praktik dan kompleksitas masalah pasien/klien.
- c. Penerapan asuhan keperawatan  
Fungsi utama perawat klinik adalah memberikan asuhan keperawatan langsung sesuai standar praktik dan kode etik perawat.
- d. Pimpinan sarana kesehatan harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan karir perawat, Kesempatan yang sama  
Setiap perawat klinik mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir sampai jenjang karir professional tertinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Standar profesi  
Dalam memberikan asuhan keperawatan mengacu pada standar praktik keperawatan dan kode etik keperawatan.
- f. Komitmen pimpinan  
Pimpinan sarana kesehatan harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan karir perawat, sehingga dapat dijamin kepuasan pasien/klien serta kepuasan perawat dalam pelayanan keperawatan.

#### **J. Plan of Action**

Perencanaan peningkatan jenjang karir perawat harus memenuhi persyaratan jenjang karir perawat. Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Permenkes No. 40 tahun 2017 meliputi :

a. Pendidikan Formal

1) Perawat Klinik I (PK I)

Perawat Klinik I (Novice) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 1$  tahun dan menjalani masa klinis level I selama 3 – 6 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 1$  tahun dan menjalani masa klinis level 1 selama 2 – 4 tahun. Perawat Klinik I harus memiliki sertifikat pra klinis.

2) Perawat Klinik II (PK II)

Perawat Klinik II (*Advance Beginner*) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 4$  tahun dan menjalani masa klinis level II selama 6 – 9 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 3$  tahun dan menjalani masa klinis level II selama 4 – 7 tahun. Perawat Klinik II harus memiliki sertifikat Perawat Klinik I.

3) Perawat Klinik III (PK III)

Perawat Klinik III (*Competent*) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 10$  tahun dan menjalani masa klinis level III selama 9 – 12 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 7$  tahun dan menjalani masa klinis level III selama 6 – 9 tahun atau Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja 0 tahun dan menjalani masa klinis level III selama 2 – 4 tahun. Perawat Klinik III dengan lulusan DIII Keperawatan dan Ners harus memiliki sertifikat Perawat Klinik II.

4) Perawat Klinik IV (PK IV)

Perawat Klinik IV (*Proficient*) memiliki latar belakang pendidikan Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 13$  tahun dan menjalani masa klinis level IV selama 9 – 12 tahun atau Ners Spesialis dengan pengalaman kerja  $\geq 2$  tahun dan menjalani masa klinis level IV selama 6 – 9 tahun. Perawat Klinik IV harus memiliki sertifikat Perawat Klinik III.

5) Perawat Klinik V (PK V)

Perawat Klinik V (*Expert*) memiliki latar belakang pendidikan Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja  $\geq 4$  tahun dan mempunyai sertifikat PK IV atau Ners Spesialis II (Konsultan) dengan pengalaman kerja 0 tahun dan menjalani masa klinis level IV selama 6 – 9 tahun. Perawat Klinik V menjalani level V sampai memasuki usia pension.

b. Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Kompetensi (sertifikasi)

1) Perawat Klinik I (PK I)

Perawat Klinik I (Novice) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 1$  tahun dan menjalani masa klinis level I selama 3 – 6 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 1$  tahun dan menjalani masa klinis level 1 selama 2 – 4 tahun. Perawat Klinik I harus memiliki sertifikat pra klinis.

2) Perawat Klinis II (PK II)

Perawat Klinik II (*Advance Beginner*) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 4$  tahun dan menjalani masa klinis level II selama 6 – 9 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 3$  tahun dan menjalani masa klinis level II selama 4 – 7 tahun. Perawat Klinik II harus memiliki sertifikat Perawat Klinik I.

3) Perawat Klinis III (PK III)

Perawat Klinik III (*Competent*) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 10$  tahun dan menjalani masa klinis level III selama 9 – 12 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 7$  tahun dan menjalani masa klinis level III selama 6 – 9 tahun atau Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja 0 tahun dan menjalani masa klinis level III selama 2 – 4 tahun. Perawat Klinik III dengan lulusan DIII Keperawatan dan Ners harus memiliki sertifikat Perawat Klinik II dan sertifikasi teknikal.

4) Perawat Klinis IV (PK IV)

Perawat Klinik IV (*Proficient*) memiliki latar belakang pendidikan DIII Keperawatan dengan pengalaman kerja  $\geq 19$  tahun dan menjalani masa klinis level IV sampai memasuki usia pensiun atau Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 13$  tahun dan menjalani masa klinis level IV selama 6 – 9 tahun. Perawat Klinik IV harus memiliki sertifikat Perawat Klinik III dan sertifikasi teknikal II.

5) Perawat Klinis V (PK V)

Perawat Klinik V (*Expert*) memiliki latar belakang pendidikan Ners dengan pengalaman kerja  $\geq 22$  tahun dan menjalani masa level V sampai memasuki usia pensiun. Perawat Klinik V harus memiliki sertifikasi PK IV dan sertifikasi teknikal II.

c. Pengembangan Pendidikan Berkelanjutan

Program pengembangan pendidikan berkelanjutan disusun sesuai dengan kompetensi pada setiap level karir seperti diuraikan di bawah ini.

| LEVEL | PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK I  | 1. Asuhan Keperawatan : 12 kompetensi inti<br>2. Komunikasi Therapeutik<br>3. Keselamatan klien<br>4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi<br>5. <i>Caring</i><br>6. Etika Profesi<br>7. Keperawatan Gawat Darurat Dasar (EN Basic)<br>8. Keperawatan Bencana Basic<br>9. Sistem Informasi Keperawatan |
| PK II | 1. Asuhan Keperawatan Umum<br>2. Pengelolaan Asuhan keperawatan dalam tim<br>3. Kerja Tim Keperawatan<br>4. Preceptorship                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 5. Pendidikan Kesehatan<br>6. Praktik Berbasis Bukti Diskusi Refleksi Kasus<br>7. Metodologi Riset Dasar (Deskriptif dan Survey)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PK III | 1. Asuhan Keperawatan pada Area Spesifik<br>2. Keperawatan Gawat Darurat Intermediate<br>3. Keperawatan Bencana Advance<br>4. Keperawatan Kritis Basic<br>5. Pengelolaan asuhan keperawatan di ruangan<br>6. Menerapkan agen pembaharu terkait asuhan melalui evidence based practice<br>7. Audit asuhan Keperawatan<br>8. Metode mencari akar masalah/RCA<br>9. Manajemen Risiko terkait asuhan keperawatan<br>10. Manajemen Konflik<br>11. Kolaborasi intra dan interdisiplin<br>12. Menyusun satuan pengajaran Pendidikan Kesehatan<br>13. Metodologi Riset lanjutan (Analitik dan Differensial) |
| PK IV  | 1. Asuhan Keperawatan Spesialistik<br>2. Keperawatan Gawat Darurat Advance<br>3. Keperawatan Kritis Advance<br>4. Keterampilan klinis spesialis<br>5. Case manajer<br>6. Metodologi pendidikan kesehatan sasaran kelompok/masyarakat dan klien dengan masalah kesehatan kompleks<br>7. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)<br>8. Praktik Berbasis Bukti Lanjutan<br>9. Teknik Penyusunan Jurnal                                                                                                                                                                                                 |
| PK V   | 1. Asuhan Keperawatan Sub Spesialis<br>2. Keterampilan Klinis Sub spesialis<br>3. Manajemen asuhan Keperawatan di RS<br>4. Manajemen strategik asuhan keperawatan<br>5. Manajemen Konseling<br>6. Metodologi pendidikan kesehatan sasaran kelompok/masyarakat dan klien dengan masalah kesehatan kompleks<br>7. Metodologi Riset <i>clinical trial</i> , eksperimen, kuasi eksperimen                                                                                                                                                                                                               |

## K. Implementasi

Implementasi jenjang karir perawat klinis dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan perkembangan karirnya baik sebagai perawat baru, perawat lama maupun perawat pindah tugas. Perawat baru adalah perawat yang baru lulus pendidikan dan atau baru pertama kali bekerja dengan masa kerja 0-1 tahun dan perawat lama adalah perawat dengan masa kerja lebih dari 1 tahun (Permenkes No. 40 (2017)).

a. Implementasi jenjang karir perawat baru

Implementasi jenjang karir bagi perawat baru terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1) Rekrutmen dan seleksi

Rekrutmen dan seleksi staf baru dilaksanakan oleh RS dibawah koordinasi divisi sumber daya manusia/ SDM dengan keperawatan. Seleksi meliputi seleksi administrasi, kelayakan sehat fisik serta psikologis dan kredensial edukasi yang meliputi keaslian ijazah, transkrip nilai, sertifikat uji kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Kredensial terhadap asuhan kritis bisa dipersyaratkan sesuai kebijakan organisasi. Seleksi dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu seleksi administrative, psikotes, wawancara, kredensial, dan validasi kompetensi (sesuai dengan kebijakan organisasi).

2) Orientasi

Orientasi adalah proses memberikan informasi, pengenalan dan indoktrinasi staf baru. Orientasi dibagi menjadi 2 tahap yaitu orientasi umum yang meliputi Visi, Misi, Kebijakan organisasi, hak dan kewajiban staf, keselamatan klien, pengendalian dan pengontrolan infeksi, mutu pelayanan, caring, etik dan asuhan keperawatan serta dokumentasi asuhan keperawatan. Orientasi khusus adalah orientasi setelah penempatan di unit kerja yang meliputi visi, misi, kebijakan, hak dan kewajiban di unit kerja.

3) Internship/ Magang

Internship/ magang merupakan proses melaksanakan asuhan di unit kerja bersama preceptor. Preceptor menjadi role model dari perawat baru, mengarahkan dan mengevaluasi pencapaian kompetensi serta melaksanakan asuhan bersama dengan perawat baru. Preceptorship dilaksanakan melalui *one to one*, dimana preceptor tidak hanya menjadi role model dalam melaksanakan asuhan keperawatan tetapi juga memberikan motivasi serta membantu proses adaptasi dari staf baru. Perawat baru akan mengikuti siklus dinas dari preceptor dan dalam proses preceptorship akan dievaluasi pencapaian kompetensi sesuai level karir. Pencapaian kompetensi didokumentasikan dalam logbook dan preceptor akan mengevaluasi apakah perawat baru sudah mampu secara mandiri dalam melaksanakan asuhan. Apabila staf baru telah mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara mandiri maka staf baru telah dapat melaksanakan asuhan secara mandiri di level karir PK I. Daftar kompetensi dan evaluasi bersama dengan preceptor diusulkan sebagai logbook dan portofolio untuk asesmen kompetensi dan untuk mendapatkan penugasan klinis secara mandiri sesuai dengan level karirnya.

#### 4) Kredensial:

##### a) Asesmen Kompetensi

Perawat baru yang telah melalui proses internship dengan preceptor serta telah dilaksanakan evaluasi proses oleh preceptor dan juga didokumentasikan dalam log book dapat mengajukan permohonan assesment kompetensi. Pengelolaan asesmen kompetensi menjadi tanggung jawab kepala bidang keperawatan. Tahapan assesmen kompetensi terdiri dari:

- (1) Self evaluasi, verifikasi log book dan porto folio.
- (2) Mengajukan permohonan assesmen diketahui dan setuju oleh preceptor dan kepala ruangan.
- (3) Melaksanakan pra konsultasi, untuk validasi kesiapan asesmen dan kontrak pelaksanaan asesmen.
- (4) Pelaksanaan asesmen untuk kompetensi PK I oleh asesor.
- (5) Melaksanakan usulan banding (jika diperlukan).
- (6) Pengambilan keputusan hasil asesmen kompetensi.
- (7) Pemberian Sertifikat Kompetensi bagi perawat yang kompeten.

##### b) Penetapan Kewenangan Klinik

Kredensial pemberian kewenangan klinik dilakukan oleh Komite Keperawatan Rumah Sakit. Perawat yang mengusulkan kewenangan klinik dipersyaratkan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- (1) Mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite Keperawatan sesuai Rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih (*White Paper*).
- (2) Mengikuti proses kredensial dengan cara review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode yang dilakukan oleh panitia Adhoc (Mitra Bestari) yang ditentukan.
- (3) Memperoleh hasil kredensialing berupa daftar kewenangan klinis bagi perawat klinis level PK I selanjutnya direkomendasikan oleh Komite Keperawatan untuk mendapatkan surat penugasan klinis dari pimpinan/direktur rumah sakit.

##### c) Pemberian Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) PK I

Perawat baru yang telah mendapatkan rekomendasi kewenangan klinis oleh Komite Keperawatan akan diusulkan memperoleh surat penugasan klinis oleh direktur rumah sakit, dalam bentuk penerbitan surat keputusan penugasan klinis. Surat Penugasan Klinis merupakan izin dari pimpinan/Direktur rumah sakit untuk melaksanakan praktik dengan kewenangan klinik yang telah diberikan.



e. Praktik di rumah sakit

Perawat mendapatkan penugasan di unit kerja sesuai dengan penugasan klinis (*clinical appointment*) yang telah ditetapkan. Berdasarkan penugasan klinis perawat menyusun uraian tugas. Dan melaksanakan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan dengan mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui program Pengembangan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) yang telah ditentukan. Kompetensi perawat terus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan PKB yang telah ditetapkan di komite keperawatan melalui program mutu profesi.

f. Kenaikan Penjenjangan Karir Klinis

Setiap perawat mempunyai hak untuk meningkatkan jenjang karir sesuai perencanaan karir yang telah dipilih. Setelah melaksanakan tugas memberikan asuhan keperawatan dan mempunyai kompetensi asuhan pada level karir di atasnya maka perawat dapat mengusulkan kenaikan tingkat dengan tahapan kredensial dan selanjutnya melaksanakan tugas pada jenjang yang baru. Kenaikan jenjang karir perawat hendaknya diiringi dengan kenaikan penghargaan yang berupa remunerasi. Bagi perawat yang belum memenuhi persyaratan untuk naik tingkat dilakukan pembinaan khusus dan jika selama 2 tahun tetap tidak memenuhi persyaratan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang disepakati.

d. Implementasi jenjang karir perawat lama

Implementasi jenjang karir bagi perawat lama terdiri dari tahapan sebagai berikut :

1. Pemetaan (*mapping*)

Bagi rumah sakit yang belum melaksanakan jenjang karir perawat dan akan melaksanakan, maka sebagai tahap awal melakukan *mapping*/ pemetaan. Mapping atau pemetaan adalah suatu proses menetapkan level perawat lama sesuai penjenjangan karir dengan prasyarat yang ditetapkan sesuai kebijakan masing-masing rumah sakit.

Pemetaan peringkat karir dilaksanakan berdasarkan persyaratan setiap peringkat oleh tim bidang keperawatan untuk menetapkan kelayakan perawat pada level PK sesuai kompetensinya. Pemetaan perangkat karir dinilai berdasarkan pendidikan dan pengalaman asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan, hasil penilaian kinerja klinis dan divalidasi melalui assesmen kompetensi. Setelah asesmen kompetensi perawat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai peringkat.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- 1) Survey data dasar perawat saat ini berdasarkan kualifikasi sebagai berikut : Nama, Pendidikan Keperawatan terakhir, Pelatihan, lama bekerja, umur, golongan/ pangkat atau level (jika ada).
- 2) Melakukan review dan analisis hasil survey data dasar untuk menetapkan level setiap perawat.
- 3) Menyusun rekapitulasi profil perawat berdasarkan penjenjangan karir hasil review.
- 4) Setelah dilakukan pemetaan, setiap perawat mengikuti assesmen kompetensi sesuai level hasil pemetaan.

2. Kredensial:

a) Asesmen Kompetensi

Asesmen kompetensi dilakukan untuk memvalidasi kompetensi yang harus dimiliki sesuai hasil mapping. Tahapan assesmen kompetensi terdiri dari :

- (1) Mengajukan permohonan assesmen
- (2) Asesmen Mandiri
- (3) Pra konsultasi
- (4) Asesmen
- (5) Usulan banding (jika perlu)
- (6) Keputusan hasil assesmen
- (7) Pemberian Sertifikat Kompetensi

b) Penetapan Kewenangan Klinik sesuai dengan penjenjangan karirnya (PK I, II, III, IV dan V)

Pada tahap ini dilakukan review, evaluasi terhadap bukti-bukti untuk menetapkan kewenangan klinis setiap perawat sesuai dengan masing-masing penjenjangan. Adapun tahap kredensial sama dengan kredensial PK I.

c) Pemberian Penugasan Klinis bagi PK I, II, III, IV dan V

Pemberian penugasan klinis dilakukan oleh Pimpinan/Direktur RS. Perawat yang telah dilakukan kredensial akan direkomendasi untuk memperoleh penugasan klinis oleh Pimpinan/Direktur RS dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.

3. Penugasan Kerja sesuai dengan Area Praktiknya

Perawat melaksanakan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan Surat Keputusan Penugasan Klinis yang telah diberikan. Selain itu perawat dituntut untuk mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui program-program Pengembangan Profesional, Personal dan Kualitas Berkelanjutan bagi perawat. Perawat lama (PK I,II, III, IV, V) melaksanakan tugas baik secara individu atau tim, saling

membimbing dan dilakukan supervisi berjenjang, setiap perawat memiliki *Logbook* dan diisi secara benar.

4. Kenaikan Tingkat Penjenjangan Klinis

Sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan bagi setiap perawat lama, maka perawat berhak mengajukan permohonan untuk kenaikan jenjang karir dan mengikuti proses kredensialing. Selanjutnya melaksanakan tugas pada jenjang yang baru dan bagi perawat lama mempunyai hak untuk promosi ke jabatan yang baru. Kenaikan level karir profesional hendaknya diikuti dengan kenaikan penghargaan berupa kenaikan renumerasi. Bagi perawat lama yang 2 x 3 tahun belum memenuhi syarat untuk kenaikan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.

**L. Evaluasi**

Evaluasi jenjang karir perawat untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan jenjang karir di pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun pelayanan primer. Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil pelaksanaan jenjang karir perawat (Permneks No. 40, 2017).

1. Evaluasi proses pelaksanaan jenjang karir perawat

Evaluasi proses berupa *check list* laporan/ dokumen lainnya. Evaluasi dilakukan melalui laporan dan dokumentasi/ system informasi jenjang karir perawat yang meliputi :

1. Pengorganisasian jenjang karir,
2. Terlaksananya program orientasi,
3. Terlaksananya program internship,
4. Terlaksananya mapping (pemetaan) perawat lama,
5. Terlaksananya assesmen (perawat lama dan baru),
6. Terlaksananya proses kredensialing perawat,
7. Terlaksananya proses re-kredensial,
8. Terlaksananya program pengembangan profesional berkelanjutan,
9. Terlaksananya program kenaikan tingkat jenjang karir,
10. Tersedia data dasar profil perawat dan perkembangan setiap tahun.

2. Evaluasi hasil pelaksanaan jenjang karir perawat

Evaluasi hasil implementasi jenjang karir perawat memiliki 4 aspek yaitu komponen, indikator, pengukuran dan hasil. Hasil implementasi jenjang karir perawat akan memberikan pengaruh kepada klien, perawat, pelayanan keperawatan dan pelayanan kesehatan. Lingkup pelaksanaan evaluasi hasil implementasi jenjang karir perawat meliputi :

1. Peningkatan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan,
2. Peningkatan kepuasan kerja perawat,

3. Peningkatan kepuasan klien,
4. Peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dan kesehatan.

Instrumen evaluasi hasil dapat berupa kuisioner kepuasan perawat dan kuisioner kepuasan klien. Sedangkan kinerja perawat dan kualitas pelayanan dapat diukur melalui instrument *check list* observasi kinerja, kuisioner dan juga melalui dokumentasi asuhan keperawatan. Kualitas mutu pelayanan juga dinilai melalui indikator mutu layanan keperawatan. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun kemudian dianalisis dan hasilnya menjadi dasar perbaikan proses dan implementasi pengembangan jenjang karir perawat.



# SUPERVISI DALAM KEPERAWATAN



## SUPERVISI DALAM KEPERAWATAN

### A. Pendahuluan

Supervisi keperawatan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Kegiatan ini dilakukan secara profesional berupa pengarahan, bimbingan dan dukungan kepada staf perawat melalui proses yang terstruktur. Seorang supervisor sebagai penanggung jawab perlu dilengkapi dengan pengetahuan dasar manajemen seperti cara membimbing dan mengembangkan stafnya dengan menggunakan bahasa yang tepat, memiliki pemahaman positif dan selalu siap untuk membantu atau memberikan solusi dalam memecahkan masalah. Melalui supervisi, perawat pelaksana dapat mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan serta kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan.

#### Ringkasan Hasil Penelitian

Supervisi merupakan bagian penting dari proses pemberian asuhan keperawatan, dimana terjalinnya kerjasama antar sejawat maupun dengan profesi kesehatan lainnya. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan ini dapat dipakai sebagai alat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan perawat serta manfaat yang signifikan di ruang rawat. Oleh karena itu perawat profesional perlu dilengkapi dengan pelatihan pelaksanaan supervisi keperawatan sehingga mampu melakukan supervisi dengan tepat. Didapatkan juga bahwa sulit untuk seorang manajer keperawatan mempertahankan mutu asuhan keperawatan tanpa melakukan perencanaan supervisi. Seorang supervisor tidak hanya memberi perintah namun harus mampu memberikan motivasi dan berkoordinasi serta mampu memberikan bimbingan. Sedangkan pelaporan supervisi harus progresif, inovatif, fleksibel dan dapat mengembangkan kelebihan masing-masing perawat profesional. (Ginting and Harahap, 2019; Reschke *et al.*, 2021; Rocha, Pinto and Carvalho, 2021)

### B. Definisi

Supervisi oleh profesi keperawatan dipraktikkan secara luas kerana memiliki efek menguntungkan bagi pasien, perawat dan juga organisasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap pengendalian dalam fungsi manajemen yang berperan untuk mengevaluasi, motivasi, membimbing dan mendukung serta mempertahankan upaya manajemen mutu SDM keperawatan. Selain itu melalui supervisi, perawat belajar untuk merancang, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dirinya dalam memecahkan masalah klinis maupun interpersonal staf di ruang rawat serta meningkatkan mutu asuhan yang diberikan.

Depkes, (2019) mendefinisikan supervisi keperawatan adalah kegiatan memberikan pengawasan dan pembinaan staf secara berkesinambungan oleh

supervisor untuk menyelesaikan masalah pelayanan keperawatan, ketenagaan dan peralatan sehingga pasien dapat merasakan pelayanan yang bermutu setiap saat

Sitorus Ratna dan R.Panjaitan (2011) dalam Setiadi, (2016) menjelaskan supervisi sebagai proses formal yang memungkinkan perawat praktisi untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi dan menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai kebijakan dan prosedur serta meningkatkan perlindungan terhadap pasien dan pelayanan keperawatan yang aman dalam situasi yang kompleks.

Supervisi dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan juga evaluasi secara langsung kepada perawat apakah kompeten dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan juga adanya proses diskusi antar sesama perawat maupun dengan (Richard J. Swansburg, 2006; Nursalam, 2011)

Supervisi dalam keperawatan bukan hanya sekedar mengawasi atau mengontrol tetapi sebagai proses memacu individu perawat untuk berkontribusi secara aktif dan positif dalam menyelesaikan masalah maupun memperbaiki proses yang sudah berlangsung untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien (Marquis and Huston, 2017)

Jadi dalam kegiatan supervisi menampilkan dua jenis pelaku yaitu pimpinan atau manajer perawat dan perawat pelaksana atau orang yang disupervisi. Pemimpin dapat melaksanakan pengawasan, menilai seluruh perencanaan kegiatan sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan dan perawat pelaksana mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini dilakukan secara terprogram, terjadwal dan sangat efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu seorang manajer keperawatan maupun perawat profesional diharapkan memiliki kemampuan dalam melaksanakan supervisi

### **C. Tujuan dan Manfaat Supervisi Keperawatan**

Supervisi dilakukan seoptimal mungkin pada lingkungan dan suasana kerja dan kondisi pasien yang nyaman dan juga dibutuhkan persediaan sarana prasarana yang mendukung untuk memudahkan pelaksanaan tugas seperti memeriksa, menilai, mengarahkan dan memperbaiki serta meningkatkan penampilan kerja perawat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. swanburg (2020) dan Sitorus & Panjaitan, (2011) menjelaskan tujuan supervisi:

1. Memfasilitasi staf keperawatan termasuk area kerja dan pekerjaan itu sendiri untuk mengembangkan diri.
2. Memperhatikan rencana, kegiatan dan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan.
3. Meningkatkan kemampuan pekerjaan melalui orientasi, latihan dan bimbingan staf sesuai kebutuhannya serta mengarahkan kepada kemampuan dan mengembangkan keterampilan keperawatan.



4. Memberikan bimbingan kepada staf secara langsung sehingga mampu mengerjakan tanggung jawab pekerjaannya dengan hasil yang baik.
5. Menolong dan mengarahkan staf keperawatan untuk meningkatkan minat, sikap dan kebiasaan yang baik dalam bekerja.
6. Mendorong dan meningkatkan perkembangan professional secara terus menerus dan menjamin standard asuhan.

#### **D. Ruang lingkup**

Supervisi pelayanan keperawatan dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab antara lain kepala ruangan sebagai penanggung jawab ruang rawat dan juga ujung tombak tercapinya tujuan pelayanan mengawasi secara langsung staf keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung pada klien di ruang perawatan sesuai dengan yang didelegasikan. Ruang perawatan dan unit pelayanan di bawah unit pelaksana fungsional mempunyai supervisor yang bertanggung jawab mengawasi kepala ruangan dan juga jalannya pelayanan keperawatan yang ada diinstansinya. Kepala seksi bertugas melakukan supervisi secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa unit pelaksana fungsional yang digabung menjadi satu. Kepala bidang sebagai top manajer keperawatan bertanggung jawab melakukan supervisi kepala seksi dan semua perawat secara langsung maupun tidak langsung. Supervisi berjenjang berkaitan dengan struktur organisasi yang menggambarkan garis tanggung jawab bahwa siapa yang menjadi supervisor dan siapa yang disupervisi. Hal ini dapat disesuaikan dengan metode penugasan pada ruang rawat tersebut.

##### **1. Area Personal Keperawatan**

Supervisor merencanakan kebutuhan ketenagaan keperawatan pada unit meliputi penerimaan tenaga keperawatan saat wawancara, seleksi tenaga sesuai kompetensi dan menjadi tanggung jawabnya, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perawatan di lingkup tanggung jawabnya, menasehati staf perawat untuk dapat disiplin, memotivasi staf agar taat pada standard perawatan yang berlaku, memperbaiki kebijakan dan prosedur apa bila diperlukan, menyimpan semua dokumen sesuai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan masalah staf, mengadakan pembaharuan secara positif, mengatur jadwal dinas staf menjadi fleksibel untuk semua staf, membuat iklim kerja menjadi kondusif bagi staf.

##### **2. Area Lingkungan dan Peralatan**

Kepala ruangan sebagai supervisor bertanggung jawab terhadap area lingkungan dan peralatan seperti menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, terlibat menentukan anggaran yang berkaitan dengan keperawatan, mengevaluasi dan memantau kelengkapan peralatan di ruang lingkup tanggung jawabnya,

membina kerja sama yang baik, membuat laporan dan menjaga komunikasi yang baik.

3. Area Asuhan Keperawatan

Area asuhan keperawatan meliputi menjaga asuhan keperawatan sesuai standard, meningkatkan standard dengan program quality assurance (QA), mengawasi dan mengevaluasi kualitas asuhan keperawatan pasien dan lingkungan, mendokumentasikan asuhan keperawatan, menjadi penasehat dan pelindung pasien, membina komunikasi efektif dengan pasien, keluarga, maupun organisasi profesi lain.

4. Area Pengawasan dan Evaluasi

Supervisi bertanggung jawab mengawasi lingkungan dan mengukur hasil dari proses kerja. Fungsi pengawasan meliputi perhatian terhadap sistem alur kerja, system informasi, model pemberian asuhan kepada pasien, liburan staf, upah staf dan promosi. Evaluasi membantu menentukan hasil pengawasan dan sebagai pedoman untuk mengkaji hasil kerja. Proses supervisi harus menggunakan prosedur yang sistematis untuk mengevaluasi kinerja staf secara rutin.

Karakteristik yang harus dimiliki supervisor adalah:

1. Atasan langsung dari staf perawat yang disupervisi
2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup terkait manajemen asuhan keperawatan
3. Memahami prinsip pokok dan teknik supervisi
4. Memiliki sifat edukatif dan suportif
5. Memiliki banyak waktu untuk berdiskusi dengan perawat pelaksana serta sabar dan selalu berupaya mengupdate hal-hal baru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang disupervisi

## **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Supervisi**

Prinsip Supervisi Klinik Keperawatan

1. Supervisi dilakukan sesuai struktur organisasi
2. Didasarkan atas hubungan profesional dan bukan hubungan pribadi
3. Kegiatan diuraikan secara jelas melalui petunjuk, peraturan, uraian tugas dan standard
4. Bersifat edukatif, suportif dan informal
5. Harus progresif, inovatif, fleksibel dan dapat mengembangkan potensi masing-masing staf perawat yang disupervisi
6. Memberikan perasaan aman pada staf dan pelaksana keperawatan, memiliki tujuan yang jelas
7. Supervisi dilakukan secara objektif

8. Memberi kepuasan pada pasien, staf dan manajer dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan

#### Peran supervisor

Supervisor bertanggung jawab dalam manajemen sesuai area tanggung jawabnya, oleh karena itu supervisor harus menguasai beberapa kompetensi diantaranya adalah (Suyanto 2019, Sitorus & Panjaitan 2011) :

1. Supervisor sebagai *coach*  
Supervisor memberikan pembekalan kepada staf perawat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Staf yang memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan asuhan keperawatan akan menghasilkan nilai akhir yang baik.
2. Supervisor sebagai mentor  
Kompetensi seorang supervisor yang baik adalah memiliki kemampuan dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan fasilitas untuk peningkatan karir staf perawat. Mentoring yang tidak jelas akan sulit dimengerti oleh staf dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi pada proses mentoring. Proses mentoring dapat formal atau non formal. Sebagai mentor seorang supervisor harus memiliki keahlian klinis, pengetahuan, pengalaman, keinginan untuk mengasuh dan komitmen untuk profesi.
3. Supervisor sebagai pemegang kekuasaan  
Supervisor keperawatan dituntut untuk mampu merubah perilaku seseorang sesuai perilaku yang diharapkan. Hubungan dalam proses supervisi sangat penting dengan membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi kepada staf, dan meningkatkan komitmen staf terhadap mutu. Sebagai pemegang kekuasaan supervisor harus lebih peka bagaimana psikologis perawat sehingga ketika perawat tersebut membutuhkan dukungan motivasi dari pihak lain, supervisor mampu memberikannya. Suasana pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, rutinitas, kompleksnya asuhan keperawatan atau masalah pasien membuat perawat tidak bersemangat atau fokus dan jika dalam supervisi hubungan tidak adekuat dapat menimbulkan kebencian, kurangnya motivasi dan *chaos*.
4. Supervisor dan kerja sama  
Supervisor harus memiliki kompetensi berupa kemampuan membangun kerja sama baik secara formal maupun informal. Supervisor yang efektif mengenal penggunaan yang bermanfaat terhadap pemaksaan, tujuan, individual, dan strategi formal sebagai pendekatan dalam tugas. Kemampuan mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan atau kelebihan staf dapat membantu supervisor dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Supervisor memberi latihan dan bimbingan

Memberikan latihan dan bimbingan diperlukan staf perawat. Kemampuan memberikan latihan dan bimbingan seorang supervisor dapat memberi peluang untuk menemukan staf yang belum terampil dalam melakukan asuhan keperawatan. Selain itu supervisor harus dapat menjadi role model dalam memberikan contoh misalnya cara melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SPOnya.

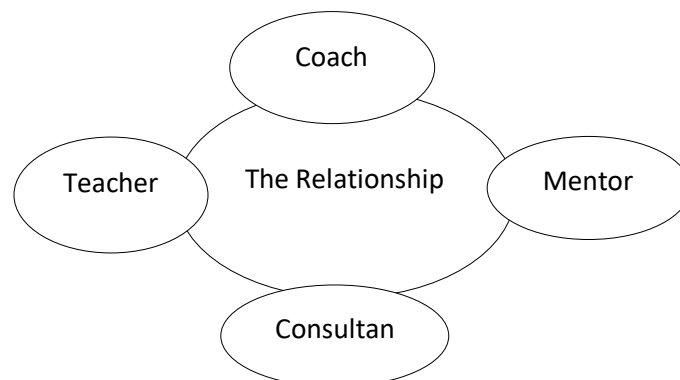
6. Supervisor memberikan penilaian

Supervisi merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi hingga evaluasi dan karena itu seorang supervisor yang efektif harus memiliki kompetensi memberi penilaian. Penilaian yang diberikan pada staf harus objektif sesuai pedoman penilaian yang berlaku dan disepakati di rumah sakit tersebut.

Keterampilan yang harus dimiliki supervisor

*Department of health human service* (2009) dalam Morrissey, (2020) menjelaskan keterampilan seorang supervisor keperawatan adalah sebagai berikut :

1. Teacher, supervisor adalah guru, pelatih dan seorang role model profesional mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dari setiap pelayanan asuhan keperawatan. Dalam hal ini perawat pelaksana memiliki kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.
2. Consultan, memiliki kinerja untuk mengenali masalah serta menentukan alternatif penyelesaian masalah untuk mencapai tujuan bersama.
3. Coach, memberikan dukungan profesional yang terus menerus untuk mengidentifikasi masalah asuhan keperawatan yang dilakukan perawat pelaksana. Masalah dapat terjadi akibat kelelahan kerja atau stress kerja akibat beban kerja. Supervisor harus mampu mengatasi konflik yang terjadi serta tim harus memiliki sikap saling mendukung sehingga memberikan kenyamanan dalam bekerja.
4. Mentor, melalui peran model, supervisor memfasilitasi keterampilan tim dan memberikan kesempatan mengembangkan keterampilan profesional.



**Gambar 3.1 Roles Of The Clinical Supervisor.**

## F. Analisis Situasi

Bahwa sebagai pemimpin atau manajer selama melakukan supervisi harus memperlakukan timnya dengan baik dan terhormat, sehingga mereka merasa dihargai, didengar yang membantu dalam proses pertukaran informasi dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan profesional. Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi secara berkala dan berkelanjutan dengan memantau laporan kegiatan meliputi kenyataan atau kejadian yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan tersebut. Ketidaksesuaian atau penyimpangan menyebabkan adanya perbedaan antara kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan yang benar terjadi yang disebut dengan masalah

Kegiatan analisis dilakukan untuk mengetahui jenis masalah dan faktor penyebab munculnya masalah tersebut dan juga sumber atau potensi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk mendapatkan melaksanakan supervisi maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### Teknik Supervisi

#### 1. Langsung

Supervisi dilakukan secara langsung pada saat kegiatan sedang dilakukan misalnya saat perawat sedang mengisi formulir asuhan keperawatan, dilakukan saat pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan. Supervisor mendampingi perawat dalam mengisi setiap komponen dalam proses keperawatan dimulai dari pengkajian sampai evaluasi.

Cara memberikan bimbingan dan pengarahan yang efektif (Sitorus dan Panjaitan 2011):

- a. Pengarahan diberikan dengan lengkap
- b. Mudah dipahami
- c. Menggunakan kata-kata yang tepat
- d. Berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat
- e. Berikan arahan yang logis
- f. Hindari memberikan banyak arahan pada satu saat secara bersamaan
- g. Pastikan bahwa arahan yang diberikan dipahami
- h. Yakinkan bahwa arahan yang diberikan dilaksanakan serta perlu ditindak lanjuti

#### 2. Tidak langsung

Supervisi dilakukan melalui laporan tertulis maupun lisan. Supervisor tidak melihat langsung kejadian di lapangan sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan fakta. Supervisor memberikan umpan balik secara tertulis.

## Langkah Supervisi

### Pra supervisi

1. Menyusun jadwal supervisi
2. Menetapkan kegiatan yang akan disupervisi
3. Supervisor menetapkan tujuan
4. Mensosialisasikan rencana supervise kepada staf perawat
  - a. Supervisi
5. Mengucapkan salam kepada staf perawat yang disupervisi
6. Mengecek pekerjaan personil
7. Mengarahkan staf sesuai kebutuhan
8. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan instrument / alat ukur yang telah disiapkan
9. Mendiskusikan pencapaian yang telah diperoleh staf perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan
10. Supervisor memanggil PP dan PA untuk mendiskusikan pencapaian yang harus ditingkatkan pada masing-masing tahap dan mengadakan pembinaan dan klarifikasi masalah
11. Pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi data sekunder
12. Supervisor mengklarifikasi masalah yang ada.
13. Supervisor melakukan tanya jawab dengan PP dan PA

### Pasca Supervisi

1. Supervisor membuat daftar masalah yang belum diselesaikan
2. Supervisor memberikan penilaian supervisi
3. Supervisor memberikan Feed Back dan klarifikasi
4. Supervisor memberikan reinforcement pada staf perawat
5. Supervisor menyampaikan rencana tindak lanjut supervisi

### Skenario implementasi keterampilan supervisor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di RS Kasih didapatkan data

- 100% kepala ruangan menyatakan memahami tentang supervisi keperawatan
- 80% kepala ruangan melakukan supervisi untuk memantau kinerja perawat pelaksana pada sore dan malam hari berupa disiplin berpakaian, jam dinas, dll namun tidak secara terjadwal sedangkan 20% belum melakukan supervisi
- 60% perawat pelaksana mengatakan tidak disupervisi dan tidak dilakukan pembinaan oleh kepala ruangan
- 75% kepala ruangan mengatakan memahami bahwa supervisi lebih difokuskan pada proses observasi, baik itu observasi langsung oleh kepala bidang keperawatan, maupun oleh kepala ruangan.

- Supervisi kepala ruangan ke ketua tim dan ketua tim ke perawat pelaksana sudah dilaksanakan setiap hari akan tetapi belum ada pendokumentasian sesuai standar dan belum terjadwal.
- Hasil observasi belum ada format untuk supervisi yang baku di ruangan

#### G. Prioritas Masalah

Belum optimalnya pelaksanaan supervisi dan belum ada pedoman pelaksanaan supervisi. Supervisi secara umum adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh “atasan” terhadap pekerjaan yang dilakukan “bawahan” untuk kemudian bila ditemukan masalah, segera diberikan bantuan yang bersifat langsung guna mengatasi. pelaksanaan supervisi keperawatan di RS X hanya berfokus pada kehadiran dan laporan jumlah pasien saja dan sering mengabaikan hal-hal tentang pelaksanaan standar operasional antara lain SOP tindakan pasang infus, nebulizer atau kegiatan MPKP sehingga ada beberapa hal yang belum berjalan secara maksimal.

#### H. *Planning of Action* Implementasi Supervisi Keperawatan

| No | Uraian kegiatan                             | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran                                                                                    | Metode                                                                            | Media       | Dana | Waktu | PJ |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|----|
| 1. | FGD supervisi untuk kepala – kepala ruangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman serta komitmen yang tinggi dari pihak manajerial keperawatan tentang pentingnya supervisi</li> <li>- Standar penilaian supervisi kepala ruangan kepada ketua tim dan ketua tim ke perawat pelaksana</li> <li>- Penetapan kebijakan dan jadwal supervisi rutin</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat</li> <li>- Manajer keperawatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curah pendapat</li> <li>- FGD</li> </ul> | Laptop, LCD |      |       |    |

## I. Implementasi

Berdasarkan masalah tersebut dapat dilakukan implementasi pelaksanaan supervisi keperawatan dalam pelaksanaan perencanaan harus dijalankan dengan maksimal seperti penyusunan jadwal dinas profesi keperawatan, pelaksanaan program pelatihan atau seminar, rapat rutin keperawatan, dan perencanaan evaluasi program kerja keperawatan.

## J. Evaluasi

Pelaksanaan supervisi keperawatan harus terkendali mulai dari kepala bidang keperawatan sebagai top menerjer dan semua staf yang melaksanakan tugas dan tetap berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Supervisor juga perlu memberikan perhatian, memberi suport dan pembimbingan serta memperhatikan proses pemberian pelayanan keperawatan selama melakukan supervisi. Implementasi pelaksanaan supervisi keperawatan dapat juga dilakukan dalam bentuk pengarahan dan juga pengawasan dalam bentuk observasi atau pengamatan secara terus menerus berhubungan dengan asuhan keperawatan kepada pasien. Evaluasi supervisi yang dilakukan juga bermanfaat untuk membantu meningkatkan kinerja staf keperawatan.

## K. Format Laporan Supervisi

| Supervisor : |        |                   | Tanggal : |               |
|--------------|--------|-------------------|-----------|---------------|
| Masalah      | Tujuan | Pemecahan masalah | Evaluasi  | Tindak lanjut |





# MOTIVASI KERJA PERAWAT



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

## MOTIVASI KERJA PERAWAT

### A. Pendahuluan

Manusia pada hakikat mempunyai motivasi, minimal yaitu motivasi hidup sehat, kuat, dan selamat atau terhindar dari malapetaka. Bawahan memiliki motivasi dari diri sendiri (intrinsic) dan motivasi dari luar (ektrinsik) terutama dari pimpinannya (Husaini Usman, 2013)

Tugas umum seorang pemimpin adalah memberikan pengarahan atau bimbingan (finch & McGaugh, 1981). Pengarahan (*leading*) menurut Stroner (1992) meliputi : (1) motivasi, (2) kepuasan kerja, (3) kinerja, (4) kepemimpinan, (5) kelompok dan komite, (6) komunikasi, (7) negosiasi, dan (8) manajemen karier individu. Sementara itu Schermerhorn (1996) menyatakan bahwa *leading* meliputi : (1) dasar – dasar *leading*, (2) *leading* melalui motivasi, (3) *leading* melalui komunikasi, (4) *leading* melalui keterampilan personal, (5) *leading* melalui dinamika kelompok dan kerja tim, dan (6) *leading* melalui meliputi : (1) memahami perilaku dasar manusia, (2) motivasi kerja dan ganjaran, (3) isi – isi dasar kepemimpinan, (4) isu – isu kepemimpinan kontemporer, (5) membangun kepercayaan, dan (6) mengembangkan keterampilan *interpersonal*. *Leading* menurut Hunsaker (2002) meliputi : (1) membangun dasar kekuasaan, (2) mengarahkan perubahan, (3) memotivasi orang lain, (4) mengembangkan anak buah, dan (5) mengelola konflik (Husaini Usman, 2013).

Dari ketiga pendapat tersebut, terdapat persamaan, yang berbeda hanyalah istilahnya saja. Kepemimpinan menurut stoner & freedman sama dengan dasar – dasar *leading* menurut Schermerhorn dan juga sama dengan isu – isu dasar kepemimpinan dan isu – isu kepemimpinan kontemporer menurut robbins. Motivasi menurut Striner dan Freedman hamper sama maksudnya dengan *leading* melalui motivasi menurut Schermerhorn, dan motivasi kerja dan ganjaran menurut robbins sama dengan *leading* melalui komunikasi menurut Schermerhorn. Kelompok dan komite menurut Stoner & Freedman sama dengan *leading* melalui dinamika kelompok dan kerja tim menurut Schermerhorn. Manajemen karir insivisu menurut Schermerhorn dan juga hamper sama dengan mengembangkan ketreampilan *interpersonal* dengan mengembangkan anak buah menurut Hunsaker (Husaini Usman, 2013).

Perbedaan ketiga pendapat terletak pada jumlah dan unsure – unsure lain dari *leading*. Negosiasi, kinerja, dan kepuasan kerja hanya ada pada pendapat stoner. *Leading* melalui inovasi dan perencanaan perubahan hanya ada pada pendapat Schermerhorn dan Hunsaker. Membangun kepercayaan hanya ada pada Robbins. Manajemen konflik hanya ada pada pendapat Hunsaker (Husaini Usman, 2013).

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengarahan meliputi : (1) motivasi, (2) kepemimpinan, (3) kekuasaan, (4) pengambilan keputusan, (5) komunikasi, (6) Koordinasi, (7) negosiasi, (8) manajemen konflik, (9) perubahan organisasi, (10) keterampilan interpersonal, (11) membangun kepercayaan, (12) penilaian kinerja, dan (13) kepuasan kerja (Husaini Usman, 2014).

Motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi membantu para manajer memahami sikap kerja pegawai masing – masing. Manajer dapat memotivasi pegawai dengan cara berbeda – beda sesuai dengan pola masing – masing yang paling menonjol. Bawahan perlu dimotivasi karena ada bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi atasannya. Motivasi yang timbul dari luar disebut *motivasi ekstrinsik*. Di pihak lain, ada pula bawahan yang bekerja atas motivasi dari dirinya sendiri. Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri disebut *motivasi intrinsik*. Motivasi intrinsik biasanya lebih bertahan lama dan efektif dibandingkan motivasi ekstrinsik (Husaini Usman, 2013).

Jika seseorang berhasil mencapai motivasinya, maka yang bersangkutan cenderung untuk terus termotivasi. Sebaliknya, jika seseorang sering gagal mewujudkan motivasinya, maka yang bersangkutan mungkin tetap ulet terus berusaha dan berdoa sampai motivasinya tercapai atau justru menjadi putus ada (frustasi) (Husaini Usman, 2013).

Berikut akan disajikan beda motivasi dengan motif, definisi, tujuan, manfaat, ruang lingkup, faktor2 yang mempengaruhi, analisis situasi, prioritas masalah, alternatif solusi, plan of action, implementasi akhirnya, bab ini di tutup dengan evaluasi.

## **B. Definisi**

### **1. Definisi Motivasi**

Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang member kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk factor – factor yang menyebabkan menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. (Stoner & Freeman, 1995 : 134) Mptivasi menurut Ngalm Purwanto (2000:60) adalah bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam (Sbortell & Kaluzny, 194:59) (Nursalam MNurs, 2002).

Teori – teori motivasi (Stoner & Freeman, 1995) Landy dan Becker mengelompokkan banyak pendekatan modern pada teori dan praktik menjadi lima kategori : teori kebutuhan, teori penguatan, teori keadilan, teori harapan dan teori penetapan sasaran:

a. Teori kebutuhan

Abraham Maslow telah mengembangkan suatu konsep teori motivasi yang dikenal dengan hirarki kebutuhan (hierarchy of needs). Menurut Maslow, nampaknya ada semacam hirarki yang mengatur dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan manusia (Thoha, 2003).

Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang terkenal dengan kebutuhan FAKHTA (Fisiologis, Aman, Kasih Sayang, Harga Diri, dan Aktualisasi Diri) dimana dia memandang kebutuhan manusia sebagai lima macam hirarki, mulai dari kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang paling menonjol atau paling kuat bagi mereka pada waktu tertentu (Nursalam, 2011). Maslow meyakini bahwa orang termotivasi untuk memuaskan kebutuhan tertentu, mulai dari kebutuhan bertahan hidup dasar sampai kebutuhan psikologis kompleks, dan bahwa orang mencari kebutuhan yang lebih tinggi saat kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi secara dominan (Marquis and Huston, 2003).

b. Teori keadilan

Teori keadilan didasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah evaluasi individu atau keadilan dari penghargaan yang diterima. Individu akan termotivasi kalau mereka mengalami kepuasan dan mereka terima dari upaya dalam proporsi dan dengan usaha yang mereka pergunakan. (Nursalam MNurs, 2002).

c. Teori harapan

Menyatakan cara memilih dan bertindak dari berbagai alternative tingkah laku, berdasarkan harapannya apakah ada keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkah laku.

Teori harapan berpikir atas dasar :

1) Harapan hasil prestasi

Individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari tingkah laku mereka. Harapan ini nantinya akan mempengaruhi keputusan mereka tentang cara bertingkah laku.

2) Valensi

Hasil dari suatu tingkah laku tertentu mempunyai valensi atau kekuatan untuk memotivasi, yang bervariasi dari satu individu ke individu yang lain.

3) Harapan prestasi usaha

Harapan orang mengenai seberapa sulit untuk melaksanakan tugas secara berhasil dan mempengaruhi keputusan tentang tingkah laku. (Nursalam MNurs, 2002).

d. Teori penguatan

Teori penguatan, yang dikaitkan ahli psikologi B.F skinner dengan teman-temannya, menunjukkan bagaimana konsekuensi tingkah laku dimana lampau yang mempengaruhi tindakan pada masa depan dalam proses belajar siklis. Proses ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

Rangsangan → Respon → Konsekuensi → Respon masa depan

Dalam pandangan ini, tingkah laku sukarela seseorang terhadap suatu situasi atau peristiwa merupakan penyebab dari konsekuensi tertentu. Teori penguatan menangkut ingatan orang mengenai pengalaman rangsangan respon konsekuensi. Menurut teori penguatan, seseorang termotivasi kalau dia memberikan respon pada rangsangan dalam pola tingkah laku konsisten sepanjang waktu. (Nursalam MNurs, 2002).

**2. Pengertian Motivasi Kerja**

Berkerja adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapat kepuasan. Dan aktivitas ini melibatkan fisik maupun mental (M.As'as. 2001 : 47). Pendapat dari gilmer (1971), bahwa bekerja itu merupakan proses fisik maupun mental manusia dalam mencapai tujuannya. Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja (Mangkunegaa, 2000 : 94 dalam Nursalam MNurs, 2002)

**C. Tujuan Motivasi**

**1. Tujuan Motivasi**

Tujuan Motivasi adalah usaha memobilisasi (merangsang) sumber daya untuk menghasilkan produktivitas dan semangat agar mendapatkan hasil terbaik perusahaan (Hasibuan, 2016). Ada beberapa tujuan pemberian motivasi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan semangat karyawan dan kepuasan kerja.
- b. Meningkatkan produktivitas staf.
- c. Mempertahankan stabilitas karyawan perusahaan.
- d. Meningkatkan disiplin karyawan.
- e. Mengefrktifkan pengadaan karyawan.
- f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
- g. Meningkatkan loyalitas, kreaktifitas dan partisipasi karyawan.
- h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.
- i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan.
- j. Meningkatkan penggunaan alat dan bahan baku secara efektif

Berdasarkan tujuan motivasi tersebut, motivasi digunakan untuk meningkatkan produktifikasi kinerja karyawan dan kepuasan kerja agar para pegawai mampu berprestasi dalam melaksanakan pekerjaannya secara maksimal.

## **2. Peran manajer dalam menciptakan motivasi**

Manajer memegang peran yang penting dalam memotivasi staf untuk menciptakan tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer harus mempertimbangkan keunikan / karakteristik dari stafnya dan berusaha untuk memberikan tugas sebagai suatu strategi dalam memotivasi staf. Kegiatan yang perlu dilaksanakan manajer dalam menciptakan suasana yang morivatif adalah:

- a. Mempunyai harapan yang jelas stafnya dan komunikasikan harapan tersebut kepada para staf
- b. Harus adil dan konsisten terhadap semua staf atau karyawan
- c. Pengambilan keputusan harus tepat dan sesuai
- d. Kembangkan konsep tim kerja
- e. Akomodasikan kebutuhan dan keinginan staf terhadap tujuan organisasi
- f. Tunjukkan kepada staf bahwa anda memahami perbedaan – perbedaan dan keunikan dari masing – masing staf
- g. Hindarkan adanya suatu kelompok / perbedaan antar staf
- h. Berikan kesempatan kepada staf untuk menyelesaikan tugasnya dan melakukan suatu tantangan – tantangan yang akan memberikan pengalaman yang bermakna
- i. Mintalah tanggapan dan masukan kepada staf terhadap keputusan yang akan dibuat di organisasi
- j. Pastikan bahwa staf mengetahui dampak dari keputusan dan tindakan yang akan dilakukan
- k. Ciptakan situasi saling percaya dan kekeluargaan dengan staf
- l. Berikan kesempatan kepada staf untuk melakukan koreksi dan pengawasan terhadap tugas
- m. Jadilah “role model” bagi staf
- n. Berikan dukungan yang positif (Usman Husaini, 2013).

## **D. Manfaat Teori Motivasi**

Motivasi sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kinerja (performace) bawahannya karena kinerja tergantung dari motivasi, kemampuan, dan lingkungan. Rumusnya (Husaini Usman, 2013).

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kinerja (K) = fungsi dari motivasi (M), kemampuan (K), dan lingkungan (L)</p> <p>Atau</p> $K = f(m,k,l)$ <p>(Hunsaker, 2002)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Motivasi

### 1. Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi

Motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu internal yang berasal dari proses psikologis dalam diri seseorang, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri (*environment factor*) (Saydan dalam Sayuti, 2007) :

#### a. Faktor internal

##### 1) Jenis kelamin

Jenis kelamin merupakan aspek identitas yang sangat berarti, wanita dan pria mempunyai pengalaman yang berbeda tentang pembentukan identitas jenis, kelamin identitas, jenis kelamin terbentuk sekitar usia tiga tahun. Wanita dan pria mempunyai perbedaan secara psikologis dimana wanita lebih mudah tersinggung, mudah terpengaruh, sangat peka, menonjolkan perasaan, tanggap dan mudah melupakan perasaan. Sementara pria tidak mudah emosional, sangat objektif, tidak mudah terpengaruh, mudah memisahkan antara pikiran dan perasaan sehingga kadang kurang peka dan mampu memendam rasanya (Nungki, 2007).

##### 2) Usia

Menyatakan bahwa makin tua usia pekerja, makin sedikit kesempatan mendapat pekerjaan alternatif. Namun disamping itu pekerja yang tua cenderung rendah tingkat kemangkirannya atau absensinya, artinya mereka hanya absen jika kesehatannya terganggu (sakit). Usia dalam kaitan pengaruhnya terhadap motivasi pegawai terletak pada kesediaan atau kesetiaan yang lebih dibandingkan pegawai yang lebih muda dan kematangan emosi atau tempramennya nampak pada kinerja atau penampilannya (Robbins, 2008).

##### 3) Tingkat Pendidikan

Seorang pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan lebih termotivasi karena sudah mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan karyawan yang lebih rendah tingkat pendidikannya, sebaliknya jika tingkat pendidikan yang dimilikinya tidak digunakan secara maksimal ataupun tidak diharagai sebagaimana layaknya oleh manajer maka hal ini akan membuat karyawan tersebut mempunyai motivasi yang rendah didalam bekerja.



4) Masa kerja

Menurut Gibson, dkk (1997) dalam Syafutri (2012) masa kerja seseorang akan menentukan prestasi individu yang merupakan dasar prestasi dan kinerja organisasi, maka tingkat prestasi individu akan semakin meningkat yang dibuktikan dengan tingginya motivasi kerja sehingga memungkinkan untuk mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan.

5) Keinginan dan harapan pribadi

Seorang mau bekerja keras bila ada keinginan pribadi yang hendak diwujudkan menjadi kenyataan.

6) Kebutuhan

Kebutuhan biasanya berbanding sejajar dengan motivasi, semakin besar kebutuhan seseorang untuk dipenuhi maka semakin besar pula motivasi karyawan tersebut untuk bekerja keras.

7) Kelelahan dan kebosanan

Faktor kelelahan dan kebosanan dapat mempengaruhi gairah dan semangat kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi motivasi kerjanya.

8) Kepuasan kerja

Kepuasan kerja mempunyai korelasi yang sangat kuat kepada tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang. Karyawan yang puas terhadap pekerjaan akan mempunyai motivasi yang tinggi dan komitmen terhadap pekerjaannya. Tinggi rendahnya kepuasan karyawan dapat dicerminkan dari produktivitas kerjanya yang tinggi, sanggup bekerja ekstra, jarang absen, dan tingkat *turn over* yang rendah.

b. Faktor eksternal

1) Kondisi lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah keseluruhan dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan pekerjaan meliputi tempat bekerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, keberhasilan, pencahayaan, ketenangan, termasuk hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat kerja.

2) Kompensasi yang memadai

Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk memberikan dorongan kepada para karyawan agar bekerja secara baik. Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa penghargaan nyata yang diterima karyawan karena bekerja adalah dalam bentuk gaji, tunjangan, dan insentif.

3) Supervisi yang baik

Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang supervisor dalam memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat kepada orang lain (pegawai) untuk

mengambil tindakan-tindakan. Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan pegawai agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki orang tersebut. Oleh karena itu seorang supervisor dituntut untuk pengenalan atau pemahaman dari sikap dan karakteristik bawahananya (Mathis dan Jackson, 2006).

4) Ada jaminan karir

karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidup. Para karyawan mengejar karir untuk dapat memenuhi kebutuhan individual secara mendalam. Mereka bekerja bukan untuk hari ini saja, tetapi mereka berharap akan bekerja sampai tua, cukup dalam satu perusahaan saja dan tidak usah seringkali berpindah. Hal tersebut akan dapat terwujud bila perusahaan dapat memberikan jaminan karier untuk masa depan, baik jaminan akan adanya promosi jabatan, pangkat, maupun jaminan pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi diri (Sutrisno, 2009).

5) Status dan tanggung jawab

Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan dan harapan setiap karyawan dalam bekerja. Seseorang dengan menduduki jabatan yang tinggi merasa dirinya dipercaya, diberi tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar untuk melakukan kegiatannya. Jadi status dan kedudukan ini merupakan stimulus atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan *sence of achievement* dalam tugas sehari-hari.

6) Peraturan yang fleksibel

Faktor lain yang diketahui dapat mempengaruhi motivasi adalah didasarkan pada hubungan yang dimiliki oleh karyawan dalam organisasi. Bidang-bidang seperti kelayakan dari kebijakan manajemen, keadilan dari tindakan disipliner, cara yang digunakan untuk memutuskan hubungan kerja dan peluang kerja semua akan mempengaruhi retensi karyawan, apabila karyawan merasakan bahwa kebijakan itu terlalu kaku atau ditetapkan secara tidak konsisten, mereka akan cenderung untuk mempunyai motivasi yang rendah.

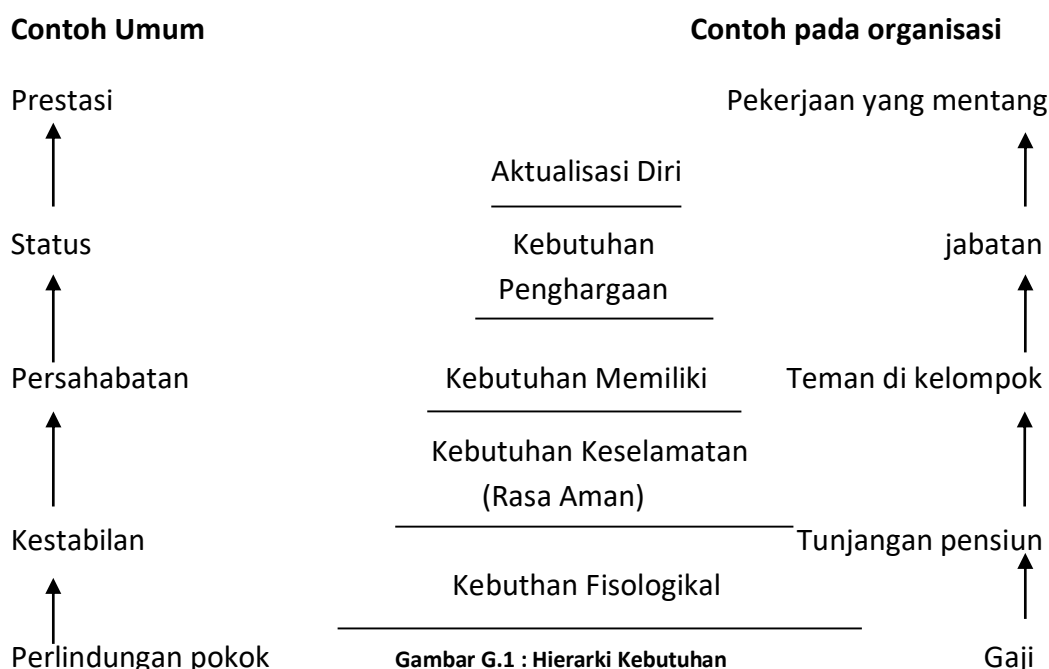
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi motivasi kerja (Rivai Veithzal, 2005):

- a) Rasa aman dalam bekerja
- b) Gaji yang adil dan kompetitif
- c) Lingkungan kerja yang menyenangkan
- d) Penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen.

## F. Prioritas Masalah

Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow terdapat lima tingkatan kebutuhan, dari kebutuhan manusia yang paling rendah sampai pada kebutuhan manusia yang paling tinggi. Urutan motivasi yang paling rendah sampai motivasi yang paling tinggi. Hierarki kebutuhan Maslow pada gambar G.1 gambarkan masalah dari motivasi (Husaini Usman, 2013) :



## G. Alternatif Solusi

### 1. Teknik – teknik motivasi

Para ahli mengungkapkan tentang teknik-teknik memotivasi bawahan antara lain menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut (Suyanto, 2008):

- Bersikap baik (*the be good approach*) dengan cara menciptakan kondisi kerja yang baik seperti tunjangan, gaji dan bonus yang tinggi.
- Menggunakan *kekerasan* (*the strong approach*) yaitu pemimpin menggunakan wewenang untuk menekan bawahannya.
- Perundingan *implisit* (*implicit bargaining*) melalui perundingan antarabawahan dan atasan terhadap hasil kerja yang dicapai sesuai dengan imbalan yang akan diberikan.
- Kompetisi (*competition*) memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- Internalisasi (*internalized motivation*) merupakan pertimbangan terhadap keterampilan, perhatian, kebebasan dan percaya diri yang dimiliki.

Teknik memotivasi yang dapat digunakan oleh manajer keperawatan sebagai berikut (Swansburg, 1999 dalam Suyanto, 2008:

- a) Harga diri (*self esteem*), yaitu suatu pengakuan terhadap keberhasilan pekerjaan yang telah dilakukan staf perawatan sehingga meningkatkan harga diri dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi.
- b) Pengkayaan pekerjaan (*job enrichment*), merupakan pengembangan tugas bagi staf perawatan sehingga pekerjaan itu sendiri dapat membuat staf termotivasi.
- c) Pemberdayaan (*empowerment*), melalui pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan sehingga dapat timbul rasa percaya dan mempercayai serta saling mendukung.
- d) Promosi kesamping (*lateral promotion*), merupakan promosi karir dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap staf perawatan untuk maju dan mendapatkan tugas yang lebih serta sesuai.
- e) Pertumbuhan (*growth*), merupakan tumbuh dan berkembang guna meningkatkan kemampuan staf dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap staf perawatan untuk meneruskan pendidikan dan mengikuti pelatihan.
- f) Komunikasi (*communication*) tujuannya untuk memberikan motivasi dengan berbagai informasi dan berkonsultasi.
- g) Penghargaan (*reward*), baik finansial maupun finansial.

2. Selain itu, ada teknik motivasi lainnya yang dapat dilakukan terhadap bawahan, yaitu yang disebut dengan prinsip MOTIVATE (vermas, 1996 dalam Husaini Usman. 2013):

- M = Manifest artinya bangkitkan rasa percaya diri ketika pendelegasian tugas
- O = Open artinya bangkitkan percaya diri ketika mendelegasikan tugas
- T = Tolerance artinya toleransi terhadap kegagalan, mau dan boleh belajar dari kesalahan karena pengalaman adalah guru yang terbaik (tingkatkan kreativitas)
- V = Value artinya semua pihak terkait dalam pekerjaan (meningkatkan rasa diterima & komitmen)
- A = Align artinya menyeimbangkan sasaran pekerjaan (proyek) dengan sasaran individu (orang – orang bersemangat mencapai kepuasan yang mereka inginkan).
- T = Trust artinya kejujuran setiap anggota tim (vital dalam memotivasi)
- E = Empower artinya berdayakan setiap anggota tim sewajarnya (khususnya dalam pengambilan keputusan & pelaksanaannya).

3. Strategi meningkatkan motivasi

Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dengan menata kembali sebuah penugasan yang ada di dalam organisasi dengan memodifikasi setiap tugas

keperawatan agar dapat meningkatkan sebuah tanggung jawab, otonomi dan pengembangan sikap profesional, diantaranya sebagai berikut:

- a) *Job rotation*
- b) *Job enlargement*
- c) *Job enrichment*

Selanjutnya, agar motivasi dapat selalu ada maka perlu cara lain untuk mempertahankan motivasi seperti menciptakan iklim kerja, adapun cara untuk menciptakannya sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi Sumber Stress.  
Sumber stress dapat dipicu karena jumlah pasien yang berlebihan, kondisi pasien yang berat dan serius, staf perawat yang kurang, konflik antara perawat - dokter.
- b) Melakukan tindakan pencegahan dan mengurangi stress.
- c) Menciptakan suasana kerja yang terbuka.
- d) Komunikasi yang baik dan efektif secara verbal maupun non verbal secara horizontal.
- e) Mengurangi kontrol yang berlebihan pada tugas yang telah diberikan agar staf dapat mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab.
- f) Memberikan *reinforcement* pada hasil kerja / penampilan yang positif.
- g) Bila memungkinkan peningkatan kesejahteraan.
- h) Mengembangkan konsep kerja tim (Suyanto, 2008).

#### 4. Teknik pengukuran motivasi kerja

Kekuatan motivasi kerja atau tenaga kerja untuk bekerja atau berkinerja secara langsung tercermin sebagai upaya seberapa jauh ia bekerja keras. Upaya ini mungkin menghasilkan kinerja yang cukup baik atau sebaliknya, karena ada dua faktor yang harus benar jika suatu upaya itu akan diubah menjadi kinerja. Pertama, tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Tanpa kemampuan dan upaya yang tinggi tidak mungkin menghasilkan kinerja yang baik. Kedua adalah persepsi tenaga kerja yang bersangkutan tentang bagaimana upaya pada situasi yang sama.

Teori harapan (*Expectancy Theory*) merupakan teori pengutamaan penghargaan diri dari Victor Vroom, dalam lingkungan kerja setiap pegawai selalu mempunyai harapan. Harapan adalah suatu istilah yang berkenaan dengan kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan suatu pola. Perolehan dapat dalam bentuk uang atau materi ataupun dalam bentuk non materi (Wursanto, 2009).

Kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal-balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaannya. Berapa besar seseorang yakin bahwa

perusahaan akan memberikan pemuasan atas keinginannya sebagai imbalan dari usaha yang dilakukannya (Hasibuan, 2008).

#### 5. Pengkategorian motivasi kerja

Rumus untuk pengkategorian motivasi, yaitu :

$$P = f / n \times 100\%$$

Ket : P = Presentasi kategori

f = Faktor yang di dapat

n = Skor maksimal

Adapun pengkategorian motivasi, yaitu :

- a) Motivasi tinggi : 67 – 100%
- b) Motivasi sedang : 34 – 66%
- c) Motivasi rendah : 0 – 33%

Proses penilaian motivasi kerja menurut para ahli psikologi membagi motivasi dalam beberapa tingkatan, namun secara umum terdapat kesamaan dalam mengklarifikasikan tingkatan motivasi, yaitu (Irwanto, 2010) :

- 1) Motivasi tinggi : motivasi dikatakan kuat apabila dalam diri seseorang memiliki keinginan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang tinggi bahwa dirinya akan berhasil dalam mencapai tujuan dan keinginannya.
- 2) Motivasi sedang : motivasi dikatakan sedang apabila dalam diri seseorang memiliki keinginan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah untuk berhasil dalam mencapai tujuan dan keinginannya.
- 3) Motivasi rendah : motivasi dikatakan rendah atau lemah apabila di dalam diri seseorang memiliki keinginan yang positif namun memiliki keinginan dan harapan yang rendah bahwa dirinya dapat mencapai tujuan dan keinginannya (Hidayat, 2009).

### H. Implementasi

#### 1. Proses Motivasi

Motivasi terdiri dari elemen - elemen yang saling berinteraksi dan bersifat interdependen :

- a) *Need* : Kebutuhan tercipta manakala terjadi ketidakseimbangan fisik maupun psikologis. Kebutuhan psikologis terkadang tidak timbul akibat ketidakseimbangan
- b) *Driver* : Dorongan atau motif timbul untuk mengurangi kebutuhan. Dorongan baik fisiologis maupun psikologis berorientasi pada tindakan dan menyiapkan energi pendorong untuk mencapai tujuan (incentives).

- c) *Incentives / goal* : Segala sesuatu yang akan mengurangi kebutuhan dan menurunkan dorongan tindakan. Dengan demikian pencapaian tujuan akan mengembalikan keseimbangan fisiologis dan psikologis dan menurunkan bahkan menghentikan dorongan.

Motivasi itu ada atau terjadi karena adanya kebutuhan seseorang yang harus segera dipenuhi untuk segera beraktifitas segera mencapai tujuan (Widayatun, 1999) :

a) Faktor yang berpengaruh terhadap motivasi :

- 1) Faktor fisik & proses mental
- 2) Faktor hereditas, lingkungan
- 3) Faktor intrinsik seseorang
- 4) Fasilitas (sarana & prasarana)
- 5) Sikon
- 6) Program dan aktifitas
- 7) Media

b) Bentuk-bentuk motivasi :

- 1) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri.
- 2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu.
- 3) Motivasi terdesak yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak serta menghentak dan cepat sekali munculnya pada perilaku aktifitas seseorang.
- 4) Motivasi yang berhubungan dengan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ideologi sosbud) dan hankam yang sering menonjol adalah motivasi sosial karena individu itu adalah makhluk sosial.

## I. Evaluasi

Perawat dalam sumber daya terpenting dalam menjalankan pelayanan suatu rumah sakit, maka perawat dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, komunikasi intelektual, komunikasi interpersonal, kemampuan teknis dan moral. Karakteristik perawat yang selalu menjadi penentu arah dan kekuatan bekerja adalah motivasi dan lain – lain seperti : tingkat pengetahuan, keterampilan kerja, kewenangan yang diberikan, nilai inovatif, dedikasi dan pengabdian masing – masing pada profesi. Menurut Herzberg dalam Ilyas (2001), yang dimaksud dengan faktor motivasi adalah hal – hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor – faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang misalnya dari organisasi, tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.

Pentingnya suatu motivasi karena motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam berperilaku (Nursalam, 2015). Motivasi perawat sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja perawat saat memberikan pelayanan keperawatan. Untuk melakukan kajian terhadap literatur yang berhubungan dengan pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap kinerja perawat (Lutfi Fauji Ridwan. 2015)





# **MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN**



## MANAJEMEN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN

### A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan harus dilakukan secara profesional berdasarkan kode etik keperawatan yang berlaku. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan bahwa Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Pelayanan keperawatan harus dijalankan secara baik untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Mutu pelayanan keperawatan merupakan bagian dari fungsi pengendalian dalam manajemen keperawatan.

Manajemen mutu pelayanan keperawatan dilakukan untuk menciptakan kepuasan pasien (individu, kelompok, atau masyarakat). Penelitian (Sesrianty et al., 2019) menjelaskan bahwa kepuasan pasien dapat dilihat dari mutu pelayanan keperawatan yang baik. Selanjutnya dijelaskan bahwa penting untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan guna meningkatkan citra positif dari suatu fasilitas layanan kesehatan. Kepuasan klien dapat dilihat dengan adanya peningkatan kunjungan ulang pasien di fasilitas kesehatan. Penelitian (Habibi et al., 2020) menyatakan bahwa mutu pelayanan keperawatan berhubungan dengan minat pasien untuk kunjungan ulang di rumah sakit. Mutu pelayanan yang meningkatkan minat kunjungan ulang pasien di fasilitas kesehatan dilihat dari dimensi mutu layanan kesehatan yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.

Manajemen mutu pelayanan keperawatan dapat diimplementasikan oleh manager keperawatan. Penelitian (Aziz & Hidayat, 2019) menerangkan bahwa kepemimpinan manager keperawatan dalam hal ini kepala ruangan dapat mempengaruhi implementasi system manajemen mutu keperawatan di rumah sakit. Penelitian lain oleh (Pratiwi, 2019) menyatakan bahwa implementasi system manajemen mutu keperawatan dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan mutu kepala ruangan sebagai salah manager lini pertama dalam keperawatan.

### B. Definisi

Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa prancis kuno yaitu *management* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur, serta bahasa itali yaitu *meneggiare* yang berarti mengendalikan (Aditama, 2020). Mutu pelayanan kesehatan seringkali menjadi penentu citra fasilitas layanan kesehatan di masyarakat, karena merupakan alat ukur dari suatu kualitas pelayanan kesehatan (Nursalam, 2014). Menurut (Astari, 2020) definisi mutu terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam pelayanan kesehatan,
2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan, dan
3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah

Mutu Pelayanan Keperawatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan keperawatan sebagai pemenuhan kebutuhan pasien secara holistic (biologi, psikologi, sosial, dan spiritual) (Siregar, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu pelayanan keperawatan merupakan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan keperawatan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistic.

### C. Tujuan

Tujuan manajemen mutu pelayanan keperawatan terbagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu (Triwibowo, 2013):

- |             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahapan I   | Penyusunan standar atau kriteria;<br>Bertujuan untuk terciptanya asuhan keperawatan yang lebih terstruktur dan terencana berdasarkan standar kriteria masing-masing perawat.                               |
| Tahapan II  | Mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan kriteria;<br>Betujuan untuk informasi dapat mendukung proses asuhan keperawatan secara lebih efektif, serta sebagai pengukur kualitas pelayanan keperawatan. |
| Tahapan III | Identifikasi sumber informasi;<br>Bertujuan untuk pemilihan informasi yang lebih akurat dengan penyeleksian ketat dan berkesinambungan. Pasien juga dapat dijadikan sumber informasi.                      |
| Tahapan IV  | Mengumpulkan dan menganalisis data;<br>Bertujuan untuk penyeleksian data oleh perawat dari pasien. Data dianalisis satu-persatu.                                                                           |
| Tahapan V   | Evaluasi ulang;<br>Bertujuan untuk meminimalkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan pada keseluruhan proses asuhan keperawatan.                                                                         |

### D. Manfaat

Manajemen mutu pelayanan keperawatan memiliki banyak manfaat dalam pelayanan asuhan kesehatan di tatanan layanan kesehatan. Manfaat pengendalian mutu pelayanan kesehatan, antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan individu, masyarakat, atau kelompok terhadap pelayanan kesehatan.

Pengendalian mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan secara baik dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, dan mencegah terjadinya tuntutan hukum. Hal tersebut berorientasi pada tingkat kunjungan ulang pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif

Pengendalian mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan tepat dan benar. Hal tersebut berpotensi meningkatkan citra fasilitas kesehatan.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien

Pengendalian mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan secara teratur dan tepat dapat mencegah terjadinya masalah dalam pelayanan asuhan keperawatan. Efisiensi waktu, biaya, maupun tenaga untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dicegah dengan rutinnya pengendalian mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup manajemen mutu pelayanan keperawatan dapat dilihat pada indikator dan dimensi mutu pelayanan keperawatan, sebagai berikut:

1. Dimensi

Dimensi manajemen mutu pelayanan keperawatan merupakan parameter untuk menilai kualitas dari suatu fasilitas layanan kesehatan terkait kepuasan pasien. Parasuraman et al (1991) dalam (Nursalam, 2014) secara umum membagi dimensi mutu pelayanan keperawatan menjadi 5 (lima), antara lain:

a. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan dapat dikaitkan dengan kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara professional, serta sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Perawat harus memiliki kemampuan dalam melakukan tindakan keperawatan, tindakan kolaborasi maupun tindakan edukasi kesehatan secara baik dan benar. Misalnya perawat mampu menjelaskan semua tindakan yang akan dilakukan, serta mampu menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan pasien dengan baik dan benar.

b. Empati (*Emphaty*)

Empati adalah persepsi pasien berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh perawat. Kesopanan dan keramahan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Hal tersebut berorientasi terhadap peningkatan mutu pelayanan asuhan keperawatan. Sikap perawat yang penuh perhatian dalam memenuhi kebutuhan pasien selama dirawat di rumah sakit maupun berobat ke puskesmas dapat memberikan dampak

positif bagi proses penyembuhan pasien, maupun bendampak positif bagi citra rumah sakit ditengah masyarakat.

c. Berwujud/Bukti Fisik (*Tangibles*)

Bukti fisik/berwujud dapat dilihat dari penampilan perawat saat berkomunikasi dengan pasien, fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit sehingga membantu proses penyembuhan pasien, pengengkapan alat yang digunakan dalam membantu perawatan pasien, serta rasio tenaga perawat dengan pasien yang sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit.

d. Ketanggapan/Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Ketanggapan/daya tanggap berhubungan dengan kemampuan perawat untuk siap sedia dalam membantu pasien dalam proses penyembuhan. Ketanggapan/daya tanggap juga dapat dilihat ketepatan waktu perawat datang sesuai kontrak waktu sebelumnya dengan pasien. Misalnya perawat yang merespon permintaan atau pertanyaan pasien secara cepat dan tanggap. Contoh lain ialah perawat datang mengganti cairan infus sebelum pasien atau keluarga pasien yang melaporkan kehabisan cairan infus.

e. Jaminan Kepastian (*Assurance*)

Jaminan meliputi pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh perawat. Kepercayaan pasien terhadap perawat meningkat apabila perawat mampu merespon apa yang menjadi keluhan klien, ataupun perawat terampil dalam melakukan tindakan keperawatan dan tindakan kolaborasi secara terampil. Pasien akan merasa terjamin atau merasa aman jika perawat mampu menampilkan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur secara baik dan benar.

2. Indikator

Indikator manajemen mutu keperawatan merupakan suatu variabel yang ditetapkan untuk menilai kualitas asuhan keperawatan yang berorientasi terhadap mutu pelayanan kesehatan. *American Nursing Association's* (ANA) dalam (Hidaya, 2020) menjelaskan bahwa indikator mutu keperawatan dapat dijabarkan dalam 3 kategori, sebagai berikut:

| Kategori I                                  | Ukuran                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ukuran berfokus pada <i>outcomes</i> pasien | 1. Angka kematian pasien karena operasi                    |
|                                             | 2. Angka decubitus                                         |
|                                             | 3. Angka pasien jatuh                                      |
|                                             | 4. Angka pasien jatuh dengan cedera                        |
|                                             | 5. Angka <i>restrain</i>                                   |
|                                             | 6. ISK karena pemasangan cateter di ICU                    |
|                                             | 7. <i>Blood stream infection</i> karena pemasangan cateter |
|                                             | 8. VAP di ICU dan HDNC                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategori II</b>                      | <b>Ukuran</b>                                                                                                                                                                                          |
| Ukuran berfokus pada intervensi perawat | 9. Konseling berhenti merokok pada kasus AMI<br>10. Konseling berhenti merokok pada kasus gagal jantung<br>11. Konseling berhenti merokok pada kasus pneumonia                                         |
| <b>Kategori III</b>                     | <b>Ukuran</b>                                                                                                                                                                                          |
| Ukuran berfokus pada system             | 12. Perbandingan antara RN, LVN/LPN, UAP dan kontrak<br>13. Jam perawatan pasien per hari oleh RN, LVN/LPN dan UAP<br>14. <i>Practice Environment Scale-Nursing Work Index</i><br>15. <i>Turn over</i> |

Menurut (Depkes, 2008) indikator mutu pelayanan keperawatan dibagi menjadi 6, yaitu:

a. Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Indicator keselamatan pasien (*patient safety*) adalah penilaian pada pasien dengan kriteria aman dari kejadian pasien jatuh, decubitus, kesalahan dalam pemberian obat, serta cedera akibat *restrain*.

1) Kejadian Pasien Jatuh

Kejadian pasien jatuh dapat menyebabkan risiko cedera fisik. Pendekatan pengurangan pasien risiko jatuh dikembangkan oleh fasilitas layanan kesehatan untuk mengurangi risiko cedera akibat jatuh bagi pasien. Fasilitas layanan kesehatan perlu mengevaluasi risiko cedera bila jatuh termasuk riwayat jatuh, obat yang telah digubnakan, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan (Mandias dkk, 2021). Persentase kejadian pasien jatuh dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien jatuh}}{\text{jumlah pasien yang berisiko jatuh}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pasien jatuh yaitu jatuhnya pasien saat istirahat maupun terjaga yang tidak disebabkan oleh serangan stroke, epilepsy, seizure, bahwa karena terlalu banyak aktifitas.
- Jumlah pasien jatuh yaitu total jumlah pasien jatuh yang dirawat selama waktu tertentu setiap bulan
- Jumlah pasien risiko jatuh yaitu total jumlah pasien yang berisiko jatuh yang dirawat selama periode waktu tertentu setiap bulan

## 2) Kejadian Dekubitus

Decubitus adalah luka tekan yang disebabkan karena pasien mengalami gangguan mobilitas seperti pada kasus injuri tulang belakang, pasien yang mengalami stroke, serta penyakit degenerative lainnya, atau pasien dengan penggunaan alat bantu ambulasi seperti kursi roda yang lama. Kejadian decubitus harus dilakukan pengumpulan data setiap hari (Winasari dkk, 2021). Hal tersebut biasanya menggambarkan terjadinya kerusakan integritas kulit. Persentase kejadian decubitus dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah kejadian dekubitus}}{\text{jumlah pasien berisiko terjadi dekubitus}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah kejadian decubitus adalah jumlah kejadian baru decubitus dalam periode tertentu.
- Jumlah pasien berisiko terjadi decubitus adalah jumlah pasien yang mempunyai risiko terjadi decubitus selama periode waktu tertentu. Pasien yang memiliki risiko decubitus adalah pasien baru setelah dilakukan pengkajian memiliki satu atau lebih faktor risiko, seperti: usia lanjut; pasien dengan cedera medulla spinalis atau cedera kepala atau mengalami penyakit neuromuskular, sehingga pasien tidak mampu bergerak pada bagian tubuh tertentu secara mandiri; malnutrisi/kelainan status gizi; berbaring lama; mengalami kondisi kronik seperti Diabetes, serta penyakit vaskuler lainnya; serta iritasi kulit yang lembab akibat inkontinen urine dan feses,

## 3) Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

Kejadian kesalahan pemberian obat merupakan salah satu kejadian tidak diharapkan atau insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Pemberian obat di fasilitas pelayanan kesehatan harus diwaspadai sehingga digubakan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai (*high-alert*), yaitu obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (*sentinel event*), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (*adverse outcome*) misalnya obay terlihat mirip dan kedengaran mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/LASA*) (Mangindara dkk, 2022). Jumlah pasien yang mengalami kejadian kesalahan pemberian obat yaitu jumlah insiden KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) atau KNC (Kejadian Nyaris Cedera) yang terjadi dalam sehari.



Persentase angka KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) akibat kesalahan pemberian obat dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang terkena kejadian tak diharapkan dalam pemberian obat}}{\text{jumlah pasien pada hari tersebut}} \times 100\%$$

Persentase angka KNC (Kejadian Nyaris Cedera) akibat kesalahan pemberian obat dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang terkena kejadian nyaris cedera dalam pemberian obat}}{\text{jumlah pasien pada hari tersebut}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kejadian salah pemberian obat adalah harus sesuai dengan 6 benar pemberian obat yaitu: salah pasien (salah nama dan tidak sesuai dengan identitas medical record); salah waktu (terlambat pemberian obat yaitu 30 menit setelah jadwal, pemberian obat yang terlalu cepat yaitu 30 menit sebelum jadwal, serta obat stop tapi tetap dilanjutkan), salah cara pemberian/route (salah cara pemberian obat, misalnya obat intramuscular diberikan secara intravena); salah dosis (dosis berlebihan atau dosis kurang); salah obat (obat yang diberikan tidak sesuai dengan yang diresepkan); serta salah dokumentasi (dokumentasi tidak dilakukan sesuai dengan pelaksanaan).
- KTD (Kejadian tidak diharapkan/*adverse event*) yaitu kejadian salah pemberian obat yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan karena suatu tindakan atau karena tidak bertindak.
- KNC (Kejadian nyaris cedera/*near miss*) yaitu kesalahan tindakan pemberian obat atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dalam pemberian obat pada kasus tertentu yang dapat mencederai pasien.

4) Kejadian cedera akibat *restrain*

*Restrain* merupakan metode dengan penggunaan alat/mekanik, serta zat kimia yang dapat melumpuhkan atau mengurangi kemampuan pasien untuk menggerakkan tubuh, lengan, kaki, atau kepala secara bebas (Shodiqurrahman dkk., 2022). Pasien yang dipasang *restrain* beresiko terjadi cedera berupa lecet pada kulit, atau terjatuh, atau aspirasi. Persentase kejadian cedera akibat *restrain* dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien dengan cedera akibat restrain}}{\text{total pasien yang dipasang restrain}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Cedera akibat *restrain* yaitu berupa lecet pada kulit, terjatuh atau aspirasi akibat pemasangan *restrain*, kecuali pasien sudah cedera sebelum *restrain* dipasang.
- Jumlah pasien cedera akibat pemasangan *restrain* yaitu jumlah pasien yang cedera saat pemasangan *restrain*.
- Total pasien yang terpasang *restrain* adalah semua pasien yang dipasang *restrain* pada periode waktu tertentu.

b. Keterbatasan Perawatan Diri

Perawatan diri pasien dalam aktifitas sehari-hari pasien seperti makan dan minum, mandi, berpakaian, dan kebersihan diri (*eliminasi/toileting*). Kebutuhan pasien untuk pemenuhan perawatan diri bersifat sementara, atau permanen, atau rehabilitasi (Siregar dkk., 2021). Pada dasarnya pasien yang dirawat memiliki keterbatasan perawatan diri tergantung dari kondisi penyakit yang mengakibatkan tingkat ketergantungan pasien pada asuhan. Persentase keterbatasan perawatan diri dengan tingkat ketergantungan pasien sebagian atau total dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang tidak terpenuhi kebutuhan diri}}{\text{jumlah pasien dirawat dengan tingkat ketergantungan sebagian dan total}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Jumlah pasien tidak terpenuhi kebutuhan diri yaitu pada bulan pengukuran Sub indikator tidak terpenuhinya perawatan diri yaitu mandi (kulit, gigi, mata, rambut, tidak bau badan, perineum bersih), berpakaian (baju bersih dan kering, rambut rapih, wajah segar), dan eliminasi/*toileting* (berkemih dan defekasi dengan pola yang normal).

Jumlah pasien ketergantungan sebagian total adalah jumlah pasien pada bulan pengukuran

c. Tingkat Kepuasan Pasien dan Keluarga terhadap Pelayanan Keperawatan

Salah satu indikator standar pelayanan minimal rumah sakit adalah kepuasan pasien. Secara umum kepuasan pasien berhubungan dengan pengalaman pasien atas pelayanan yang diterima selama dirawat di fasilitas layanan kesehatan, yang biasanya diukur melalui riset dengan kuesioner atau angket atau kartu respon pasien (Talib, 2022). Pelayanan keperawatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan harus memberikan asuhan keperawatan yang profesional sehingga tingkat kepuasan pasien dan keluarga pasien dapat ditingkatkan. Persentase pengukuran tingkat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang menyatakan puas terhadap layanan keperawatan}}{\text{jumlah pasien yang dilakukan survey pada periode tertentu}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kriteria pasien yang dilakukan survey adalah setiap pasien baru yang telah dirawat: selama 3 (tiga) hari, tidak pulang paksa, dan pulang hidup.

d. Kenyamanan

Kenyamanan terbagi menjadi dua yaitu angka tatalaksana pasien nyeri dan angka kenyamanan pasien. Kenyamanan dalam hal ini berhubungan dengan penatalaksanaan nyeri. Penatalaksanaan nyeri merupakan salah satu tindakan utama dari pelayanan keperawatan. penatalaksanaan nyeri dilakukan untuk mempertahankan rasa nyaman dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Pengukuran kenyamanan pasien dilakukan pada semua pasien di unit perawatan per bulan. Persentase kenyamanan dapat diukur dengan rumus:

a) Angka tatalaksana pasien nyeri

Persentase dengan nyeri yang terdokumentasi dalam askep

$$\frac{\text{jumlah total pasien nyeri yang terdokumentasi}}{\text{jumlah total pasien per periode waktu tertentu}} \times 100\%$$

Persentase tatalaksana pasien nyeri

$$\frac{\text{jumlah total tindakan perawat sebagai respon nyeri}}{\text{jumlah total pasien terdokumentasi nyeri skala } \geq 4 \text{ per periode tertentu}} \times 100\%$$

b) Persentase angka kenyamanan pasien

$$\frac{\text{jumlah pasien dengan nyeri terkontrol}}{\text{jumlah total pasien terdokumentasi nyeri per periode tertentu}} \times 100\%$$

Keterangan angka tatalaksana nyeri dan angka kenyamanan pasien:

- Tindakan perawat yaitu semua tindakan asuhan keperawatan untuk merespon nyeri dengan ambang skala yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat.
- Nyeri yaitu perasaan/sensasi tidak nyaman yang bersifat subjektif (diutarakan oleh pasien) dan perlu ditangan dengan penatalaksanaan nyeri.
- Tujuan indikator ini yaitu dilakukan berbagai tindakan pada ppasien dengan skala nyeri lebih atau sama dengan 4 (empat), dimana tidak termasuk kewajiban saat melakukan *follow-up* pengkajian.

e. Angka Kejadian Cemas

Menurut (Pranata dkk., 2021) cemas memiliki dua arti, yaitu cemas sebagai emosi yang merupakan pengalaman subjektif individual (dilihat dari tingkah laku pasien) dan cemas dengan emosi tanpa objek yang spesifik (penyebab tidak diketahui). Status kesehatan pasien dapat dipengaruhi oleh cemas yang dialami. Hal tersebut karena adanya perasaan tidak nyaman yang dapat menimbulkan menambah hari rawat. Cemas juga dapat menimbulkan cedera diri sendiri maupun orang lain. Persentase perhitungan angka kejadian cemas dapat diukur dengan rumus:

Angka kejadian cemas pada ruang rawat umum

$$\frac{\text{jumlah pasien cemas}}{\text{jumlah pasien yang dirawat}} \times 100\%$$

Angka kejadian cemas pada ruang rawat psikiatri

$$\frac{\text{jumlah pasien cemas 3x24 jam}}{\text{jumlah pasien yang dirawat dalam kurun waktu 3x24 jam}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Angka kejadian pasien cemas yaitu presentase jumlah prevalensi cemas (dari rata-rata identifikasi aspek yang dirawat di sarana kesehatan selama periode waktu tertentu per bulan.
- b) Jumlah pasien cemas yang dirawat yaitu total jumlah pasien cemas yang dirawat di sarana kesehatan selama periode waktu tertentu setiap bulan

f. Pengetahuan

Aspek Pengetahuan terbagi atas 2 yaitu pengetahuan tentang penyakitnya, dan perencanaan pasien pulang (*discharge planning*).

a) Pengetahuan tentang perawatan penyakit

Pengetahuan pasien tentang perawatan penyakitnya merupakan aspek yang sangat penting dalam proses perawatan pasien. Indikator ini menunjukkan kemungkinan masalah dalam edukasi kepada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing pasien di ruang rawat. Persentase pengetahuan tentang penyakit dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang kurang pengetahuan}}{\text{jumlah pasien yang dirawat pada periode tertentu}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah pasien yang kurang pengetahuan yaitu jumlah pasien yang menunjukkan kurang pengetahuan pasien dan keluarga setelah dikaji tentang penyakitnya.
- Jumlah pasien yang dirawat pada periode tertentu yaitu jumlah pasien yang dirawat di ruang tertentu serta dihitung pada periode tertentu

b) Perencanaan pasien pulang (*discharge planning*)

Perencanaan pasien pulang (*discharge planning*) adalah keterlibatan seluruh profesional pemberi asuhan (dokter, perawata, apoteker, ahli gizi, dan lainnya) pada proses rencana pemulangan pasien dengan tujuan mempersiapkan pasien untuk melakukan perawatan lanjutan di rumah setelah meninggalkan rumah sakit (Rahayu, 2020). Rencana pemulangan pasien sudah dibuat mulai dari pasien masuk rumah sakit. Persentase angka pengetahuan terkait perencanaan pulang pasien dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{jumlah pasien yang tidak dibuat discharge planning pada periode tertentu}}{\text{jumlah pasien yang dirawat pada periode tertentu}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah pasien yang tidak dibuat *discharge planning* pada periode tertentu yaitu jumlah pasien yang dirawat pada periode tertentu tapi tidak dibuat *discharge planning*.

#### F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan

Beberapa ahli menjabarkan faktor faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, antara lain:

1. Menurut Wijono (2008) dalam (Siregar, 2022), ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, yaitu;
  - a. Perilaku tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan,
  - b. Fungsi terapi, meliputi konsultasi/pemberian keterangan tentang penyakit yang diderita, pencegahan tenggang rasa, perawatan lebih lanjut dan kebijakan manajemen,
  - c. Fungsi perawatan, meliputi rasa nyaman dan senang, dimana adanya perhatian, sopan, cepat tanggap terhadap keluhan pasien, serta kebijakan manajemen rumah sakit, dan
  - d. Sarana dan prasarana, meliputi adanya tenaga perawat yang profesional, adanya tempat perawatan yang layak, serta fasilitas yang mumpuni.
2. Menurut (Triwibowo, 2013), faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen mutu pelayanan keperawatan, meliputi:

- a. Mengetahui kemampuan diri, yaitu perawat mampu mengintrospeksi diri dengan baik, sehingga mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Sebelum melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, perawat harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya.
  - b. Meningkatkan kerja sama, yaitu perawat harus mampu bekerja bersama teman sejawat maupun profesional pemberi asuhan lainnya (dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapi dan lainnya, serta mampu bekerja sama dengan pasien dan keluarga pasien.
  - c. Pengetahuan tugas, yaitu perawat harus tahu terkait proses perawatan pasien selama dirawat di rumah sakit. apengetahuan perawat yang baik dapat membantu pasien dalam menangani keluhan pasien selama proses penyembuhan.
  - d. Penyelesaian tugas, yaitu perawat dituntut untuk melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan secara lengkap setelah melakukan asuhan keperawatan. perawat harus mengetahui keluhan pasien serta pengobatan yang dijalani oleh pasien dengan cara mencatat atau mendokumentasikannya.
  - e. Pertimbangan prioritas keperawatan, yaitu tindakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan prioritas masalah utama pasien. Perawat harus mampu membuat tindakan asuhan keperawatan sesuai priotitas tersebut.
3. Menurut (Nursalam, 2014), faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan, adalah:
- a. Komunikasi dari mulut ke mulut (*word of mouth communication*), dimana perlakuan baik yang diterima pasien pada saat dirawat akan menjadi kesan baik, dan akan diceritakan kepada orang disekelilingnya. Oleh karena itu, sikap perawat dalam membantu proses penyembuhan pasien selama dirawat di fasilitas layanan kesehatan akan mempengaruhi citra dari tatanan layanan kesehatan tersebut. Sebaliknya jika pasien merasa tidak puas dengan pelayanan keperawatan yang diberikan maka akan menjadi kesan yang tidak baik.
  - b. Kebutuhan pribadi (*personal need*)  
Mutu pelayanan keperawatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi pasien tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien yang berbeda. Perawat harus mampu memberikan asuhan keperawatan dengan penuh tanggung jawab dan perhatian sesuai standar operasional prosedur yang berlaku meskipun tidak diminta oleh pasien.
  - c. Pengalaman masa lalu (*past experience*)  
Pengalaman terkadang merupakan patokan dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pasienpun terkadang menilai sesuatu berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Dalam memberikan asuhan keperawatan,

jika pasien pernah mengalami hal yang kurang baik maka akan melekat pada ingatannya dan pasien akan mencoba mencari pengobatan di tempat yang lain.

d. Komunikasi eksternal (*company's external communication*)

Rumah sakit dapat melakukan promosi kepada masyarakat sebagai pemberi mutu pelayanan kesehatan.

## G. Analisis Situasi

Analisis situasi yakni analisis **SWOT** (**Strenght, Weaknes, Opportunities, Threats**) mutu pelayanan keperawatan dapat dikaitkan dengan ruang lingkup manajemen mutu pelayanan keperawatan, sebagai berikut:

| Analisa SWOT<br>Mutu Pelayanan<br>Keperawatan | <b>Opportunities (O)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap tindakan asuhan keperawatan (tindakan mandiri dan kolaborasi)</li> <li>• Adanya institusi pendidikan keperawatan yang bekerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas</li> <li>• Fasilitas Rumah Sakit yang memadai (kamar mandi selalu dibersihkan petugas kebersihan, desain bangunan tidak menimbulkan resiko cedera pasda pasien, keluarga pasien, maupun petugas, kondisi permukaan yang memadai, serta pencahayaan ruangan rawat yang baik).</li> <li>• Kredensialing dilakukan secara periodic untuk menunjang jenjang karir perawat.</li> <li>• Bidang diklat menyediakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan</li> <li>• Fungsi manajemen keperawatan berjalan dengan baik (manager bidang keperawatan melaksanakan fungsi manajemen keperawatan, yakni Kepala bidang, Kepala Unit, dan Kepala Ruang)</li> </ul> | <b>Threats (T)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dengan fasilitas yang baik.</li> <li>• Tingginya kesadaran dan perhatian masyarakat terkait peraturan tentang kesehatan.</li> <li>• Tingginya penggunaan sosial media yang dapat mempercepat penyebaran informasi.</li> <li>• Adanya UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>• Adanya peraturan Internal Rumah Sakit/Puskesmas.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Strength (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Strategi S-O</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Strategi S-T</b>                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Keselamatan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insiden decubitus tidak ditemukan selama sebulan terakhir</li> <li>• Insiden kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera pada pemberian obat oleh perawat tidak ditemukan selama sebulan terakhir</li> <li>• Insiden pasien jatuh tidak ditemukan selama sebulan terakhir</li> <li>• Insiden pasien cedera akibat <i>restrain</i> tidak ditemukan selama sebulan terakhir</li> </ul> <p>2. Keterbatasan Perawatan diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insiden pasien cedera akibat tidak teroenehinya kebutuhan perawatan diri tidak ditemukan selama sebulan terakhir.</li> </ul> <p>3. Kepuasan Pasien dan Keluarga Pasien terhadap Pelayanan Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat dengan tingkat pendidikan Ners dan Ners Spesialis (Professional) dengan perawat D3 (Vokasional) memiliki perbandingan 6:4.</li> <li>• Kemudahan serta kecepatan pelayanan yang diberikan oleh perawat</li> <li>• Perawat konsisten dalam perawatan pasien karena selalu datang sesuai dengan kontrak waktu yang sudah disepakati</li> <li>• Pre and Post Conference menjadi kegiatan wajib perawat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan asuhan keperawatan sesuai SOP yang berlaku.</li> <li>• Melibatkan perawat dalam kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan mutu pelayanan keperawatan agar menjadi fasilitas layanan kesehatan yang menjadi pilihan masyarakat</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Kenyamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penerapan 4S dalam asuhan keperawatan (SDKI, SIKI, SLKI, dan Standar Panduan Askep)</li> </ul> <p>5. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan intervensi pada asuhan keperawatan mencakup intervensi mandiri, intervensi kolaborasi, dan intervensi edukasi)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Weakness (W)</b></p> <p>1. Keselamatan Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada peningkatan pasien berisiko terjadi decubitus (pasien usia lanjut, pasien dengan cedera sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa bantuan, pasien malnutrisi/ status gizi kurang, pasien berbaring lama, pasien kronik seperti Diabetes dan penyakit vaskuler lainnya, pasien dengan inkontinen urine dan feses)</li> <li>• Ada peningkatan pasien berisiko jatuh dari segi instrinsik (pasien dengan riwayat jatuh sebelumnya, pasien dengan penurunan ketajaman penglihatan, pasien dengan penurunan system muskuloskeletal.</li> <li>• Ada risiko pasien cedera akibat restrai karena adanya pasien yang dipasang restrain selama periode waktu sebulan terakhir.</li> </ul> <p>2. Keterbatasan Perawatan Diri</p> | <p><b>Strategi W-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyerap lulusan keperawatan sehingga dapat menyeimbangkan rasio perawat dan pasien</li> <li>• Melakukan semua proses keperawatan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat mengurangi mutu pelayanan keperawatan</li> <li>• Merekomendasikan perawat secara bertahap untuk mengikuti pelatihan-pelatihan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.</li> <li>• Meningkatkan fungsi manajemen keperawatan dalam mengontrol asuhan keperawatan yang diberikan untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum</li> </ul> | <p><b>Strategi W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan semua proses keperawatan berdasarkan standar operasional prosedur untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pasien dengan tingkat ketergantungan parsial (sebagian) dan total (sepenuhnya).</li> </ul>                                                                                                                          |  |  |
| 3. Kepuasan Pasien dan Keluarga Pasien terhadap Pelayanan Keperawatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio perawat berbanding pasien tidak sesuai dengan standar minimal pelayanan kesehatan (lebih banyak rasio pasien dibanding perawat).</li> </ul> |  |  |
| 4. Kenyamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah pasien yang terdokumentasi nyeri selama sebulan terakhir</li> </ul>                                                                                                                    |  |  |
| 5. Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pasien yang tidak dibuatkan <i>discharge planning</i> sehingga berisiko kurang pengetahuan setelah pulang dari rumah sakit.</li> </ul>                                                               |  |  |

#### H. Prioritas Masalah

Masalah didapat setelah menyusun analisis situasi SWOT. Terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, oleh karena itu perlu dilakukan penentuan prioritas masalah. Prioritas masalah adalah cara yang dilakukan untuk memudahkan penentuan urutan pada masalah yang telah didapatkan. Pada prioritas masalah dimulai dengan melakukan perhitungan, kemudian pembobotan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. *Magnitude* (M) : masalah yang cenderung atau sering terjadi
2. *Severity* (S) : besar kerugian yang dapat ditimbulkan
3. *Manageable* (Mn) : dapat dipecahkan
4. *Nursing concern* (Nc) : perhatian dan pertimbangan perawat dilibatkan
5. *Affordability* (Af) : sumber daya yang tersedia

Prioritas masalah dinilai dengan rentan 1 sampai 5 yaitu: 5=sangat penting, 4=penting, 3=cukup penting, 2=kurang penting, 1=sangat kurang penting. Perhitungan skor didapat dari: **M x S x Mn x Nc x Af**. Kesimpulan akhir yang menjadi prioritas adalah masalah yang memiliki jumlah atau skor terbesar.

| No | Masalah                                                                                                                  | Pembobotan |    |    |    |    |       | Prioritas |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|-------|-----------|
|    |                                                                                                                          | Mg         | Sv | Mn | Nc | Af | Total |           |
| 1  | 2                                                                                                                        | 3          | 4  | 5  | 6  | 7  | 8     | 9         |
| 1  | Adanya risiko insiden keselamatan pasien                                                                                 | 5          | 5  | 5  | 4  | 4  | 2000  | 1         |
| 2  | Adanya risiko insiden keterbatasan perawatan diri pada pasien dengan tingkat ketergantungan parsial (sebagian) dan total | 3          | 3  | 3  | 4  | 2  | 216   | 5         |
| 3  | Adanya risiko kurangnya kepuasan pasien dan keluarga pasien terhadap perawat                                             | 4          | 4  | 3  | 3  | 3  | 576   | 2         |
| 4  | Adanya risiko angka tatalaksana pasien nyeri dan kenyamanan pasien terhadap nyeri                                        | 4          | 3  | 3  | 3  | 4  | 432   | 3         |
| 5  | Adanya resiko kurang pengetahuan pasien terhadap rencana perawatan pasien setelah pulang dari rumah sakit                | 4          | 3  | 3  | 4  | 2  | 288   | 4         |

#### I. Alternatif Solusi

Alternatif solusi dilakukan dengan menggunakan pembobotan **CARL** (*Capability, Accessability, Readiness, Leverage*) dengan pembobotan nilai antara 1 sampai 5, yaitu 5 = sangat mampu, 4 = mampu, 3 = cukup mampu, 2 = kurang mampu dan 1 = tidak mampu., sebagai berikut:

| No | Alternatif Pemecahan Masalah                                                                                                       | C | A | R | L | Skor | Prioritas |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|-----------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    | 8         |
| 1. | Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan asuhan keperawatan sesuai SOP yang berlaku                               | 4 | 4 | 4 | 4 | 256  | 1         |
| 2. | Melibatkan perawat dalam kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan                                                           | 3 | 3 | 4 | 2 | 72   | 5         |
| 3. | Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyerap lulusan keperawatan sehingga dapat menyeimbangkan rasio perawat dan pasien | 4 | 4 | 3 | 3 | 144  | 3         |
| 4. | Melakukan semua proses keperawatan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku                                           | 4 | 3 | 3 | 4 | 192  | 2         |
| 5  | Merekomendasikan perawat secara bertahap untuk mengikuti pelatihan-pelatihan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.              | 4 | 2 | 4 | 4 | 128  | 4         |

### J. *Plan of Action*

Rencana kegiatan untuk mengatasi masalah mutu pelayanan keperawatan adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                                                                                                           | Target Waktu | Sasaran         | Hasil yang Diharapkan                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menerapkan asuhan keperawatan sesuai SOP yang berlaku                               | Disesuaikan  | KaRu, KaTim, PP | Mutu Pelayanan Keperawatan meningkat                                                                                               |
| 2. | Melibatkan perawat dalam kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan                                                           | Disesuaikan  | KaRu, KaTim, PP | Mengembangkan ilmu pengetahuan perawat dalam penatalaksanaan asuhan keperawatan                                                    |
| 3. | Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyerap lulusan keperawatan sehingga dapat menyeimbangkan rasio perawat dan pasien | Disesuaikan  | KaRu, KaTim, PP | Menjaring lulusan keperawatan untuk bekerja                                                                                        |
| 4. | Melakukan semua proses keperawatan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku                                           | Disesuaikan  | KaRu, KaTim, PP | Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan                                                                                            |
| 5  | Merekomendasikan perawat secara bertahap untuk mengikuti pelatihan-pelatihan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.              | Disesuaikan  | KaRu, KaTim, PP | Perawat mampu melakukan <i>discharge planning</i> untuk mempersiapkan pasien pulang dengan perawatan lanjutan di rumah dengan baik |

### K. Implementasi

Implementasi mutu pelayanan keperawatan adalah melakukan strategi alternatif pemecahan masalah yang telah disusun dalam rencana kerja (*plan of action*) dengan memperhatikan target waktu capaian, sasaran, serta hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan.

### L. Evaluasi

Evaluasi mutu pelayanan keperawatan adalah melihat dan menilai hasil dari implementasi kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi mutu pelayanan keperawatan yaitu dengan melihat dan menilai target waktu yang ditetapkan dapat dicapai, melihat dan menilai kegiatan yang dilakukan tepat sasaran yang ditergetkan, dan hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.



# MANAJEMEN WAKTU



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

## MANAJEMEN WAKTU

### A. Pendahuluan

Perawat adalah seseorang yang telah lulus sekolah tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.(Undang-undang, 2014)

Semua orang dilayanan menggunakan manajemen waktu untuk aktivitas apapun. Kemampuan mengatur waktu inilah yang membuat seseorang menjadi sukses. Agar pengelolaan waktu berhasil, perlu menggunakan waktu secara efektif dengan cara: 1) menganalisis waktu yang dihabiskan dengan mengembangkan jadwal dan kategori kegiatan, 2) memeriksa kembali setiap bagian kategori terhadap waktu yang tersedia, 3) menentukan mendesak, tidak prioritas pekerjaan yang mendesak/rutin, 4) Mendelegasikan kepada bawahan sesuai dengan sifat pekerjaannya. (Sri Mugianti, 2016)

Pelayanan kesehatan khususnya pemberian asuhan holistik menuntut perawat untuk dapat mengatur waktunya dengan baik. Manajemen waktu dalam keperawatan membantu perawat mengatur dan memprioritaskan perawatan klien, tugas manajemen ruangan, tanggung jawab untuk perbaikan diri atau pendidikan, dan kewajiban pribadi lainnya. Meskipun keperawatan adalah profesi yang menuntut, perawat yang mengembangkan teknik untuk mengatur waktu mereka dengan lebih baik dapat mencapai keseimbangan dalam menghadapi keterbatasan waktu.(Muchlis et al., 2013)

Manajemen pada pelayanan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada semua komponen yang terlibat di dalamnya, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi di Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya bergantung pada waktu pemberian perawatan. Pelayanan keperawatan yang tertata dengan baik diharapkan dapat memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan medis khususnya pelayanan keperawatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban kerja untuk staf perawat saat jam kerja sangat terbatas. Terkait dengan hal tersebut manajemen waktu dalam pelayanan keperawatan khususnya di Rumah Sakit adalah penting sekali.(Liu et al., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Yusuf (2013) didapatkan hasil ada hubungan perencanaan waktu dengan pendokumentasian nilai p-value (0,018), Hasil secara

umum terdapat hubungan yang bermakna antara manajemen waktu dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun 2013. Sebanyak 38 responden termasuk kategori manajemen waktu baik dan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan baik. (Yusuf, 2013) Hasil penelitian Pangemanan: ada hubungan antara manajemen waktu dengan produktivitas kerja perawat pelaksana di IRINA A. RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado dengan P value 0,004. (Pangemanan et al., 2014)

## **B. Pengertian**

Manajemen waktu adalah suatu cara pengaturan waktu dan pemanfaatan waktu dalam mengerjakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, dimana penyelesaian sesuai dengan waktu yang ditetapkan. (Munandar et al., 2020). Manajemen waktu merupakan kemampuan untuk merencanakan, menjadwalkan, memprioritaskan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut. Seorang perawat pelaksana harus bisa menggunakan waktu secara baik. Diantara tenaga kesehatan yang ada, tenaga perawat memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan karenanya produktivitas dari tenaga keperawatan harus dijaga. (Pangemanan et al., 2014)

## **C. Tujuan dan Fungsi Manajemen Waktu**

Efektivitas waktu pelayanan keperawatan dalam memberikan asuhan sangat didukung oleh kemampuan pimpinan atau manajer dalam mengatur penggunaan waktu kerja secara tepat. Tujuan manajemen waktu dalam pelayanan keperawatan adalah merencanakan dan mengatur waktu secara efektif sehingga asuhan langsung kepada klien (meliputi: pengkajian, keperawatan, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, pemberian dan evaluasi keperawatan), dokumentasi, konsultasi dan kolaborasi, proses transaksional, Transportasi, administrasi, pelayanan kesehatan.

Peran kepemimpinan dan fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk efektivitas manajemen waktu: (Marquis, B.L., 2015)

### **1. Peran kepemimpinan**

- a. Mengarahkan perawat pada tugas-tugas yang menjadi prioritas, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas penting tersebut dengan tepat waktu.
- b. Berfokus sebagai model peran, pendorong dan sumber bagi bawahan dalam menyusun prioritas.
- c. Membantu bawahan atau perawat untuk bekerja secara kooperatif dan memaksimalkan penggunaan waktu.
- d. Mencegah atau menyaring gangguan yang menghalangi manajemen waktu yang efektif.



- e. Memprioritaskan profesional daripada penggunaan waktu perawatan yang tidak bermanfaat.
  - f. Menampilkan sikap tenang dan tekun selama periode aktivitas pada unit pelayanan.
  - g. Fleksibilitas model peran dalam bekerja secara kooperatif dengan orang lain yang memiliki gaya manajemen waktu primer berbeda.
2. Fungsi manajemen
- a. Menyusun prioritas rencana kerja harian, bulanan dan tahunan secara tepat
  - b. Mementaskan perencanaan ke dalam jadwal kerja
  - c. Menganalisa pengaturan waktu pada pelayanan dengan pekerjaan
  - d. Menghindari hambatan dari factor lingkungan
  - e. Pendokumentasian secara tepat dan efisien serta mempertahankan kondisi kerja kondusif.
  - f. Memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama.
  - g. Menggunakan teknologi yang tepat untuk memfasilitasi komunikasi dan dokumentasi yang tepat waktu.
  - h. Membedakan antara kepersonaliaan yang tidak adekuat dan penggunaan waktu yang tidak efisien ketika sumber waktu tidak adekuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

#### **D. Manfaat Manajemen Waktu**

Manfaat manajemen waktu adalah sebagai berikut:

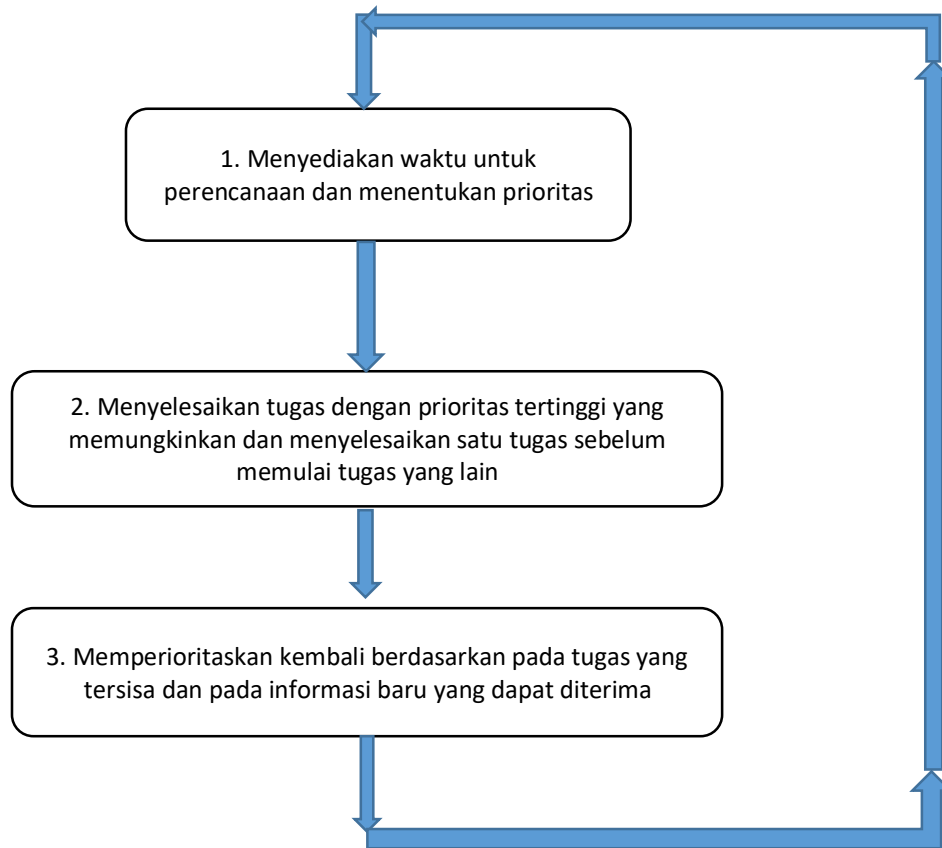
1. Bersikap disiplin, teratur, terencana, dan lebih rapi
2. Meningkatkan produktivitas
3. Mengurangi stress dan kecemasan
4. Memberikan reputasi positif.
5. Memudahkan mencapai target harian
6. Bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya.
7. Meningkatkan kualitas kerja.
8. Hubungan di tempat kerja lebih baik
9. Pengambilan keputusan lebih efisien

#### **E. Ruang Lingkup Manajemen Waktu**

Menurut (I. P. Dewi, 2014) ruang lingkup manajemen waktu merupakan pengelolaan waktu dengan baik dan efektif yang memiliki suatu tujuan yang jelas, membuat suatu skala prioritas, berani mengatakan tidak ketika akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas, jangan menunda suatu pekerjaan dan mendelegasikan suatu tugas sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan.

## F. Langkah Dasar Dalam Manajemen Waktu

Tiga langkah manajemen waktu dapat dilihat pada bagan 7.1 dibawah ini:(Muchlis et al., 2013)



Bagan. 7.1 Tiga langkah manajemen waktu

Berdasarkan bagan 7.1 dapat dijelaskan tiga langkah dasar dalam manajemen waktu:

### 1. Menyiapkan waktu untuk perencanaan dan menentukan prioritas.

Dua kesalahan yang sering dilakukan oleh para manajer pemula menganggap remeh pentingnya rencana harian dan tidak menyediakan waktu yang adekuat untuk perencanaan. Perencanaan harian sangat penting jika pengelolaan manajer kearah efisien, bukan krisis. Para manajer merasa tidak produktif jika mereka duduk di belakang meja membuat perencanaan harian itu daripada melaksanakan tugas spesifik. Namun tanpa perencanaan yang adekuat, manajer menemukan kesulitan saat memulai mengelola krisis. Selain itu, mungkin saja tidak ada yang dapat dicapai pada hari tersebut jika, jika tujuan hari itu tidak diuraikan dengan jelas.

2. Menyelesaikan tugas dengan prioritas tertinggi yang memungkinkan dan menyelesaikan satu tugas sebelum memulai tugas yang lain.

Menyusun prioritas merupakan keterampilan yang paling kritis dalam manajemen waktu yang baik karena semua tindakan yang kita ambil memberikan beberapa jenis kepentingan yang relative.

Cara sederhana dalam memprioritaskan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas adalah membagi semua permintaan terhadap waktu kita k dalam tiga kategori: “jangan lakukan”, “lakukan nanti” dan “lakukan sekarang”. Katergori “jangan lakukan” menggambarkan masalah yang akan diatasi oleh mereka sudah lampau atau lebih baik dilakukan orang lain. Kategori “lakukan nanti” menggambarkan masalah yang tidak penting atau hal yang memiliki tidak ada batas waktu segera, sehingga dapat ditunda.

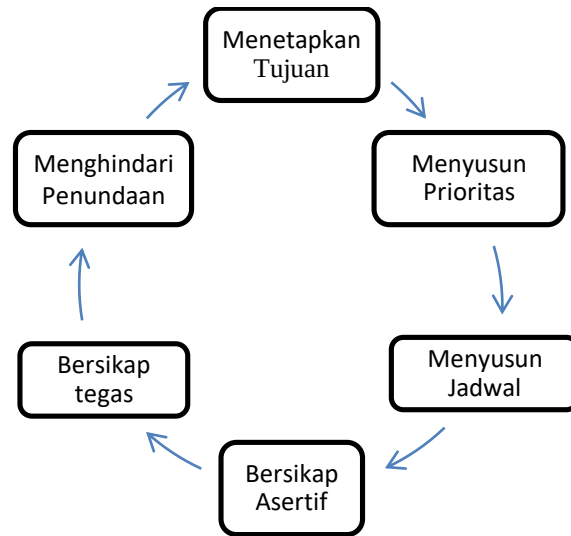
Penundaan berarti meletakkan sesuatu sampai waktu yang akan datang, mengundur waktu atau menunda hal yang tidak diperlukan. Penundaan merupakan masalah utama yang dapat mengurangi produktivitas dan mempengaruhi karir. Permintaan “lakukan sekarang” paling sering menggambarkan kebutuhan operasional unit sehari-hari. Permintaan ini meliputi kebutuhan kepersonaliaan harian, mengatasi keterbatasan persediaan alat, jadwal rapat, melakukan wawancara kontrak dan melakukan penilaian kerja. Dalam memprioritaskan semua hal “lakukan sekarang”, manajer dapat mempersiapkan bantuan daftar tertulis.

3. Memprioritaskan kembali berdasarkan pada tugas yang tersisa dan pada informasi baru yang dapat diterima.

Secara periodik, manajer harus mengkaji ulang daftar dari prioritas harian untuk melihat apakah ada yang tidak dilakukan atau yang sudah dilakukan. Beberapa rencana perlu dikeluarkan dari daftar karena hal tersebut tidak dipecahkan kedalam tugas yang mampu dikelola. Manajer harus ingat bahwa suatu daftar adalah alat perencanaan, harua ada fleksibilitas dalam mengimplementasikannya. Kenyataannya langkah terakhir dalam manajemen waktu adalah prioritaskan kembali.

## **G. Aspek-Aspek Manajemen Waktu**

Setelah melihat efek positif terhadap manajemen waktu yang mampu membuat penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya aspek-aspek dalam manajemen waktu. (Erita, 2019), (Osterweil et al., 2010)



Bagan 7.2 Aspek-Aspek Manajemen Waktu

Menurut Atkinson, aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup hal-hal berikut:

1. Menetapkan Tujuan

Bagian utama dari pengelolaan waktu adalah menetapkan tujuan dari apa yang akan dikerjakan. Menetapkan tujuan dapat membantu individu untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan, fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan.

2. Menyusun Prioritas

Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga pada prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting, mendesak, maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Atkinson berpendapat menyusun prioritas membutuhkan ketelitian tinggi dan kemampuan menyusun strategi agar hasil pokok penggunaan waktu dapat tercapai secara maksimal.

3. Menyusun Jadwal

Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Fungsi pembuatan jadwal adalah menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Jadwal kegiatan harian, mingguan, dan bulanan dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2.

**Tabel 7.1 Jadwal Kerja Harian Kepala Ruangan**

| Waktu      | Kegiatan                                                                                                                                                              | Keterangan |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 07.00 WIB  | Menghitung kebutuhan tenaga perawat pada setiap <i>shift</i>                                                                                                          |            |
| 07. 10 WIB | Melakukan Operan, <i>Pre conference</i> (antara tim 1 & tim 2), mengecek SDM dan sarana prasarana.                                                                    |            |
| 08.00 WIB  | Mengecek kebutuhan pasien (pemeriksaan, kondisi dll)                                                                                                                  |            |
| 09.00 WIB  | Melakukan interaksi dengan pasien baru atau pasien yang memerlukan perhatian khusus.                                                                                  |            |
| 10.00 WIB  | Melakukan supervisi pada ketua tim/perawatan pelaksana                                                                                                                |            |
| 11.00 WIB  | <i>Meeting</i> dengan unit terkait                                                                                                                                    |            |
| 12.00 WIB  | Menegecek ulang keadaan pasien, perawat, lingkungan yang belum teratasi                                                                                               |            |
| 13.00 WIB  | Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan asuhan keperawatan untuk sore, malam, dan esok hari sesuai tingkat ketergantungan pasien mengobservasi <i>post conference</i> |            |
| 14.00 WIB  | Operan                                                                                                                                                                |            |

**Tabel 7.2 Jadwal kegiatan Minggu Kepala Ruangan**

| Hari   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Senin  | Membuat jadwal supervisi dan bimbingan bagi perawat ketua tim dan perawat pelaksana secara individual sesuai kebutuhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Selasa | Melaksanakan supervisi dan bimbingan perawat ketua tim dan perawat pelaksanaan secara individu sesuai kebutuhan (termasuk umpan balik: pujian, teguran) serta mendokumentasikannya pada buku harian karu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Rabu   | Melaksanakan pertemuan mingguan/bulanan: 1) Mengidentifikasi masalah prioritas ruangan serta pemecahan masalahnya. 2) Menggali ide-ide kreatif staf. 3) Mengingatkan kembali Visi dan misi RS, dan membahas hal-hal operasional yang dilakukan, misalnya sebelum rapat bulanan anjuran 3 orang perawat menuliskan tindakan konkrit dan jelas tentang VISI dan MISI RS. 4) Menyepakati cara-cara pencegahan konflik diantara staf. 5) Mengidentifikasi jumlah komplain di ruangan dan menyepakati cara-cara pemecahan. |            |
| Kamis  | <i>Memfollow up</i> dan memonitor keadaan ruangan melalui telephon pada sore atau malam hari secara periodik, misalnya setiap minggu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Jumat  | 1.Melaksanakan diskusi kasus untuk melihat hal-hal positif dan hal-hal negatif yang dilakukan kepada pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | 2. Mengevaluasi mutu asuhan keperawatan dengan menggunakan kuensioner kepuasan pasien dan keluarga serta menilai kelegkapan dokumentasi asuhan keperawatan pasien.                                                                                             |  |
| Sabtu  | Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan belajar dan pengembangan ketua tim atau perawat pelaksana Melakukan rode keperawatan setiap 2 minggu dan mendiskusiakan isu pada waktu rode antara lain: dokumentasi asuhan keperawatan, SDM (kehadiran, disiplin) |  |
| Minggu | Membuat program menjaga mutu yang spesifik/prioritas untuk setiap ruangan                                                                                                                                                                                      |  |

#### 4. Bersikap Asertif

Aspek manajemen waktu ini diartikan sebagai ekspresi bertanggungjawab dari perasaan dan pikiran seseorang terhadap orang tertentu pada waktu yang tepat. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata "Tidak" atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif.

#### 5. Bersikap tegas

Merupakan strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu. Dalam bersikap asertif tetap dibutuhkan pertimbangan matang dari segi konsekuensi atau besar kecilnya dampak positif dan negatif yang diterima individu.

#### 6. Menghindari Penundaan

Penundaan merupakan penangguhan suatu hal hingga terlambat dikerjakan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara apik serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Meminimalkan Waktu yang Terbuang. Pemborosan waktu mencakup segala kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut sering menjadi penghalang bagi individu untuk mencapai keberhasilannya karena sering membuat individu menunda melakukan kegiatan yang penting.

#### 7. Prinsip Manajemen Waktu

Pengelola waktu yang tepat, maka diperlukan penetapan prinsip-prinsip dasar manajemen waktu agar lebih berhasil dan berdaya guna. Adapun prinsip dasar manajemen waktu adalah sebagai berikut: (Nayak, 2018)

- Sediakan waktu untuk perencanaan dan menetapkan prioritas
- Selesaikan tugas berprioritas tinggi sesegera mungkin dan tuntaskan tugas sebelum mulai tugas yang lain.

- c. Prioritaskan kembali tugas yang tersisa berdasarkan informasi baru yang terkait.

Menurut International Journal of Caring Sciences, manajemen waktu yang efektif dalam keperawatan dapat menghasilkan:

- a. Produktivitas yang lebih besar
- b. Mengurangi stres
- c. Peningkatan efisiensi
- d. Lebih banyak peluang untuk kemajuan profesional
- e. Kesempatan yang lebih besar untuk mencapai karir dan tujuan hidup

Produktifitas waktu dapat dicapai dengan:

- a. Tetapkan Tujuan yang Dapat Dicapai

Langkah pertama yang harus diambil perawat untuk meningkatkan produktivitas adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Menurut peneliti perawatan kesehatan, kesalahan umum adalah "membiarkan tujuan jangka panjang didominasi oleh tuntutan waktu jangka pendek yang lebih cepat dan mendesak."

Perawat didorong untuk menetapkan tujuan karir yang dapat dicapai dalam satu hingga tiga tahun (mis. menyelesaikan pendidikan tinggi) saat mereka bekerja menuju tujuan jangka panjang yang dapat diselesaikan dalam lima hingga 10 tahun (mis. menempati posisi kepemimpinan atau direktur klinis).

Perawat yang bekerja atau mahasiswa keperawatan juga dapat menuliskan tugas sehari-hari berdasarkan prioritas yang mereka rasakan. Sasaran harian lebih cenderung berubah sepanjang hari, tetapi prosedur tertentu tetap konstan untuk perawat dan dapat diperkuat dengan rutinitas.

- b. Menerapkan Rutinisasi

Rutinisasi adalah alat yang membantu perawat memaksimalkan efisiensi waktu. Rutinisasi melibatkan "mengulangi apa yang berhasil dalam rutinitas dalam proses yang sistematis sehingga konsistensi membantu manajemen waktu." Menciptakan rutinitas yang konsisten meningkatkan manajemen waktu dalam keperawatan dengan menghilangkan perencanaan yang tidak perlu dan mengubah tugas penting menjadi kebiasaan. Rutinitas setiap hari mulai jam dinas dan kegiatan selama shift diatur sedikitan rupa supaya rencana kegiatan harian terlaksana dengan baik. Rutinisasi dirancang untuk tanggung jawab harian yang diperlukan, mulai dari mengumpulkan riwayat kesehatan pasien hingga melakukan pemeriksaan fisik. Seorang perawat harus membuat daftar tugas rutin dan mengurutkan setiap tugas berdasarkan durasi dan prioritas setiap item. Menerapkan proses langkah demi langkah untuk tugas rutin dapat menghemat waktu setiap hari.

c. Mulai Penumpukan Kognitif

Membuat rutinitas untuk mengelola tanggung jawab yang dapat diprediksi adalah solusi yang jelas, tetapi bagaimana perawat dapat mengelola tugas yang tidak dapat diprediksi dan perubahan yang tidak dapat diprediksi? Menurut Pusat Perawatan Lippincott, penumpukan kognitif adalah "proses manajemen alur kerja yang membantu perawat menetapkan prioritas dan mengatur waktu mereka."

Manajemen waktu dalam keperawatan membutuhkan manajemen perubahan yang dinamis. Perawat yang bekerja dapat terlibat dalam penumpukan kognitif dengan menentukan tingkat perawatan apa yang diperlukan, perawatan apa yang mungkin dan bagaimana mereka dapat memberikan perawatan yang diperlukan dengan sumber daya dan waktu yang tersedia. Perawat diminta untuk terus mengatur ulang tugas-tugas sebagai item prioritas yang lebih tinggi muncul.

d. Luangkan Waktu untuk Istirahat

Kejenuhan terkait pekerjaan adalah risiko umum di antara petugas kesehatan. Sebuah publikasi baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 15% perawat yang diwawancarai melaporkan perasaan kelelahan dan 56% perawat yang diwawancarai mengatakan fasilitas perawatan kesehatan mereka sedikit atau sangat tidak efektif dalam menangani kelelahan. Kelelahan juga dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti: Mengurangi kualitas perawatan pasien, Menurunnya kualitas kesehatan mental di kalangan petugas kesehatan, peningkatan depresi dan kecemasan. Manajemen waktu dalam keperawatan tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan produktivitas, tapi meluangkan waktu untuk istirahat dan merilekskan tubuh. Perawat harus beristirahat secara teratur dan memprioritaskan waktu istirahat untuk mencegah kelelahan terkait pekerjaan.

e. Delegasikan Pekerjaan

Setelah mengoptimalkan manajemen waktu dalam keperawatan, perawat masih meminta bantuan dan mengandalkan jaringan kolaboratif petugas kesehatan. The American Nurses Association (ANA) merilis panduan tentang prinsip-prinsip delegasi untuk membantu manajemen waktu dalam keperawatan. Menurut panduan tersebut, pendelegasian dalam keperawatan adalah "penugasan kinerja kegiatan atau tugas yang berkaitan dengan perawatan pasien kepada tenaga bantuan tanpa izin sambil tetap mempertahankan akuntabilitas untuk hasilnya."((ANA), 2010)

Panduan ini menginstruksikan perawat tentang bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang pendelegasian tanggung jawab



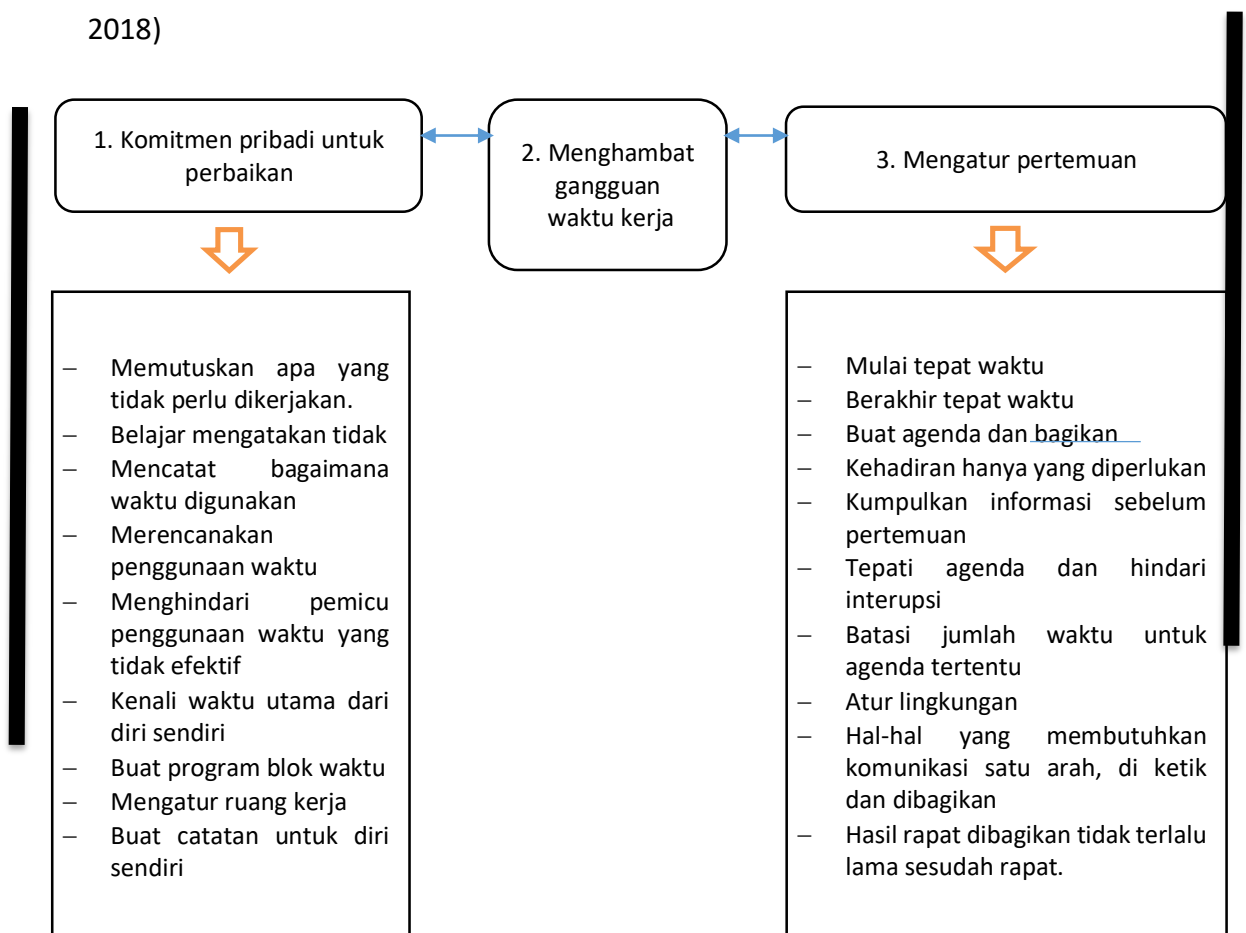
keperawatan. ANA mengatakan bahwa keputusan perawat untuk mendelegasikan harus didasarkan pada hal berikut:

- 1) Kompleksitas perawatan pasien
- 2) Ketersediaan pekerja yang menerima delegasi
- 3) Jenis pengawasan yang diperlukan
- 4) Intensitas pengawasan yang diperlukan

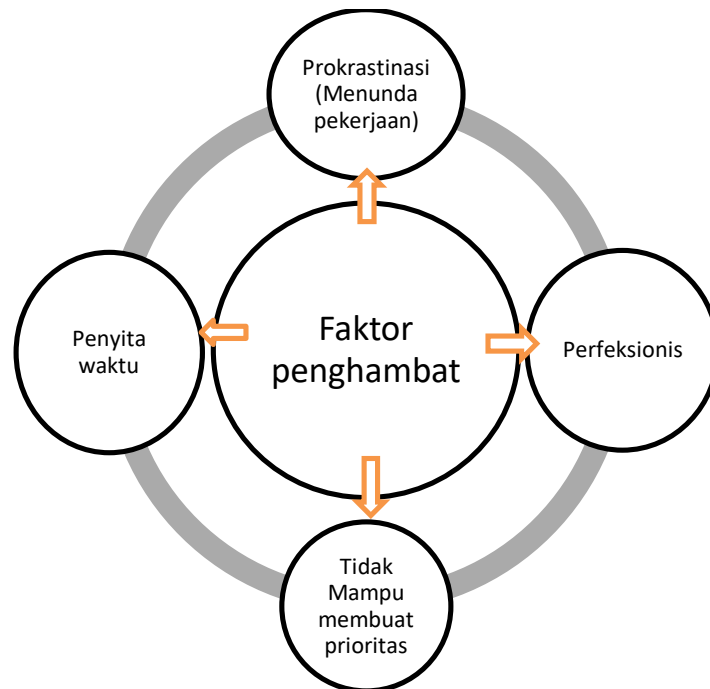
Delegasi bekerja paling baik ketika petugas kesehatan memiliki hubungan kerja yang positif, kemampuan untuk berkolaborasi dan menggunakan komunikasi terbuka. Pendelegasian tidak boleh digunakan ketika keputusan keperawatan harus dibuat oleh RN berlisensi. Alat untuk manajemen waktu yang lebih baik dalam keperawatan ini dapat digunakan untuk tugas administratif atau prosedur rutin daripada tanggung jawab keperawatan yang mengandalkan pelatihan kritis.(Fkep et al., 2021), (Osterweil et al., 2010), (Yusuf, 2013).

#### 8. Metode Mengelola Waktu

Adapun metode mengelola waktu secara efektif adalah: (R. Dewi & Maigeni, 2018)



## 9. Faktor Penghambat Manajemen Waktu Efektif



Bagan 7.3 Faktor penghambat manajemen waktu

Berdasarkan bagan 7.3 faktor penghambat manajemen waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prokrastinasi (Menunda pekerjaan)  
Bentuk kegagalan pengaturan diri yang ditandai dengan penundaan pekerjaan, meskipun ada konsekuensi yang berpotensi negatif.
- b. Perfeksionis  
perfeksionis adalah orang-orang yang telah menetapkan standar tinggi terhadap kinerja dan kepribadian mereka. Berdasarkan hal tersebut, orang-orang yang memiliki sifat ini sering berpikir bahwa apapun yang mereka lakukan tidak pernah memuaskan. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka, meskipun sudah waktunya untuk rehat.
- c. Tidak Mampu membuat prioritas  
Tidak bisa 'memboboti' / menilai pekerjaan: lama, urgensi (segera atau nanti) dan berat ringannya pekerjaan. Tidak bisa menyusun berbagai pekerjaan secara sistematis
- d. Penyita waktu  
Disamping faktor penghambat, manajemen waktu efektif juga dapat berhubungan dengan penghabisan atau 'penyitaan' waktu yang dapat

menghambat produktifitas kerja. ‘Penyita’ waktu dapat terjadi secara internal maupun eksternal. (I. P. Dewi, 2014).

#### 10. Analisa Situasi

Analisis waktu adalah merupakan prasyarat bagi seseorang dalam pengelolaan waktu Dasar dari analisis waktu dibuat biasanya dalam berbentuk catatan waktu (log) dimana kegiatan individu dicatat lengkap dengan waktunya. (Febriati, 2017)

#### 11. Prioritas Masalah

Dream warriors, menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan supaya tidak stress dan dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan menyusun skala prioritas.

Ada sebuah teknik manajemen yang disebut Eisenhower Decision Matrix, yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik, dengan memisahkan hal-hal yang dilakukan ke dalam empat buah kategori sebagai berikut: (Bimrew Sendekie Belay, 2022)

| <u>Eisenhower Decision Matrix</u> | Urgent/Mendesak                    | Not Urgent/<br>Tidak Mendesak        |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Important/Penting                 | Do<br>Do it now                    | Decide<br>Schedule a time to do it.  |
| Not Important/ Tidak Penting      | Delegate<br>Who can do it for you? | Delete (if possible)<br>Eliminate it |

#### Kuadran 1: Penting dan Mendesak

Kuatran 1 yang di masukan hal-hal yang sangat penting dan wajib diselesaikan hari itu juga. Memasukkan terlalu banyak pekerjaan ke dalam Kuadran satu akan membuat pekerjaan tidak produktif.

Menentukan skala prioritas, fokus pada pekerjaan yang paling mendesak dan paling penting. Biasakan ditinjau kembali *list* yang sudah dibuat dan mempertimbangkan ulang mana saja pekerjaan yang paling mendesak di antara pekerjaan mendesak lainnya. Dengan menyelesaikan hal yang paling benar-benar harus diselesaikan terlebih dahulu, pekerjaan mendesak lainnya akan lebih ringan untuk diselesaikan.

#### Kuadran 2: Penting namun Tidak Mendesak

Kuadran 2 ini dengan memasukkan tugas dan pekerjaan yang penting dan dapat diansur secara bertahap. Walaupun tidak mendesak, namun tetap harus menentukan target penyelesaian agar pekerjaan ini bisa berjalan sesuai rencana. Hal yang harus diwaspadai adalah budaya menunda-nunda waktu. Proses

mengansur dalam pekerjaan yang tidak mendesak sangat penting agar tidak keteteran ketika tenggang waktu sudah dekat.

#### Kuadran 3: Mendesak namun Tidak Penting

Kuadran 3 berisi hal-hal yang tidak penting namun tetap harus dikerjakan. Contohnya adalah *follow up* jadwal rapat lewat telepon atau email, diskusi dengan rekan kerja, dilihat juga pekerjaan tersebut bisa didelegasikan atau tidak. Kalau tidak bisa didelegasikan, bisa melakukan hal-hal yang masuk di kategori pekerjaan Kuadran 3, hanya jika memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan yang penting dan utama, serta waktunya disesuaikan dengan kapasitas waktu dan pekerjaan.

#### Kuadran 4: Tidak Penting dan Tidak Mendesak

Sekali terjebak berlama-lama ada di dalam kegiatan Kuadran 4. Main media sosial di tengah waktu pekerjaan, kumpul berlama-lama dengan teman hanya untuk bergosip, sibuk depan *smartphone* tanpa tujuan yang jelas. Kalau berada dalam kegiatan ini, segera hentikan dan buat skala prioritas pekerjaan.

### 12. Evaluasi

Evaluasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang prioritas dengan hasil lebih maksimal dan sesuai dengan keperluan memberikan asuhan keperawatan yang holistik dalam memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Prioritas pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan memberikan gambaran kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- (ANA), A. N. A. (2010). *Nursing: Scope and standards of practice* ((2nd ed.)). Silver Spring, MD: Nursesbooks.org.
- Aditama, R.A. (2020). Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi. Malang: AE Publishing.
- Arini. T (2018). Budaya Keselamatan Pasien dengan Pemberdayaan dan Kepuasan Kerja. (Tesis Universitas Airlangga).
- Astari, R.Y. (2010). Mutu Pelayanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Yogyakarta: Budi Utama.
- Aziz, A., & Hidayat, A. (2019). by Abdul Aziz Alimul Hidayat.
- Baroto, T., Purbohadiningrat, C. (2014). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis PPOB KIPO Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM. *Jurnal Teknik Industri*, 15(1), 88–102
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). *The Eisenhower Box* (Issue 8.5.2017, pp. 2003–2005).
- David. F. R (2011). *Strategic Management*, Manajemen Strategis, Konsep (Palupi Wuriarti, Ed.; 12th ed.). Salemba Empat.
- Depkes (2019) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI.
- Depkes. (2008). Pedoman indikator mutu pelayanan keperawatan klinik di sarana kesehatan.
- Dewi, I. P. (2014). *Relationship Between Knowledge, Attitude and Time Management Of Nurses With Nursing Documentation*. 1(6).
- Dewi, R., & Maigeni, M. (2018). Lama Masa Kerja Dan Manajemen Waktu Dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan. *Real in Nursing Journal*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.32883/rnj.v1i1.227>
- Erita. (2019). Buku Materi Pembelajaran Manajemen Keperawatan. Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional Edisi 4, 117.
- Ernawati. (2010). Hubungan Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Dengan Komite Keperawatan Di RSUD Dr. Soedarso Pontianak. (Tesis Universitas Indonesia)
- Febriati, N. S. (2017). Analisis Manajemen Waktu Belajar Siswa Kelas VIII di Smp Negeri 10 Palembang.
- Fkep, J. I. M., No, V. V, Yusuf, M., & Sofia, J. (2021). Manajemen Waktu Perawat Pelaksana Dalam Pemberian *Time Management of Implementing Nurses in Providing*. V(3), 118–126.

- Ginting, D. and Harahap, Y. W. (2019) 'Hubungan Kemampuan Supervisi Kepala Ruang Dengan Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan', *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*, 1(2). doi: 10.35451/jkf.v1i2.162.
- Habibi, A. H., Hakim, F. H., & Azizi, F. S. (2020). Hubungan Mutu Pelayanan Keperawatan dengan Minat Kunjungan Ulang Rawat Jalan di RSIA PKU Muhammadiyah Cipondoh. *Jurnal JKFT*, 4(2), 11–21.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidaya, N., Alfianur, Handayani, F. (2020). *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan*. Bogor: Adab.
- Hidayat, R Dede. 2009. *Ilmu Prilaku Manusia Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta : Trans Info Media
- I Gusti Ngurah Alit Wiswasta, dan I Gusti Ayu Ari Agung, dan I Made Tamba. (2018). Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, Dan Pengembangan Usaha) (I Ketut Sumantra, Ed.; 1st ed.). Universitas Mahasaraswati Press.
- Ilyas, Y. 2001. *Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian)*, Cetakan Pertama, Jakarta : FKM UI
- Irwanto. 2010. *Prilaku Manusia*. Jakarta : Avisiena.
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. [www.http//bprs.kemkes.go-id](http://bprs.kemkes.go-id)
- Kurniasih, et.al (2021). *Teknik Analisa* (1st ed.). cv, Alfabeta. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Liu, J. ying, Liu, Y. hui, & Yang, J. peng. (2014). *Impact of learning adaptability and time management disposition on study engagement among Chinese baccalaureate nursing students*. *Journal of Professional Nursing*, 30(6), 502–510. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2014.05.002>
- Lusianah, (2008). Hubungan Motivasi Dan Supervisi Dengan Kualitas Dokumentasi Proses Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Marinir Cilandak. (Tesis Universitas Indonesia).
- Lutfi Fauji Ridwan. 2015. Pengaruh MOTivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap kinerja perawat. <https://pustaka.unpad.ac.id>
- Mandias, R.J. dkk. (2021). *Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Marquis, B. L. and Huston, C. J. (2017) *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application, Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application*. doi: 10.1097/00006216-200407000-00013.

- Marquis, B.L., dan C. J. H. (2015). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing*:
- Mathis, R dan Jackson, W. 2006. *Human Resources Development*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Morrissey, J. (2020) *Training supervision : Professional and ethical considerations, The Handbook of Professional, Ethical and Research Practice for Psychologists, Counsellors, Psychotherapists and Psychiatrists*.
- Muchlis, L., Lilianti Sjattar, E., Andi Makkasau, R., Keperawatan Fak Kedokteran Universitas Hasanuddin Alamat Koresponden, B., Muchlis Makassar, L., & Selatan Jl, S. (2013). Hubungan Prinsip Manajemen Waktu Dengan Produktivitas Kerja Kepala Ruangan Melalui Persepsi Perawat Di Rsud Andi Makassar Parepare Relationship Between the Principle of Time Management and Work Productivity of Room Chief Through Nurses' Perception in Andi.
- Munandar, A., Rasyidin, & Baharuddin. (2020). Pengaruh Manajemen Waktu dan Kompensasi terhadap Asuhan Keperawatan Melalui Motivasi Kerja Perawat di ruang Perawatan RSUD Daya Kota Makassar. *Journal STIEAMKOP*, 3(2), 22–35. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume>
- Muryani. (2019). Upaya Optimalisasi MPKP Model Tim Dalam Meningkatkan Kinerja Perawat. (Tesis Universitas Airlangga).
- Nayak, S. G. (2018). *Time Management in Nursing-Hour of Need*. *International Journal of Caring Sciences*, 11(3), 1997–2000. [www.internationaljournalofcaringsciences.org](http://www.internationaljournalofcaringsciences.org)
- Nungki. 2007. Disiplin Kerja Ditinjau dari Semangat Kerja Karyawan Laki-laki. Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Psikologi USM. Tidak dipublikasikan.
- Nursalam (2011) *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional Edisi 3*, Salemba Medika.
- Nursalam. (2014). *Manajemen Keperawatan: Konsep Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. (Edisi 4). Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. 2002. *Manajemen Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Nursalam. 2015. *Manajemen Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Osterweil, D., Osterweil, D., Hickey, K. A., & Hulz, B. (2010). *The Nursing Home Visit: An Exercise in Time Management*. *Journal of the American Medical Directors Association*, 11(3), B24. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2009.12.070>
- Pangemanan, E. J., Robot, F. J. M., & Hamel, R. S. (2014). Hubungan Manajemen Waktu Dengan Produktivitas Kerja Perawat Pelaksana Di IRINA A RSUP Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO. *Jurnal Keperawatan*, 2(2), 1–7.



- Philip Kotler, et.al (2009). Manajemen Pemasaran. In Jakarta : Indeks.
- Pranata, L. dkk. (2021). Manajemen Keperawatan: Kualitas Pelayanan Keperawatan. Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Pratiwi, M. (2019). Merencanakan, Dan Mempengaruhi Upaya Menggerakkan Perawat Dalam Lingkup Wewangnya. *Scientia Journal*, 8(1), 48–57.
- Rahayu, D.S. (2020). Meningkatkan Kualitas Discharge Planning melalui Coaching Keperawatan. Batu: Literasi Nusantara.
- Reschke, D. J. et al. (2021) 'Group clinical supervision for nurses: Process, group cohesion and facilitator effect', *Australian Journal of Advanced Nursing*, 38(3). doi: 10.37464/2020.383.221.
- Richard J. Swansburg, R. C. S. (2006) *Management and Leadership for Nurse Administrators*. Edited by R. C. S. Linda Roussel, Richard J. Swansburg. Available at: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=I201jFBjt1YC&oi=fnd&pg=PR17&dq=swansburg+management+and+leadership&ots=U-ARuyv4S9&sig=zqfohMg5wJV7H2iIVB4obgRWX9A&redir\\_esc=y#v=onepage&q=swansburg+management+and+leadership&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=I201jFBjt1YC&oi=fnd&pg=PR17&dq=swansburg+management+and+leadership&ots=U-ARuyv4S9&sig=zqfohMg5wJV7H2iIVB4obgRWX9A&redir_esc=y#v=onepage&q=swansburg+management+and+leadership&f=false).
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi edisi kedepuluh*. alih bahasa. Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia.
- Rocha, I. A. da R. E. S., Pinto, C. M. C. B. and Carvalho, A. L. R. F. de (2021) '*Impact of clinical supervision on job satisfaction and emotional competence of nurses*', *Revista brasileira de enfermagem*, 74(6). doi: 10.1590/0034-7167-2021-0125.
- Sayuti. 2007. *Motivasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Septika, M. (2018). *Konsep Dasar Pemberian Obat untuk Bidan*. (Edisi 1). Cilacap: Stikes Al Islamiyyah.
- Sesrianty, V., Machmud, R., & Yeni, F. (2019). Analisa Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 6(2), 116–126. <https://doi.org/10.33653/jkp.v6i2.317>
- Setiadi (2016) '*Manajemen Dan Kepemimpinan dalam Keperawatan*', Indomedia Pustaka.
- Shodiqurrahman, R. dkk. (2022). *Keperawatan Kegawatdaruratan dan Keperawatan Kritis*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Siregar, D. dkk. (2021). Pengantar Proses Keperawatan: Konsep, Teori dan Aplikasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, H.K. dkk. (2022). Ilmu Keperawatan Dasa. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sri Mugiarti. (2016). Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Praktik Keperawatan. In Book (Vol. 4, Issue 1).
- Steven R. Steiber, & William J. Krowinski. (1990). Measuring and Managing Patient Satisfact. American Hospital Pub.
- Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto. 2008. Mengenal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di Rumah Sakit. Jogjakarta : Mitra Cendekia.
- Syafutri, Mella. 2012. Analisis Karakteristik Individu Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dibagian RSUP Fatmawati Depok. Fakultas Kesehatan Masarakat Universitas Indonesia.
- Taufik Hidayat. (2009). Aspek-Aspek Manajemen Keperawatan Yang Berpengaruh Terhadap Kompetensi Interpersonal Perawat Di Rawat Inap RSUD BRIGJEN H.Hassan Basri Kandungan Kalimantan Selatan. (Tesis Universitas Diponegoro)
- Triwibowo, C. (2013). Manajemen Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit. Jakarta: TIM.
- Umar, Husein. (2019). *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-undang. (2014). Undang-undang Republik Indonesia nomer 38 tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia, 1–32.
- Usman Husaini. 2013. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidkan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wardhana. A ,. et.al (2021). Manajemen Strategik (Harini Fajar Ningrum, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Wardoyo, P.M. (2011). Enam Alat Analisis Manajemen (ed.Pertama). Semarang University Press.
- Widayatun, T.R. (1999). Ilmu Prilaku, Jakarta : PT Fajar Interpratama.
- Widiyarini., Hunusalela, Z.F. (2019). Perencanaan Strategi Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM dalam Upaya Peningkatan Penjualan PT Prima Vista Solusi. Journal of Applied Business and Economic, 5(4), 384-397

- Winasari, S., Utami, Y.W., Susanto, A.H., Dewi, E.S. (2021). Keperawatan Dasar: Dasar-dasar untuk Praktik Keperawatan Profesional. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wursanto. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf, M. (2013). Hubungan Manajemen Waktu Perawat Pelaksana Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Tahun 2013. Jurnal Ilmu Keperawatan ISSN: 2338-6371 Muhamad, 1(1), 76–84.

## SINOPSIS

Manajemen Keperawatan mempunyai beberapa fungsi manajemen yang terkait dengan pengelolaan pelayanan keperawatan. Oleh karena itu diperlukan acuan aplikasi manajemen keperawatan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Acuan ini disusun dalam bentuk Buku Aplikasi Manajemen Keperawatan dalam Praktik Keperawatan. yang memerlukan aplikasi dalam praktik keperawatan.

Buku ini dapat digunakan baik pada area pendidikan keperawatan maupun pelayanan keperawatan. Pada area pendidikan keperawatan dapat dijadikan acuan saat mahasiswa melaksanakan Praktik di Institusi Pelayanan Keperawatan sedangkan pada area pelayanan keperawatan dapat dijadikan acuan bagi pengelola pelayanan keperawatan baik tingkatan manajemen lini, menengah maupun top manajemen.

Isi Buku ini mencakup hasil pemikiran penulis berdasarkan beberapa referensi baik berupa teori maupun kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam aplikasi manajemen keperawatan dalam praktik keperawatan. Adapun isi dari Buku ini meliputi materi yang terkait dengan Analisis SWOT, Klasifikasi Klien berdasarkan Tingkat Ketergantungan, Jenjang Karir Perawat, Supervisi dalam Keperawatan, Motivasi Kerja Perawat, Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan dan Manajemen Waktu Sistematisa penulisan materi meliputi Pendahuluan, Definisi, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Faktor-faktor yang mempengaruhi, Analisis Situasi, Prioritas Masalah, Alternatif Solusi, *Plan of Action*, Implementasi dan Evaluasi

Manajemen Keperawatan mempunyai beberapa fungsi manajemen yang terkait dengan pengelolaan pelayanan keperawatan. Oleh karena itu diperlukan acuan aplikasi manajemen keperawatan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Acuan ini disusun dalam bentuk Buku Chapter Aplikasi Manajemen Keperawatan dalam Praktik Keperawatan. yang memerlukan aplikasi dalam praktik keperawatan.

Buku Chapter ini dapat digunakan baik pada area pendidikan keperawatan maupun pelayanan keperawatan. Pada area pendidikan keperawatan dapat dijadikan acuan saat mahasiswa melaksanakan Praktik di Institusi Pelayanan Keperawatan sedangkan pada area pelayanan keperawatan dapat dijadikan acuan bagi pengelola pelayanan keperawatan baik tingkatan manajemen lini, menengah maupun top manajemen.

Isi Buku Chapter ini mencakup hasil pemikiran penulis berdasarkan beberapa referensi baik berupa teori maupun kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam aplikasi manajemen keperawatan dalam praktik keperawatan. Adapun isi dari Buku Chapter ini meliputi materi yang terkait dengan Analisis SWOT, Klasifikasi Klien berdasarkan Tingkat Ketergantungan, Jenjang Karir Perawat, Supervisi dalam Keperawatan, Motivasi Kerja Perawat, Manajemen Mutu Pelayanan Keperawatan dan Manajemen Waktu Sistematisa penulisan materi meliputi Pendahuluan, Definisi, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Faktor-faktor yang mempengaruhi, Analisis Situasi, Prioritas Masalah, Alternatif Solusi, Plan of Action, Implementasi dan Evaluasi

Penerbit :  
PT Nuansa Fajar Cemerlang  
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F  
Jalan S. Parman Kav. 22-24  
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah  
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480  
Telp: (021) 29866919



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

**Anggota IKAPI**  
**No. 624/DKI/2022**

ISBN 978-623-88564-5-9



9 786238 856459